Estilo UERJ

Simulado 2
Resolução

Gabarito, a armadilha de cada questão, o dado que decide e o raciocínio completo, alternativa por alternativa.

80 questões

15 de outubro de 2026

ANTES DE CORRIGIR

Como usar esta resolução

Corrija olhando primeiro a coluna da arma. O que interessa não é o total de acertos, é em qual armadilha você caiu.

ARMA DA BANCA	O QUE FAZ	QUESTÕES	ONDE ESTÃO
Rótulo verdadeiro	um dado real do paciente puxa para a doença de manual errada	25	1, 4, 14, 18, 26, 28, 30, 34, 41, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 66, 69, 71, 72, 74, 77, 78
Negativo no meio	o discriminante é um dado negativo no meio do caso	8	8, 23, 35, 39, 40, 43, 60, 62
Dado omitido	o achado mais famoso foi retirado	2	17, 31
Droga a deduzir	a droga em uso não é nomeada	3	12, 56, 58
Grade X / Y	alternativa composta em que uma metade não basta	16	5, 9, 10, 13, 16, 19, 22, 29, 36, 37, 42, 44, 52, 65, 68, 70
Qualificador	o comando restringe o que se pede	1	6
Limiar	um ponto de corte ou janela decide	10	2, 21, 24, 25, 32, 33, 46, 67, 73, 80
Omissão	a resposta certa é não fazer, ou o degrau mais simples	10	3, 7, 15, 45, 48, 54, 64, 75, 76, 79
Cronologia	o tempo entre os eventos decide	5	11, 20, 27, 38, 50

O que cada arma treina em você

- **Rótulo verdadeiro, negativo no meio, dado omitido:** a leitura em modo confirmação, a sua maior causa de erro de identificação.
- **Grade X / Y e qualificador:** a alternativa aceita pela metade e o comando lido pela metade.
- **Limiar, cronologia e omissão:** a regra aplicada sem checar a condição que a habilita, e o exame ou tratamento a mais, o seu padrão dominante em 15/10/2026.
- **Droga a deduzir:** a droga em uso que decide e não vem nomeada.

Todas as questões têm uma única alternativa defensável pela diretriz citada. Se discordar de alguma, anote: discutir o gabarito é o melhor treino.

GABARITO

Respostas

1 **A**	2 **D**	3 **B**	4 **B**	5 **D**	6 **A**	7 **D**	8 **D**	9 **A**	10 **A**
11 **C**	12 **D**	13 **D**	14 **C**	15 **D**	16 **C**	17 **D**	18 **A**	19 **B**	20 **B**
21 **B**	22 **D**	23 **D**	24 **A**	25 **A**	26 **B**	27 **B**	28 **B**	29 **B**	30 **A**
31 **D**	32 **B**	33 **B**	34 **A**	35 **A**	36 **B**	37 **A**	38 **B**	39 **A**	40 **A**
41 **C**	42 **B**	43 **C**	44 **D**	45 **D**	46 **B**	47 **C**	48 **C**	49 **A**	50 **A**
51 **C**	52 **D**	53 **A**	54 **B**	55 **C**	56 **A**	57 **C**	58 **D**	59 **C**	60 **C**
61 **D**	62 **C**	63 **C**	64 **A**	65 **A**	66 **B**	67 **C**	68 **C**	69 **D**	70 **B**
71 **C**	72 **A**	73 **B**	74 **C**	75 **C**	76 **B**	77 **D**	78 **B**	79 **A**	80 **D**

A cor ao lado de cada letra é a da arma da banca, como na tabela anterior. Distribuição: A 21, B 21, C 19, D 19.

RESOLUÇÃO

Questão por questão

1 Infectologia · Endocardite de prótese precoce: o agente que define o empírico apesar da extração dentária

Rótulo verdadeiro **Gabarito A**

Mulher de 67 anos, submetida há 7 semanas a troca valvar aórtica por prótese biológica, procura o pronto-socorro por febre de 38,5 °C há 10 dias, calafrios e astenia. No pós-operatório teve deiscência superficial da ferida esternal, tratada com curativos. Há 3 semanas fez extração de dois molares, sem antibiótico profilático. Nega uso recente de antibióticos. Exame: T 38,4 °C, FC 102 bpm, PA 112 × 70 mmHg, ferida esternal cicatrizada, sopro sistólico ejetivo 2+/6 em foco aórtico e sopro diastólico aspirativo novo em borda esternal esquerda; sem petéquias ou esplenomegalia. Três pares de hemoculturas colhidos, ainda sem crescimento. Ecocardiograma transesofágico: abscesso perivalvar aórtico e regurgitação paraprotética moderada. Enquanto se aguarda a identificação, o agente mais provável e que deve orientar o esquema empírico é:

O DADO QUE DECIDE

submetida há 7 semanas a troca valvar aórtica por prótese biológica

Resolução. A extração dentária sem profilaxia é verdadeira e puxa para o estreptococo viridans, o agente de manual da endocardite após procedimento dentário. Mas o dado que manda é o tempo de prótese: endocardite de prótese nos primeiros 2 meses (e, em geral, até 1 ano) é infecção de origem perioperatória, dominada por estafilococo coagulase-negativo e S. aureus, com gram-negativos e fungos atrás. A deiscência esternal reforça a contaminação perioperatória, e o abscesso perivalvar é a complicação esperada dos estafilococos. Por isso o empírico da endocardite de prótese precoce é vancomicina com gentamicina e rifampicina (esta acrescentada após 3 a 5 dias, quando as hemoculturas negativarem), e não ceftriaxona ou penicilina. O abscesso também já indica avaliação cirúrgica.

A) Estafilococo coagulase-negativo CORRETA
Correta. Prótese há 7 semanas com deiscência esternal e abscesso perivalvar: estafilococo coagulase-negativo é o agente mais provável da endocardite de prótese precoce.

B) Estreptococo do grupo viridans ARMADILHA
Errada. É a armadilha: seria o agente na endocardite de valva nativa ou de prótese tardia após extração dentária; a prótese de 7 semanas desloca a etiologia para os estafilococos.

C) Enterococcus faecalis
Errada. Enterococo predomina após manipulação urinária ou digestiva em idosos, sem relação com o pós-operatório recente e sem esse dado na história.

D) Bactéria do grupo HACEK
Errada. HACEK é causa de endocardite com hemocultura de crescimento lento em valva nativa, rara na prótese precoce e sem relação com a cirurgia.

Para levar. Endocardite em prótese com menos de 1 ano (sobretudo menos de 2 meses) é estafilocócica até prova em contrário, mesmo com procedimento dentário recente: empírico com vancomicina, gentamicina e rifampicina.

ESC Guidelines for the management of endocarditis (2023); AHA Scientific Statement on Infective Endocarditis in Adults (2015).

---

2 Oncologia · Neutropenia febril de baixo risco pelo MASCC: antibiótico oral ambulatorial

Limiar **Gabarito D**

Mulher de 49 anos, em quimioterapia adjuvante para carcinoma de mama (docetaxel e ciclofosfamida, último ciclo há 9 dias, sem profilaxia antimicrobiana), procura o pronto-atendimento com febre de 38,4 °C iniciada em casa há 6 horas. Refere mal-estar leve; sem tosse, disúria, diarreia ou dor. Não tem DPOC, nunca teve infecção fúngica e não está desidratada. Exame: bom estado geral, PA 122 × 78 mmHg, FC 96 bpm, FR 16 irpm, SpO2 98% em ar ambiente, sem foco infeccioso, cateter totalmente implantado sem sinais flogísticos. Exames: neutrófilos 380/mm³, creatinina 0,7 mg/dL, bilirrubinas e transaminases normais, lactato 1,1 mmol/L; radiografia de tórax e urina tipo 1 normais. Mora a 15 minutos do hospital, com acompanhante e telefone. Colhidas as hemoculturas, a conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

Não tem DPOC, nunca teve infecção fúngica e não está desidratada

Resolução. Neutropenia febril assusta e puxa para internação com cefepime, que é a conduta de quem é de alto risco. O escore MASCC aqui soma 26 (sintomas leves 5, sem hipotensão 5, sem DPOC 4, tumor sólido sem infecção fúngica prévia 4, sem desidratação 3, febre iniciada fora do hospital 3, idade abaixo de 60 anos 2), acima do corte de 21, e não há critério clínico de alto risco: sem foco, sem disfunção orgânica, lactato normal e neutropenia esperada curta. Com suporte domiciliar e acesso rápido ao hospital, a ASCO e a IDSA indicam antibiótico oral (ciprofloxacino com amoxicilina-clavulanato), com a primeira dose no serviço, observação e alta com reavaliação precoce. Não tratar é inaceitável: toda neutropenia febril recebe antibiótico empírico depois das hemoculturas.

A) Internar e iniciar cefepime intravenoso ARMADILHA
Errada. É a isca: seria a conduta com MASCC abaixo de 21, instabilidade, foco, disfunção orgânica ou impossibilidade de seguimento; nada disso existe aqui.

B) Internar com piperacilina-tazobactam e vancomicina
Errada. Vancomicina empírica se indica em instabilidade, infecção de cateter ou pele, pneumonia ou colonização por MRSA; nenhuma está presente.

C) Alta sem antibiótico, aguardando culturas
Errada. Neutropenia febril exige antibiótico empírico na primeira hora, qualquer que seja o risco.

D) Ciprofloxacino e amoxicilina-clavulanato orais CORRETA
Correta. MASCC de 26, sem critério de alto risco e com suporte domiciliar: ciprofloxacino e amoxicilina-clavulanato orais, ambulatorial após observação.

Para levar. MASCC de 21 ou mais, sem critério clínico de gravidade e com acesso rápido ao hospital: neutropenia febril pode ser tratada com antibiótico oral ambulatorial.

ASCO/IDSA Guideline Update: Outpatient Management of Fever and Neutropenia in Adults Treated for Malignancy (2018); NCCN Prevention and Treatment of Cancer-Related Infections (2025)

---

3 Endocrinologia · DHGNA: FIB-4 abaixo de 1,3 no diabético com ALT elevada

Omissão **Gabarito B**

Homem de 54 anos, com diabetes tipo 2 há seis anos em metformina e empagliflozina (HbA1c 7,1%), hipertensão e IMC de 33 kg/m², é encaminhado porque a ultrassonografia de abdome, pedida por dor lombar, descreveu esteatose hepática moderada. Consome cerca de duas doses de álcool por semana. Nega uso de amiodarona, metotrexato ou corticoide. Exame: sem estigmas de hepatopatia crônica, baço não palpável. Exames: AST 34 U/L (até 40), ALT 71 U/L (até 41), GGT 88 U/L, plaquetas 268.000/mm³, albumina 4,4 g/dL, HBsAg e anti-HCV negativos, ferritina 210 ng/mL com saturação de transferrina 29%. O índice FIB-4 calculado foi 0,81. Além de reforçar a perda de peso, o próximo passo mais adequado na avaliação da fibrose hepática é:

O DADO QUE DECIDE

O índice FIB-4 calculado foi 0,81

Resolução. A armadilha é a elastografia: o paciente é diabético, obeso e tem ALT quase duas vezes o limite, e o reflexo é achar que esse grupo de alto risco precisa de um segundo exame. Mas o diabetes é o motivo para calcular o FIB-4, e não para pular o resultado dele. Com FIB-4 abaixo de 1,3, o valor preditivo negativo para fibrose avançada passa de 90%, e o fluxograma termina ali: mudança de estilo de vida e novo FIB-4 em um a dois anos no diabético (um a três anos nos demais). A ALT elevada não entra no índice como fator de risco de fibrose e não muda a etapa; transaminase normal ou alta não estratifica fibrose. Elastografia fica para 1,3 a 2,67, e hepatologista para acima de 2,67 ou elastografia acima de 12 kPa. Ferritina com saturação de 29% não é sobrecarga de ferro e também não pede nada.

A) Biópsia hepática percutânea
Errada. Biópsia se reserva a dúvida diagnóstica ou discordância entre testes não invasivos de risco intermediário ou alto, o que não existe aqui.

B) Repetir o FIB-4 em um a dois anos CORRETA
Correta. FIB-4 de 0,81 é baixo risco; no diabético, repete-se o FIB-4 em um a dois anos, com foco na perda de peso.

C) Elastografia hepática transitória ARMADILHA
Errada. Seria a conduta com FIB-4 entre 1,3 e 2,67; com 0,81 o risco já está estratificado como baixo.

D) Encaminhamento ao hepatologista
Errada. Encaminhamento é para FIB-4 acima de 2,67 ou elastografia alterada; ALT elevada isolada não é critério.

Para levar. FIB-4 abaixo de 1,3 encerra a estratificação: repete-se o índice (em um a dois anos no diabético). Elastografia só entre 1,3 e 2,67; hepatologista acima de 2,67.

AASLD Practice Guidance on MASLD 2023; EASL-EASD-EASO Clinical Practice Guidelines on MASLD 2024; ADA Standards of Care 2026, seção 4.

4

Reumatologia · Vasculopatia por cocaína adulterada com levamisol imitando granulomatose com poliangeíte

Rótulo verdadeiro

Gabarito B

Homem de 34 anos procura atendimento por lesões dolorosas e escurecidas nas orelhas e nas bochechas há 10 dias, com artralgias de mãos e joelhos. Há 6 meses tem obstrução nasal com crostas e epistaxe ocasional. Usa cocaína inalada nos fins de semana há 5 anos e nega outras drogas ou medicações. Exame físico: T 37,4 °C, PA 124 × 78 mmHg, púrpura retiforme com centro necrótico nas hélices das duas orelhas e nas regiões malares, perfuração do septo nasal anterior, sem sinovite, ausculta pulmonar normal. Exames: Hb 12,6 g/dL, leucócitos 2.300/mm³ (neutrófilos 450/mm³), plaquetas 205.000/mm³, creatinina 0,9 mg/dL, EAS sem hematúria e sem proteinúria, p-ANCA reagente 1:1.280 com anti-MPO 160 U/mL e anti-PR3 42 U/mL (VR < 20 para ambos), anticoagulante lúpico reagente, crioglobulinas negativas, anti-HCV e anti-HIV não reagentes. TC de tórax normal; TC de seios da face com perfuração septal, sem erosão de seios paranasais ou da órbita. O diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

púrpura retiforme com centro necrótico nas hélices das duas orelhas e nas regiões malares

Resolução. Anti-PR3 reagente, crostas nasais, epistaxe e perfuração septal são o rótulo que puxa granulomatose com poliangeíte, e quem fecha pelo anticorpo indica rituximabe ou ciclofosfamida. Mas o conjunto é de outra doença: usuário de cocaína com púrpura retiforme necrótica nas orelhas e nas bochechas, neutropenia, ANCA em título muito alto com anti-MPO e anti-PR3 ao mesmo tempo e anticoagulante lúpico reagente é a vasculopatia pelo levamisol, adulterante frequente da cocaína. A lesão nasal destrutiva também é efeito da própria cocaína (lesão destrutiva da linha média), que imita a granulomatose e induz ANCA. Faltam os órgãos da vasculite sistêmica: sem glomerulonefrite, sem nódulos pulmonares e sem erosão de seios ou órbita. O tratamento é suspender a cocaína, com cuidado local das lesões e vigilância da neutropenia; imunossupressão fica para a minoria com glomerulonefrite ou hemorragia alveolar, e a reexposição faz recair.

A) Poliangeíte microscópica

Errada. A poliangeíte microscópica é anti-MPO, mas com glomerulonefrite ou capilarite pulmonar e sem neutropenia; não explica perfuração septal nem necrose nas orelhas.

B) Vasculopatia por levamisol CORRETA

Correta. Cocaína, púrpura retiforme em orelhas e bochechas, neutropenia, ANCA duplo em título alto e anticoagulante lúpico: vasculopatia pelo levamisol.

C) Granulomatose com poliangeíte ARMADILHA

Errada. Seria a resposta com anti-PR3 isolado, nódulos pulmonares, erosão de seios ou órbita e glomerulonefrite; aqui o ANCA é duplo, em título muito alto, e a necrose nas orelhas com neutropenia aponta o adulterante.

D) Vasculite crioglobulinêmica
Errada. Explicaria púrpura com necrose de extremidades, mas as crioglobulinas são negativas e o HCV é não reagente.

Para levar. ANCA em título muito alto com anti-MPO e anti-PR3 juntos, púrpura retiforme em orelhas e neutropenia em usuário de cocaína é vasculopatia pelo levamisol: o tratamento é parar a droga, não imunossuprimir pelo anticorpo.

ACR/EULAR 2022 classification criteria for GPA (exigem excluir mimetizadores); KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Management of ANCA-Associated Vasculitis; McGrath MM et al., Clin J Am Soc Nephrol 2011 (cocaína contaminada com levamisol e doença associada ao ANCA).

---

5 Hematologia · Linfoma folicular de baixa carga tumoral em estádio IV: observação vigilante

Grade X / Y **Gabarito D**

Mulher de 58 anos procura o clínico por "ínguas" no pescoço e na virilha percebidas há 1 ano, sem crescimento desde então. Nega febre, sudorese noturna e perda de peso. Exame: linfonodos cervicais e inguinais bilaterais de 1,5 a 2,5 cm, fibroelásticos e indolores; baço não palpável. Exames: Hb 13,1 g/dL, leucócitos 6.400/mm³, plaquetas 210.000/mm³, LDH 190 U/L (VR até 250), beta-2-microglobulina normal. Biópsia excisional de linfonodo inguinal: proliferação nodular de células B pequenas clivadas, CD20+, CD10+, BCL2+, CD5 negativo, ciclina D1 negativa, Ki-67 de 10%. PET-CT: linfonodos cervicais, axilares, mediastinais e ilíacos, apenas um acima de 3 cm (o maior com 3,2 cm), SUV máximo de 6. Biópsia de medula óssea com infiltração paratrabecular de 15%. O diagnóstico e a conduta são, respectivamente:

> **O DADO QUE DECIDE**
> *apenas um acima de 3 cm (o maior com 3,2 cm)*

Resolução. A primeira metade se decide pela imuno-histoquímica: CD10+ e BCL2+ com CD5 e ciclina D1 negativos, padrão nodular e Ki-67 baixo é linfoma folicular de baixo grau; o manto seria CD5+ e ciclina D1+. A segunda metade é onde o rótulo engana: a medula infiltrada coloca a doente em estádio IV, e estádio IV soa como indicação de quimioterapia. No folicular, porém, quem indica tratamento é a carga tumoral (critérios GELF), não o estádio: massa de 7 cm ou mais, três ou mais sítios nodais acima de 3 cm, sintomas B, esplenomegalia, citopenias, fase leucêmica, derrames ou compressão de órgão (e, pela NCCN, também progressão contínua ou doença volumosa). Ela não tem nenhum: só um linfonodo passa de 3 cm, os exames estão normais e a doença não cresce há 1 ano. Ensaios randomizados mostram que tratar o folicular assintomático de baixa carga não aumenta a sobrevida, e a conduta é observação com reavaliação periódica. SUV de 6 também afasta transformação, que pede biópsia do sítio mais ávido.

A) Linfoma do manto / R-quimioterapia
Errada. Erra as duas metades: manto exigiria CD5+ e ciclina D1+, e mesmo nele o tratamento depende do comportamento clínico.

B) Linfoma do manto / observação vigilante
Errada. A conduta caberia num manto indolente leucêmico não nodal selecionado, mas a imuno-histoquímica (CD10+, ciclina D1 negativa) não é de manto.

C) Linfoma folicular / R-quimioterapia ARMADILHA

Errada. É a armadilha: diagnóstico certo, mas estádio IV não indica tratamento no folicular sem critério de carga tumoral.

D) Linfoma folicular / observação vigilante CORRETA

Correta. Folicular (CD10+, BCL2+, ciclina D1 negativa) sem nenhum critério GELF: observação vigilante, mesmo com medula infiltrada.

Para levar. No linfoma folicular a indicação de tratar vem da carga tumoral (GELF) e dos sintomas, não do estádio: estádio IV assintomático e de baixa carga se observa.

NCCN B-Cell Lymphomas 2025; ESMO 2021 Clinical Practice Guidelines para linfoma folicular; critérios GELF.

6

Medicina baseada em evidências · NNT: taxa por pacientes-ano convertida para o horizonte do estudo

Qualificador

Gabarito A

Ensaio clínico randomizado comparou uma droga a placebo em pacientes de alto risco cardiovascular e os acompanhou por 5 anos. A taxa de AVC foi de 2,0 por 100 pacientes-ano no grupo placebo e de 1,5 por 100 pacientes-ano no grupo tratado, constante ao longo do seguimento. O número de pacientes que é preciso tratar durante os 5 anos para evitar um AVC é, aproximadamente:

O DADO QUE DECIDE

durante os 5 anos

Resolução. A redução absoluta de risco é de 0,5 ponto percentual por ano (2,0 menos 1,5 por 100 pacientes-ano), o que dá NNT de 200 por ano de tratamento. O comando, porém, qualifica o horizonte: tratar durante 5 anos. Com taxa constante e eventos pouco frequentes, a redução absoluta acumulada é de cerca de 2,5 pontos percentuais, e o NNT em 5 anos é cerca de 1 dividido por 0,025, ou 40 (a conta exata pelas incidências acumuladas, cerca de 9,5% contra 7,2%, dá perto de 44, e nenhuma outra alternativa se aproxima). O 200 é a resposta certa para outra pergunta (um ano). O 25 é a redução relativa de risco (25%) escrita como número, e o 4 é o inverso dela, duas grandezas verdadeiras que não são o NNT.

A) 40 CORRETA

Correta. Redução absoluta de cerca de 0,5 ponto por ano, acumulada em 5 anos (cerca de 2,5 pontos): NNT de aproximadamente 40 no horizonte pedido.

B) 4

Errada. É 1 dividido pela redução relativa (0,25); NNT usa a redução absoluta.

C) 25

Errada. 25 é a redução relativa de risco em porcentagem (0,5 de 2,0), grandeza verdadeira fora do comando.

D) 200 ARMADILHA

Errada, e é a armadilha. É o NNT para um ano de tratamento (1 dividido por 0,005); seria a resposta se o comando pedisse o número por ano.

Para levar. NNT é 1 dividido pela redução absoluta de risco no horizonte de tempo pedido; com taxa por pacientes-ano, o NNT de um ano dividido pelo número de anos dá a aproximação.

Guyatt, Users' Guides to the Medical Literature, 3ª ed.; Laupacis, Sackett e Roberts (N Engl J Med 1988)

---

7 Neurologia · Crise aguda sintomática por hipoglicemia de sulfonilureia na DRC: tratar a causa e observar, sem anticrise

Omissão **Gabarito D**

Homem de 74 anos, com diabetes tipo 2 e doença renal crônica (TFGe 24 mL/min/1,73 m²), em uso de glibenclamida 10 mg/dia e losartana, é trazido pela filha após crise tônico-clônica generalizada de cerca de 2 minutos, em casa, às 6 h. Ela conta que ele quase não jantou na véspera por diarreia. Na chegada, 40 minutos depois, está confuso e sudoreico, sem déficit focal, PA 150/90 mmHg, FC 104 bpm, Tax 36,4 °C. Glicemia capilar 34 mg/dL. Recebeu 50 mL de glicose a 50% IV, com recuperação completa da consciência em 10 minutos. Sódio 138 mEq/L, cálcio 9,2 mg/dL, creatinina 2,6 mg/dL. TC de crânio sem contraste: atrofia compatível com a idade. Nunca teve crise antes. A conduta mais adequada neste momento é:

O DADO QUE DECIDE

doença renal crônica (TFGe 24 mL/min/1,73 m²), em uso de glibenclamida 10 mg/dia

Resolução. A crise no PS puxa o reflexo da dose de ataque, mas esta crise tem causa aguda identificada e corrigida: glicemia de 34 mg/dL com recuperação plena após a glicose. Crise aguda sintomática (provocada) não é epilepsia e não se trata com droga anticrise; trata-se a causa. A decisão real está entre internar e dar alta, e quem a decide é a primeira linha: glibenclamida, sulfonilureia de meia-vida longa e metabólitos ativos de eliminação renal, numa TFGe de 24. Essa hipoglicemia recorre por 24 a 72 horas depois da primeira correção, e a refeição isolada não protege. Por isso a conduta é internar com glicose IV contínua e glicemias seriadas (octreotida se houver recorrência apesar da glicose), suspendendo a sulfonilureia de forma definitiva.

A) Levetiracetam oral por seis meses
Errada. Droga de manutenção seria discutida numa primeira crise não provocada com EEG ou imagem alterados; crise provocada não aumenta o risco de epilepsia a ponto de justificar tratamento crônico.

B) Fenitoína IV em dose de ataque ARMADILHA
Errada, é a armadilha. Fenitoína seria para estado de mal ou crise recorrente sem causa corrigível; aqui a crise foi provocada pela hipoglicemia, já corrigida, e a droga não previne nova hipoglicemia.

C) Alta após refeição, sem glibenclamida
Errada. Seria aceitável na hipoglicemia por insulina rápida corrigida em paciente com função renal normal; com sulfonilureia de ação longa e DRC, a recorrência nas horas seguintes é a regra.

D) Internação com glicose IV contínua CORRETA
Correta. Glibenclamida com TFGe de 24 dá hipoglicemia prolongada e recorrente: exige glicose IV contínua, glicemias seriadas e observação hospitalar.

Para levar. Crise com causa aguda corrigida (hipoglicemia, hiponatremia, abstinência) não pede anticrise: trata-se a causa. Hipoglicemia por sulfonilureia na DRC pede internação e glicose contínua.

ILAE 2010 e 2021 (crise aguda sintomática); ADA Standards of Care 2026 (hipoglicemia, sulfonilureias na DRC); SBD 2025.

8

Cardiologia · Complicação mecânica do infarto: ruptura de músculo papilar x comunicação interventricular pela oximetria

Negativo no meio

Gabarito D

Homem de 63 anos, no 4º dia de infarto inferior tratado com angioplastia da coronária direita realizada 14 horas após o início da dor, evolui subitamente com dispneia intensa e hipotensão. Exame: PA 84×54 mmHg, FC 118 bpm, SpO2 84% em ar ambiente, estertores até ápices, sopro holossistólico de intensidade 3/6, mais audível na borda esternal esquerda baixa e na base, sem frêmito palpável. Cateter de artéria pulmonar: saturação de O2 de 58% no átrio direito e de 59% na artéria pulmonar; pressão de oclusão com ondas v de 48 mmHg. Radiografia: congestão pulmonar bilateral. O diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

saturação de O2 de 58% no átrio direito e de 59% na artéria pulmonar

Resolução. Sopro holossistólico novo na borda esternal esquerda, com choque e edema agudo de pulmão no 4º dia de infarto, puxa para a comunicação interventricular, e é a armadilha. O dado que separa é a oximetria: na comunicação interventricular o sangue oxigenado do VE passa para o VD e a saturação salta (7% ou mais) entre o átrio direito e a artéria pulmonar; aqui ela é praticamente igual (58% e 59%). A onda v gigante não diferencia, porque também surge na comunicação interventricular pelo hiperfluxo que retorna ao átrio esquerdo. O infarto inferior por coronária direita compromete o músculo papilar posteromedial, de irrigação única, e o jato do folheto posterior, excêntrico e anterior, pode ser mais audível na borda esternal e na base, imitando a comunicação. Ausência de frêmito e edema pulmonar maciço também favorecem a ruptura de papilar; o tratamento é cirurgia de emergência com suporte hemodinâmico.

A) Infarto de ventrículo direito
Errada. O infarto de VD dá hipotensão com pulmões limpos e turgência jugular, não estertores até ápices nem sopro novo, e aparece na chegada, não no 4º dia.

B) Ruptura de parede livre do ventrículo esquerdo
Errada. A ruptura de parede livre se apresenta como tamponamento e dissociação eletromecânica, sem sopro novo e sem edema pulmonar maciço.

C) Comunicação interventricular pós-infarto ARMADILHA
Errada, e é a armadilha. Seria a resposta com salto de saturação entre átrio direito e artéria pulmonar e frêmito paraesternal; a saturação aqui não muda.

D) Ruptura de músculo papilar CORRETA
Correta. Sopro novo com edema agudo de pulmão, onda v gigante e sem salto oximétrico, no 4º dia de infarto inferior: ruptura do papilar posteromedial.

Para levar. Sopro novo e choque nos dias 2 a 7 do infarto: o salto de saturação entre átrio direito e artéria pulmonar define comunicação interventricular; sem salto, com edema pulmonar maciço, é insuficiência mitral aguda por ruptura de papilar (posteromedial no infarto inferior). Onda v gigante aparece nas duas.

ESC 2023 (acute coronary syndromes); AHA Scientific Statement 2021 (mechanical complications of acute myocardial infarction); V Diretriz da SBC sobre Tratamento do IAM com Supradesnível do Segmento ST (2015)

9

Nefrologia · Hiponatremia na insuficiência cardíaca · volemia pelo exame físico: restrição hídrica e diurético x salina

Grade X / Y

Gabarito A

Homem de 74 anos, com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida (FE 28%) em uso de sacubitril-valsartana, carvedilol, espironolactona, dapagliflozina e furosemida 40 mg/dia, é internado por dispneia aos mínimos esforços e ganho de 5 kg em duas semanas. Por conselho de um vizinho, passou a beber pelo menos três litros de água por dia para proteger os rins. Exame: lúcido, sem déficits, PA 104/68 mmHg, FC 92 bpm, turgência jugular a 45 graus, estertores até o terço médio de ambos os hemitórax e edema 3+ até as coxas. Exames: sódio 124 mEq/L (era 136 mEq/L há dois meses), potássio 4,6 mEq/L, ureia 68 mg/dL, creatinina 1,4 mg/dL (basal 1,2), glicemia 110 mg/dL, osmolalidade plasmática 262 mOsm/kg, osmolalidade urinária 410 mOsm/kg e sódio urinário de 18 mEq/L, colhido 22 horas após a última dose de furosemida. O mecanismo da hiponatremia e a conduta são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

turgência jugular a 45 graus, estertores até o terço médio de ambos os hemitórax e edema 3+ até as coxas

Resolução. Depois de errar duas vezes uma hiponatremia em que o rótulo de IC escondia hipovolemia por furosemida, a tentação é generalizar: IC com diurético e sódio baixo seria sempre depleção, e a resposta seria suspender o diurético e dar salina. Mas a volemia se lê no exame físico do dia, não no diagnóstico de base: turgência jugular, estertores até o terço médio e edema até as coxas, com 5 kg ganhos, são congestão franca. O sódio urinário baixo, colhido longe da dose de furosemida, mostra retenção ávida de sódio por volume arterial efetivo baixo, e a urina concentrada (410 mOsm/kg) mostra ADH não osmótico ativo; os três litros de água por dia fornecem a água livre que ele não consegue excretar. O tratamento é restringir água livre e intensificar o diurético de alça, que, por produzir urina relativamente hipotônica, também ajuda o sódio a subir. Salina isotônica num congesto piora o edema pulmonar e quase não corrige o sódio, porque o rim retém o sal e não excreta a água.

A) Hipervolemia / restrição hídrica e furosemida IV CORRETA

Correta. Congestão no exame (turgência, estertores, edema 3+) com sódio urinário baixo longe da dose de diurético define hiponatremia hipervolêmica; restrição de água livre e furosemida IV tratam a congestão e o sódio.

B) Hipervolemia / suspender furosemida e salina isotônica

Errada. O mecanismo está certo, mas suspender o diurético e dar salina num paciente com estertores até o terço médio agrava a congestão; a salina só caberia na depleção.

C) Hipovolemia por diurético / restrição hídrica e furosemida IV

Errada. Restrição e diurético seria a conduta certa, mas o mecanismo não é hipovolemia: não há nenhum sinal de depleção, e sim de congestão.

D) Hipovolemia por diurético / suspender furosemida e salina isotônica ARMADILHA

Errada, é a armadilha. Seria a resposta no paciente com IC superdiurético, sem edema, com mucosas secas, ureia subindo e hipotensão postural (o caso da questão que ele errou duas vezes); aqui o exame mostra congestão.

Para levar. Na IC, a volemia da hiponatremia se decide no exame físico do dia, não no rótulo da doença nem no uso de diurético: o congesto pede restrição hídrica e diurético de alça; o depletado pede suspender o diurético e salina.

ESC 2021 (Insuficiência cardíaca) com atualização 2023; Diretriz Brasileira de IC Crônica e Aguda (SBC 2018); Spasovski et al., Diretriz europeia de hiponatremia (2014).

---

10 Gastroenterologia · Helicobacter pylori: teste de controle de erradicação e suspensão do IBP

Grade X / Y **Gabarito A**

Após o tratamento de erradicação do Helicobacter pylori em paciente com úlcera duodenal não complicada, o exame de controle de cura e a conduta quanto ao inibidor de bomba de prótons antes dele são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

úlcera duodenal não complicada

Resolução. A metade fácil é o teste: a sorologia permanece reagente por meses a anos após a erradicação e não serve para controle de cura. A metade que derruba é o IBP: ele reduz a carga bacteriana e a atividade da urease e dá falso negativo no teste respiratório, no antígeno fecal e no teste da urease da biópsia. Por isso o controle se faz com teste respiratório com ureia marcada (ou antígeno fecal monoclonal) pelo menos 4 semanas após o fim do antibiótico e com o IBP suspenso por 2 semanas. Na úlcera duodenal não complicada, o controle não invasivo basta; na úlcera gástrica, o controle é endoscópico, para biopsiar a úlcera.

A) Teste respiratório com ureia / suspender IBP 2 semanas antes CORRETA

Correta. Teste respiratório com ureia, ao menos 4 semanas após o antibiótico e com IBP suspenso por 2 semanas.

B) Sorologia IgG / manter IBP

Errada. A sorologia não diferencia infecção atual de cicatriz imunológica, e manter o IBP seria irrelevante para ela; a combinação é inadequada nas duas metades.

C) Teste respiratório com ureia / manter IBP até o exame ARMADILHA

Errada. É a isca: o teste está certo, mas o IBP mantido reduz a urease e gera falso negativo, declarando uma erradicação que não ocorreu.

D) Sorologia IgG / suspender IBP 2 semanas antes

Errada. Suspender o IBP está certo, mas a sorologia segue reagente após a cura e induz retratamento desnecessário.

Para levar. Controle de erradicação: teste respiratório ou antígeno fecal, 4 semanas sem antibiótico e 2 semanas sem IBP; nunca sorologia.

IV Consenso Brasileiro sobre Helicobacter pylori (Arq Gastroenterol, 2018); Maastricht VI/Florença (2022); ACG Clinical Guideline: Treatment of Helicobacter pylori Infection (2024)

---

11 Infectologia · Sarampo: profilaxia pós-exposição em gestante suscetível fora da janela da vacina

Cronologia **Gabarito C**

Mulher de 27 anos, gestante de 16 semanas, procura a UBS porque a irmã, com quem mora, teve sarampo confirmado por RT-PCR. As duas dividiram o quarto até a irmã ser internada em isolamento há 4 dias, no mesmo dia em que surgiu o exantema. A gestante está assintomática e não tem comprovante de vacinação; a sorologia IgG para sarampo, colhida hoje, é não reagente. Nega imunodeficiência e alergias. A conduta mais adequada para ela, segundo o Ministério da Saúde, é:

O DADO QUE DECIDE

até a irmã ser internada em isolamento há 4 dias

Resolução. Contato suscetível de caso confirmado pede bloqueio, e o reflexo é vacinar. Dois dados derrubam a vacina: ela é gestante, e a tríplice viral é de vírus vivo, contraindicada na gestação; e a última exposição foi há 4 dias, fora da janela de 72 horas em que a vacina funciona como profilaxia pós-exposição. A imunoglobulina humana normal é a profilaxia indicada para contatos suscetíveis com contraindicação à vacina (gestantes, imunodeprimidos e menores de 6 meses), desde que aplicada em até 6 dias da exposição, e o 4º dia está dentro dessa janela. A vacina fica para o puerpério. Observar sem profilaxia desperdiça a única janela útil em quem tem risco de sarampo grave e de perda fetal.

A) Vitamina A em dose de ataque
Errada. Vitamina A é indicada para crianças com sarampo, para reduzir gravidade; não é profilaxia de contato adulto.

B) Observação, sem profilaxia
Errada. Seria aceitável após 6 dias da exposição ou em contato imune; no 4º dia, em gestante suscetível, ainda cabe imunoglobulina.

C) Imunoglobulina humana normal CORRETA
Correta. Gestante suscetível, exposição há 4 dias: imunoglobulina humana normal em até 6 dias.

D) Vacina tríplice viral hoje ARMADILHA
Errada. É a armadilha: o bloqueio vacinal em até 72 horas seria a conduta para um contato suscetível não gestante; aqui há gestação e já se passaram 4 dias.

Para levar. Contato suscetível de sarampo: vacina em até 72 horas; gestante, imunodeprimido e menor de 6 meses recebem imunoglobulina em até 6 dias.

Guia de Vigilância em Saúde (MS, 6ª edição, 2023), capítulo de sarampo.

---

12 Endocrinologia · Interferência da biotina: falsa tireotoxicose com TRAb positivo

Droga a deduzir **Gabarito D**

Mulher de 36 anos procura o clínico com o resultado de exames pedidos pela dermatologista, que acompanha queda de cabelo e unhas quebradiças há quatro meses e prescreveu um suplemento manipulado em dose alta, em uso diário desde então. Nega palpitação, tremor, perda de peso, intolerância ao calor ou alteração do ritmo intestinal. Exame: FC 74 bpm, PA 118/72 mmHg, tireoide de volume normal, sem nódulos, sem oftalmopatia, pele e reflexos normais. Exames: TSH 0,04 µUI/mL (0,4 a 4,5), T4 livre 3,1 ng/dL (0,8 a 1,8), T3 total 240 ng/dL (80 a 200), anticorpo antirreceptor de TSH (TRAb) 4,2 UI/L (até 1,75). Hemograma e ferritina normais. A explicação mais provável para esses exames é:

O DADO QUE DECIDE

Nega palpitação, tremor, perda de peso, intolerância ao calor ou alteração do ritmo intestinal

Resolução. TSH suprimido, T4 livre e T3 altos e TRAb positivo formam o perfil laboratorial completo de Graves, e é isso que puxa a resposta. A droga a deduzir é a biotina, o suplemento de dose alta prescrito para cabelo e unhas. Nos imunoensaios com estreptavidina e biotina, o excesso de biotina derruba o resultado dos ensaios em sanduíche (TSH baixo falso) e eleva o dos competitivos (T4 livre, T3 e o próprio TRAb altos falsos), imitando Graves inteiro. O que denuncia o artefato é a clínica: nenhuma manifestação adrenérgica, FC 74 bpm e tireoide normal com T4 livre quase duas vezes o limite. A conduta é suspender a biotina por pelo menos dois a três dias (uma semana para doses muito altas) e repetir os exames, de preferência avisando o laboratório.

A) Tireoidite indolor em fase tireotóxica
Errada. Tireoidite indolor dá tireotoxicose clínica e TRAb negativo; o anticorpo positivo e a ausência de sintomas não combinam.

B) Tireotoxicose factícia por hormônio no suplemento
Errada. Hormônio no suplemento produziria sintomas e TRAb negativo; é a explicação para tireotoxicose clínica com tireoglobulina baixa.

C) Doença de Graves em fase inicial ARMADILHA
Errada. Seria o diagnóstico com taquicardia, bócio ou oftalmopatia; aqui o TRAb positivo também é artefato da biotina em ensaio competitivo.

D) Artefato analítico do imunoensaio CORRETA
Correta. Biotina em dose alta reduz o TSH e eleva T4 livre, T3 e TRAb nos imunoensaios com estreptavidina; a paciente está clinicamente eutireoidiana.

Para levar. Laboratório de tireotoxicose em quem não tem nenhum sinal dela: pergunte pela biotina (e pela heparina), suspenda e repita antes de tratar.

FDA Safety Communication on biotin interference with laboratory tests (2017, atualizada em 2019); ATA Guidelines for Hyperthyroidism and Other Causes of Thyrotoxicosis 2016.

13 Reumatologia · Dermatomiosite anti-MDA5: doença pulmonar rapidamente progressiva antes do rastreio de neoplasia

Grade X / Y **Gabarito D**

Mulher de 61 anos, ex-tabagista (20 maços-ano), procura atendimento por dispneia que progrediu em 5 semanas de grandes para pequenos esforços, com tosse seca. Há 3 meses notou lesões violáceas nas pálpebras, pápulas dolorosas e ulceradas nas faces palmares das articulações interfalângicas, úlceras nas polpas digitais, artralgia em mãos e queda de cabelo. Perdeu 5 kg. Nega fraqueza para subir escadas ou pentear os cabelos. Exame físico: SpO2 89% em ar ambiente, FR 26 irpm, estertores em velcro bibasais, força muscular grau 5 nos quatro membros, heliotropo e eritema em V no decote. Exames: CK 190 U/L (VR até 170), aldolase normal, ferritina 2.300 ng/mL, AST 88 U/L, linfócitos 600/mm³. TC de tórax: consolidações e vidro fosco subpleurais e peribroncovasculares em bases, ausentes em radiografia de 2 meses antes. O autoanticorpo mais provável e a conduta prioritária neste momento são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

pápulas dolorosas e ulceradas nas faces palmares das articulações interfalângicas

Resolução. Idade de 61 anos, tabagismo e perda de peso numa dermatomiosite puxam para o anti-TIF1-gama e para a caça à neoplasia, que é o reflexo de manual. Mas o fenótipo é outro: miosite clinicamente ausente (força normal, CK quase normal), pápulas palmares dolorosas e ulceradas, úlceras digitais, alopecia, ferritina alta, linfopenia e uma pneumopatia que surgiu em semanas. Esse conjunto define a dermatomiosite amiopática anti-MDA5, cuja ameaça é a doença intersticial rapidamente progressiva, com mortalidade alta em meses. A conduta prioritária é imunossupressão combinada precoce (glicocorticoide em dose alta com inibidor de calcineurina, com ou sem ciclofosfamida), e não adiar o tratamento para terminar o rastreio. O rastreio de neoplasia continua indicado pela idade, mas não pode passar na frente de uma pneumopatia que dessatura em 5 semanas. O anti-TIF1-gama, ao contrário, cursa com lesão cutânea extensa e risco de câncer, e quase nunca com pneumopatia grave.

A) Anti-TIF1-gama / rastreio de neoplasia oculta ARMADILHA
Errada nas duas metades. Seria a resposta em dermatomiosite com lesões cutâneas extensas, disfagia e sem pneumopatia em adulto acima de 40 anos; aqui as úlceras palmares e a pneumopatia rápida apontam anti-MDA5.

B) Anti-TIF1-gama / imunossupressão combinada imediata
Errada na primeira metade. A conduta seria certa para pneumopatia grave, mas o anti-TIF1-gama não explica úlceras palmares, miosite ausente e pneumopatia rapidamente progressiva.

C) Anti-MDA5 / rastreio de neoplasia antes de imunossuprimir
Errada na segunda metade. O autoanticorpo está certo, mas condicionar a imunossupressão ao rastreio de neoplasia atrasa o tratamento de uma pneumopatia que mata em semanas.

D) Anti-MDA5 / imunossupressão combinada imediata CORRETA
Correta. Úlceras palmares e digitais, miosite ausente, ferritina alta e pneumopatia em semanas definem anti-MDA5, em que a imunossupressão combinada precoce decide a sobrevida.

Para levar. Dermatomiosite com pápulas palmares ulceradas, miosite ausente e pneumopatia em semanas é anti-MDA5: tratar a pneumopatia vem antes de tudo. Neoplasia é o risco do anti-TIF1-gama e do anti-NXP2.

ACR 2023 Guideline for the Treatment of ILD in Systemic Autoimmune Rheumatic Diseases; IMACS 2023 (rastreio de neoplasia nas miopatias inflamatórias); EULAR/ACR 2017 critérios de classificação das miopatias inflamatórias.

---

14 Hematologia · Doença falciforme com queda da hemoglobina: crise aplásica por parvovírus B19 pelos reticulócitos

Rótulo verdadeiro **Gabarito C**

Homem de 20 anos, com anemia falciforme (HbSS) e hemoglobina basal de 8,2 g/dL, em uso de ácido fólico, procura a emergência por cansaço intenso e tontura há 4 dias. Há 10 dias teve febre baixa, coriza e dor nas pernas, que tratou em casa com dipirona como "crise leve". Sem dor óssea atual e sem dor torácica. Exame: FC 118 bpm, PA 100 × 60 mmHg, SpO2 97%, icterícia 1+/4, mucosas muito descoradas, baço não palpável, fígado a 2 cm do rebordo. Exames: Hb 3,9 g/dL, VCM 92 fL, reticulócitos 0,2% (basal de 9%), leucócitos 8.900/mm³, plaquetas 260.000/mm³, LDH 520 U/L, bilirrubina indireta 2,1 mg/dL. A causa mais provável da queda da hemoglobina é:

O DADO QUE DECIDE

reticulócitos 0,2% (basal de 9%)

Resolução. O rótulo verdadeiro é a doença falciforme com uma "crise" recente e icterícia, que puxa para mais hemólise como explicação da anemia. Só que hemólise aumentada vem com reticulocitose acima da basal, LDH subindo e bilirrubina subindo, e aqui os reticulócitos caíram de 9% para 0,2%, a LDH está mais baixa que o esperado para um falciforme e a icterícia é discreta. Medula que parou de produzir hemácias, numa doença em que a hemácia vive 10 a 20 dias, derruba a hemoglobina em dias: é a crise aplásica, quase sempre por parvovírus B19, que infecta o progenitor eritroide, e o pródromo viral de 10 dias atrás é a pista. Sequestro exige baço crescendo, e no adulto HbSS o baço já sofreu autoesplenectomia. A conduta é transfusão e precaução respiratória, e a recuperação dos reticulócitos marca o fim da crise.

A) Sequestro esplênico agudo
Errada. Seria a resposta em criança ou em hemoglobinopatia SC com baço aumentando rápido e reticulocitose; aqui o baço não é palpável e os reticulócitos caíram.

B) Hemólise aumentada pela crise vaso-oclusiva ARMADILHA
Errada. É a armadilha: hemólise maior teria reticulócitos acima de 9% e LDH alta; reticulócitos de 0,2% indicam falha de produção.

C) Aplasia eritroide por parvovírus B19 CORRETA
Correta. Hb muito abaixo da basal com reticulócitos quase zerados após pródromo viral é crise aplásica por parvovírus B19.

D) Deficiência aguda de folato
Errada. Ele usa ácido fólico, o VCM é 92 e a carência de folato daria megaloblastose com LDH muito alta, não queda tão abrupta.

Para levar. Na doença falciforme, hemoglobina despencando com reticulócitos baixos é crise aplásica (parvovírus B19); hemólise e sequestro cursam com reticulocitose.

ASH 2020 guidelines for sickle cell disease; Ministério da Saúde, Doença falciforme: condutas básicas para tratamento (2012) e PCDT Doença Falciforme (2018).

---

15 Pneumologia · Síndrome de Löfgren: sem biópsia e sem corticoide

Omissão **Gabarito D**

Mulher de 34 anos, ex-tabagista de 8 maços-ano, procura atendimento por febre baixa, dor e edema em ambos os tornozelos há 3 semanas e nódulos dolorosos e eritematosos na face anterior das pernas. Nega tosse, dispneia, perda de peso, sudorese noturna e contato com tuberculose. Exame: T 37,7 °C, periartrite de tornozelos bilateral, nódulos subcutâneos dolorosos em região pré-tibial, sem linfonodos periféricos palpáveis, sem hepatoesplenomegalia. Radiografia de tórax: alargamento hilar bilateral simétrico, sem infiltrado. TC: linfonodomegalias hilares bilaterais e paratraqueais direitas de até 2,2 cm, sem lesão parenquimatosa. Hemograma normal, cálcio 9,6 mg/dL, ECA 88 U/L (VR até 52). Espirometria e DLCO normais. Exame oftalmológico normal. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

Espirometria e DLCO normais

Resolução. Linfonodomegalia mediastinal em ex-tabagista faz pensar em linfoma ou neoplasia e leva ao EBUS, e sarcoidose lembra corticoide. Mas eritema nodoso, periartrite de tornozelos, febre e adenopatia hilar bilateral simétrica em mulher jovem formam a síndrome de Löfgren, cuja especificidade para sarcoidose passa de 95%: a amostragem linfonodal não é necessária, desde que o seguimento confirme a evolução esperada. A síndrome remite espontaneamente em mais de 80% dos casos em até 2 anos. Corticoide na sarcoidose é para comprometimento que ameaça órgão ou causa sintoma relevante: pulmonar com dispneia e queda de função, cardíaco, neurológico, ocular, hipercalcemia ou renal. Com função pulmonar, cálcio e exame ocular normais, o tratamento é sintomático com anti-inflamatório e reavaliação clínica e funcional.

A) Ecobroncoscopia com punção linfonodal ARMADILHA
Errada, e é a armadilha. EBUS seria indicado diante de quadro discordante (adenopatia assimétrica, sintomas B, sem eritema nodoso, linfonodo periférico ou massa); na Löfgren a biópsia não muda a conduta.

B) Prednisona 20 a 40 mg/dia
Errada. Corticoide sistêmico é para sarcoidose com dispneia e queda de função, ou com acometimento cardíaco, neurológico, ocular ou hipercalcemia; ela não tem nenhum desses.

C) Metotrexato semanal
Errada. Metotrexato é poupador de corticoide na sarcoidose crônica que precisa de tratamento prolongado; não cabe em doença autolimitada.

D) Anti-inflamatório e seguimento clínico CORRETA
Correta. Löfgren com função pulmonar, cálcio e olhos normais: anti-inflamatório para a artrite e o eritema nodoso e seguimento com radiografia e função pulmonar.

Para levar. Síndrome de Löfgren dispensa biópsia e corticoide: trata sintoma e acompanha. Sarcoidose só se trata quando ameaça órgão ou limita a vida.

ATS 2020 (diagnóstico de sarcoidose); ERS 2021 (tratamento da sarcoidose)

---

16 Gastroenterologia · Pancreatite aguda necrosante: coleção necrótica aguda estéril antes de 4 semanas

Grade X / Y **Gabarito C**

Homem de 46 anos, etilista de 80 g/dia, está internado há 16 dias por pancreatite aguda grave (falência respiratória transitória nas primeiras 36 horas, já resolvida). Recebe dieta por sonda nasojejunal desde o 3º dia, com boa tolerância, e a dor está controlada com dipirona. Hoje: Tax 37,6 °C, FC 92 bpm, PA 128 × 76 mmHg, SpO2 96% em ar ambiente, abdome com dor leve à palpação profunda do epigástrio, sem distensão. Exames: leucócitos 11.800/mm³ (estáveis há 5 dias), PCR 68 mg/L (era 290 mg/L no 3º dia), procalcitonina 0,2 ng/mL, creatinina 0,9 mg/dL; hemoculturas negativas. TC com contraste: necrose de 40% do corpo pancreático e coleção heterogênea de 9 cm adjacente ao estômago, com conteúdo não liquefeito, sem parede definida e sem gás. A classificação da coleção e a conduta mais adequada neste momento são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

sem parede definida e sem gás

Resolução. A coleção de 9 cm no 16º dia atrai a drenagem, e a febrícula reforça a impressão de infecção. Pela classificação de Atlanta revisada, na pancreatite necrosante a coleção das primeiras 4 semanas, heterogênea e sem parede, é coleção necrótica aguda; pseudocisto só existe na pancreatite intersticial e depois de 4 semanas, com parede formada e conteúdo líquido. O que indica intervenção não é o tamanho, e sim infecção com piora clínica ou sintoma compressivo: aqui não há gás, a PCR caiu de 290 para 68, a procalcitonina é baixa e as hemoculturas são negativas, com o doente estável e tolerando dieta enteral. Coleção estéril e assintomática não se drena, em qualquer tamanho, e antibiótico profilático não está indicado. Drenar agora não traz benefício, arrisca infectar uma necrose estéril e aborda tecido ainda não demarcado.

A) Pseudocisto / drenagem endoscópica
Errada. Pseudocisto exige pancreatite intersticial e mais de 4 semanas com parede formada, e mesmo assim só se drena quando sintomático ou complicado; coleção de 16 dias na pancreatite necrosante não é pseudocisto.

B) Coleção necrótica aguda / drenagem percutânea ARMADILHA
Errada. É a isca: acerta a classificação e erra a conduta: drenagem percutânea entra no step-up da necrose infectada com piora clínica, e aqui não há gás, bacteremia nem deterioração.

C) Coleção necrótica aguda / suporte clínico CORRETA
Correta. Coleção heterogênea, sem parede e sem gás no 16º dia de pancreatite necrosante é coleção necrótica aguda; estéril e com o doente estável, mantém-se suporte e nutrição enteral.

D) Pseudocisto / suporte clínico
Errada. A conduta coincide, mas a classificação está errada: chamar de pseudocisto uma coleção necrótica leva, mais adiante, a drenar como líquido o que é necrose sólida.

Para levar. Antes de 4 semanas não se drena coleção pancreática estéril e assintomática, seja qual for o tamanho; quem indica intervenção é infecção com piora clínica ou sintoma compressivo, de preferência depois do encapsulamento.

Classificação de Atlanta revisada (2012); ACG Guideline: Management of Acute Pancreatitis (2024); AGA Clinical Practice Update on Management of Pancreatic Necrosis (2020)

---

17 Cardiologia · Síndrome de Turner: da ectoscopia à valva aórtica bicúspide e à coarctação

Dado omitido **Gabarito D**

Mulher de 19 anos é encaminhada por amenorreia primária. Mede 1,44 m, tem pescoço curto com pterígio, implantação baixa dos cabelos na nuca, tórax largo com mamilos afastados, cúbito valgo e quarto metacarpo curto bilateral. Nega dispneia, síncope, cefaleia ou dor torácica. Exame: PA no braço direito 156×94 mmHg, FC 76 bpm, ritmo regular, ictus no 5º espaço intercostal na linha hemiclavicular. FSH 98 mUI/mL e estradiol indetectável; creatinina 0,7 mg/dL e urina normal. Ainda não fez ecocardiograma. Ao completar o exame cardiovascular, o conjunto de achados mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

PA no braço direito 156×94 mmHg

Resolução. Baixa estatura, pterígio, cúbito valgo, quarto metacarpo curto e hipogonadismo hipergonadotrófico formam a síndrome de Turner, que não foi nomeada nem confirmada por cariótipo. As duas lesões cardiovasculares que acompanham a síndrome são a valva aórtica bicúspide (cerca de 15 a 30%) e a coarctação da aorta (cerca de 10%), e a hipertensão medida no braço direito numa jovem de 19 anos, com rim e urina normais, é a pista da coarctação que a banca deixou sem os pulsos femorais. A bicúspide se ausculta como clique de ejeção aórtico, e a coarctação como sopro sistólico no dorso, entre as escápulas, às vezes contínuo pelas colaterais. A armadilha é a associação genérica 'síndrome genética em jovem, então CIA', a mesma que derrubou a questão de Marfan; o desdobramento fixo da CIA pertence a outras síndromes (Holt-Oram, Down). Para cada síndrome, a lesão é específica: Turner é lado esquerdo e aorta.

A) Desdobramento fixo de B2 e sopro ejetivo pulmonar ARMADILHA
Errada, e é a armadilha. Desdobramento fixo com sopro ejetivo pulmonar é a CIA, própria de Holt-Oram e de Down; em Turner, o retorno venoso pulmonar anômalo parcial pode imitá-la, mas é bem menos frequente e não explica a hipertensão no braço. Seria a resposta numa adulta com palpitações, BRD incompleto e sem estigmas de Turner.

B) Sopro contínuo em maquinária infraclavicular esquerdo
Errada. O sopro contínuo infraclavicular esquerdo é da persistência do canal arterial, associada à rubéola congênita e à prematuridade, sem relação com Turner.

C) Clique mesossistólico e sopro telessistólico apical
Errada. Clique mesossistólico seguido de sopro telessistólico é o prolapso mitral, que acompanha Marfan e Ehlers-Danlos, síndromes de estatura alta e hipermobilidade, o oposto do fenótipo descrito.

D) Clique ejetivo aórtico e sopro sistólico interescapular CORRETA
Correta. O clique ejetivo vem da valva bicúspide e o sopro interescapular da coarctação, as duas lesões da síndrome de Turner; a hipertensão no braço direito numa jovem com rim normal aponta a coarctação.

Para levar. Turner: valva aórtica bicúspide (clique ejetivo) e coarctação (HAS em membros superiores, sopro interescapular, pulsos femorais fracos e atrasados); CIA é de Down e Holt-Oram, prolapso é de Marfan e Ehlers-Danlos.

ESC 2020 (adult congenital heart disease); I Diretriz da SBC para Cardiopatias Congênitas do Adulto (2008); Diretriz internacional de cuidado na síndrome de Turner (Gravholt et al., Eur J Endocrinol 2017)

---

18 Neurologia · ELA com estenose cervical incidental: fasciculação de língua e NMI fora do segmento comprimido mandam para a ENMG

Rótulo verdadeiro **Gabarito A**

Homem de 63 anos, pedreiro aposentado, com cervicalgia mecânica há anos, tem fraqueza progressiva na mão direita há 8 meses, depois na esquerda, e câimbras frequentes nas panturrilhas. Nega parestesias, alteração esfincteriana, engasgos e alteração da voz. Exame: atrofia de interósseos e tenar bilateral, fasciculações em ambos os deltoides e nas panturrilhas, língua com atrofia de bordas e fasciculações em repouso, reflexos bicipitais e patelares vivos, Hoffmann bilateral, sensibilidade tátil, dolorosa e vibratória normais. RM de coluna cervical solicitada pelo clínico: discopatia degenerativa com estenose do canal em C5-C6, sem hipersinal medular em T2. O ortopedista indica descompressão. O próximo passo mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

língua com atrofia de bordas e fasciculações em repouso

Resolução. O rótulo é verdadeiro e vem reforçado pela cervicalgia antiga e pela indicação cirúrgica: há estenose em C5-C6, e a mielopatia espondilótica dá neurônio motor superior abaixo e inferior no nível. Mas uma compressão em C5-C6 não explica fasciculação e atrofia de língua (segmento bulbar) nem fasciculação em panturrilhas (lombossacral), isto é, sinais de neurônio motor inferior acima e muito abaixo da lesão, sem nenhuma alteração sensitiva ou esfincteriana. A ausência de queixa bulbar não tranquiliza: a fasciculação de língua costuma preceder a disfagia e a disartria, e nenhuma lesão cervical a produz. Estenose cervical degenerativa é achado frequente nessa idade e pode ser incidental. O exame que confirma a síndrome é a eletroneuromiografia com agulha, estudando os segmentos bulbar, cervical, torácico e lombossacral: desnervação ativa e crônica em várias regiões, com condução sensitiva normal, sustenta doença do neurônio motor pelos critérios de Gold Coast. Operar antes disso expõe o paciente a uma cirurgia que não muda a doença.

A) Eletroneuromiografia com agulha CORRETA
Correta. Fasciculação de língua e de panturrilhas com sensibilidade normal pede ENMG em vários segmentos para documentar desnervação difusa e confirmar doença do neurônio motor.

B) Anticorpo anti-GM1 sérico
Errada. Anti-GM1 se pede na neuropatia motora multifocal, que é puramente de neurônio motor inferior, com bloqueio de condução e sem reflexos vivos nem Hoffmann.

C) Descompressão cirúrgica de C5-C6 ARMADILHA
Errada, é a armadilha. Seria a conduta na mielopatia espondilótica com déficit progressivo e achados restritos ao nível comprimido; aqui há sinais bulbares e lombossacrais que a estenose não explica.

D) RM de encéfalo com contraste
Errada. RM de encéfalo seria para lesão estrutural de tronco com sinais bulbares de instalação aguda ou outros déficits; aqui o quadro é progressivo e misto, e a imagem não confirma doença do neurônio motor.

Para levar. Sinal de neurônio motor inferior fora do segmento comprimido (língua, membros inferiores) com sensibilidade normal derruba a mielopatia como explicação: ENMG de quatro segmentos antes de operar.

Critérios de Gold Coast 2020 para ELA; AAN e EFNS (diagnóstico da doença do neurônio motor); AOSpine 2017 (mielopatia cervical degenerativa).

19

Infectologia · Raiva: profilaxia pós-exposição a morcego em pessoa com pré-exposição completa

Grade X / Y **Gabarito B**

Médica veterinária de 34 anos, com esquema completo de profilaxia pré-exposição antirrábica há 3 anos, é mordida no dorso da mão por um morcego durante captura em uma fazenda. A ferida foi lavada com água e sabão. Pelas normas do Ministério da Saúde, a indicação de soro (ou imunoglobulina) antirrábico e o número de doses de vacina são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

com esquema completo de profilaxia pré-exposição antirrábica há 3 anos

Resolução. Acidente com morcego é sempre classificado como grave, e para quem nunca foi vacinado a regra é soro (ou imunoglobulina) mais 4 doses de vacina, e é essa regra que o morcego evoca. A pré-exposição completa muda tudo: a pessoa já tem memória imunológica, a resposta anamnéstica à vacina é rápida e o soro, além de desnecessário, poderia atrapalhar a resposta. Por isso, para quem tem esquema pré-exposição completo, a reexposição pede apenas 2 doses de vacina (dias 0 e 3), sem soro, independentemente da gravidade do acidente e do animal.

A) Não indicado / 4 doses
Errada. Quatro doses sem soro seriam o esquema de quem não tem vacinação prévia em acidente que não exige soro; aqui bastam 2.

B) Não indicado / 2 doses CORRETA
Correta. Com pré-exposição completa, reexposição pede 2 doses (dias 0 e 3) e não indica soro.

C) Indicado / 4 doses ARMADILHA
Errada. É a armadilha: soro mais 4 doses é a conduta no acidente grave (como o de morcego) em quem não tem vacinação prévia; a pré-exposição completa dispensa o soro.

D) Indicado / 2 doses
Errada. O número de doses está certo, mas o soro não é indicado a quem tem pré-exposição completa.

Para levar. Pré-exposição antirrábica completa: na reexposição, 2 doses de vacina (dias 0 e 3) e nunca soro, mesmo em acidente grave com morcego.

Nota Técnica sobre a atualização da profilaxia pré, pós e reexposição da raiva humana no Brasil (MS, 2022).

20

Cronologia **Gabarito B**

Nefrologia · Hipercalemia com ECG alterado no dialítico faltoso · repetir o gluconato de cálcio enquanto o ECG não normaliza

Homem de 58 anos, em hemodiálise três vezes por semana por doença renal do diabetes, faltou às duas últimas sessões e chega com fraqueza nas pernas há seis horas. Exame: lúcido, PA 134/80 mmHg, FC 46 bpm, SpO2 95% em ar ambiente, sem estertores, edema 1+. ECG: ausência de onda P, QRS de 160 ms e ondas T apiculadas. Exames: potássio 7,6 mEq/L, glicemia 214 mg/dL, bicarbonato 17 mEq/L. Recebeu 30 mL de gluconato de cálcio a 10% IV em dez minutos e 10 UI de insulina regular com 25 g de glicose IV. Cinco minutos após o fim da infusão de cálcio, o ECG mantém QRS de 150 ms e FC de 48 bpm. A sala de hemodiálise estará disponível em 60 minutos. A conduta mais adequada neste momento é:

O DADO QUE DECIDE

o ECG mantém QRS de 150 ms

Resolução. O apressado acha que, feitos o cálcio e a insulina, resta esperar a diálise, que é o tratamento definitivo no anúrico. Mas o cálcio não baixa o potássio: ele estabiliza a membrana do miocárdio, age em 1 a 3 minutos e dura 30 a 60 minutos, e se o ECG não normaliza em 5 a 10 minutos após a dose a infusão deve ser repetida, porque o risco imediato é a parada em assistolia ou fibrilação ventricular, e não o número do potássio. A insulina começa a agir em 10 a 20 minutos, tem pico em 30 a 60, e repeti-la agora só aumenta o risco de hipoglicemia, que é frequente no renal crônico. O bicarbonato tem efeito pequeno e lento sobre o potássio, ainda menor no paciente em diálise, e não protege o miocárdio. Com QRS ainda de 150 ms e bradicardia, a prioridade é nova dose de gluconato de cálcio, enquanto se prepara a hemodiálise, que é o que remove o potássio de fato.

A) Bicarbonato de sódio a 8,4% IV
Errada. O bicarbonato desloca pouco potássio para dentro da célula, com latência longa e efeito ainda menor no dialítico; seria adjuvante na acidose grave, não a resposta a um QRS alargado persistente.

B) Nova dose de gluconato de cálcio CORRETA
Correta. ECG que continua alterado minutos após 30 mL de gluconato de cálcio exige repetir a dose; o cálcio é a única medida que protege o miocárdio em minutos.

C) Nova dose de insulina com glicose
Errada. A insulina já foi dada e está na latência; repetir não acelera a queda do potássio e aumenta a hipoglicemia.

D) Aguardar a hemodiálise monitorizado ARMADILHA
Errada, é a armadilha. A hemodiálise é o tratamento definitivo e deve ser preparada, mas esperar 60 minutos com QRS de 150 ms e bradicardia expõe o paciente a parada; a estabilização tem de ser mantida até lá.

Para levar. Na hipercalemia com ECG alterado, o gluconato de cálcio vem primeiro e se repete enquanto o ECG não normaliza; insulina e beta-2 agonista deslocam o potássio, só a diálise (ou o rim) o remove.

UK Kidney Association (Renal Association), Clinical Practice Guidelines: Treatment of Acute Hyperkalaemia in Adults (2020); KDIGO Controversies Conference on potassium (Kidney Int 2020); AHA ACLS 2020 (situações especiais).

21 Reumatologia · Artrite séptica sobreposta a gota: cristais no líquido não afastam infecção

Limiar **Gabarito B**

Homem de 63 anos, com gota tofácea há 12 anos em uso irregular de alopurinol, diabetes tipo 2 e doença renal crônica estágio 3a, procura atendimento por dor e edema no joelho direito há 2 dias, semelhante às crises anteriores, mas sem melhora com a colchicina tomada desde o início. Exame físico: T 38,2 °C, FC 104 bpm, joelho direito com derrame volumoso, calor e rubor, tofos em cotovelos. Exames: leucócitos 14.800/mm³, PCR 19 mg/dL, ácido úrico 9,1 mg/dL. Artrocentese: líquido turvo, 86.000 leucócitos/mm³ com 94% de neutrófilos, cristais de urato monossódico intracelulares em agulha com birrefringência negativa, Gram sem bactérias, cultura em andamento. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

86.000 leucócitos/mm³ com 94% de neutrófilos

Resolução. Os cristais de urato confirmados e a história de gota tofácea fazem parecer mais uma crise, e prednisona oral seria a escolha natural num renal crônico em que a colchicina falhou. Mas cristais e infecção coexistem, e a presença de um não afasta a outra. Contagem acima de 50.000 leucócitos com mais de 90% de neutrófilos, febre, falta de resposta à colchicina e um paciente diabético põem a artrite séptica na frente até a cultura dizer o contrário. O Gram é negativo em boa parte das artrites sépticas e não serve para excluí-la. A conduta é drenar a articulação (por punções repetidas, artroscopia ou cirurgia) e iniciar antibiótico venoso empírico com cobertura para estafilococo, ajustando pela cultura.

A) Prednisona oral e manter colchicina ARMADILHA
Errada. Seria a conduta na crise de gota de joelho com colchicina ineficaz e DRC; aqui a celularidade, a febre e o diabetes exigem tratar como infecção até a cultura sair.

B) Drenagem articular e antibiótico venoso CORRETA
Correta. Mais de 50.000 leucócitos com predomínio neutrofílico e febre são artrite séptica presumida, mesmo com cristais; drenagem e antibiótico venoso.

C) Corticoide intra-articular
Errada. É ótima opção na crise monoarticular de gota com infecção afastada; injetar corticoide numa articulação infectada piora a destruição.

D) Canaquinumabe subcutâneo
Errada. O anti-IL-1 é reserva para crises de gota quando colchicina, AINE e corticoide são contraindicados, e é contraindicado com infecção ativa.

Para levar. Cristal no líquido não exclui infecção: acima de 50.000 leucócitos com mais de 90% de neutrófilos, trate como séptica até a cultura negar.

ACR 2020 Guideline for the Management of Gout; BSR/BOA 2006 guideline for management of the hot swollen joint in adults; Kelley & Firestein's Textbook of Rheumatology, 11ª ed. (2021).

22 Endocrinologia · Tireotoxicose por amiodarona: tipo 2 pelo Doppler e tratamento

Grade X / Y **Gabarito D**

Homem de 67 anos, com miocardiopatia isquêmica (FE 35%) e taquicardia ventricular, usa amiodarona 200 mg/dia há três anos, além de carvedilol, sacubitril-valsartana e espironolactona. Há três semanas tem piora da dispneia, perda de 3 kg e retorno de palpitações. Função tireoidiana antes da amiodarona normal, com anti-TPO negativo e sem bócio. Exame: FC 108 bpm, irregular, PA 104/66 mmHg, tireoide de volume normal, indolor, sem nódulos. Exames: TSH abaixo de 0,01 µUI/mL, T4 livre 4,2 ng/dL (0,8 a 1,8), T3 total 190 ng/dL (80 a 200), TRAb negativo, VHS 22 mm/h. Ultrassonografia com Doppler: tireoide homogênea, de volume normal, com fluxo ausente. Captação de iodo radioativo em 24 horas: 1%. O mecanismo da tireotoxicose e o tratamento são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

tireoide homogênea, de volume normal, com fluxo ausente

Resolução. Tireotoxicose em usuário de amiodarona leva ao metimazol por reflexo, porque o iodo da droga é lembrado como combustível de síntese. Isso vale para o tipo 1, que ocorre em tireoide previamente doente (bócio nodular, Graves latente) e tem fluxo aumentado ao Doppler. Aqui a glândula era normal antes, segue sem bócio ou nódulos, o TRAb é negativo e o Doppler não mostra fluxo: é o tipo 2, uma tireoidite destrutiva pela toxicidade direta da amiodarona. A captação baixa não separa os dois tipos com segurança, porque a carga de iodo a reduz em ambos; o Doppler e a glândula prévia separam. O tratamento é prednisona (cerca de 0,5 mg/kg/dia), e a amiodarona pode ser mantida quando a arritmia exige, como na taquicardia ventricular.

A) Síntese aumentada / metimazol ARMADILHA
Errada. Seria o tipo 1, em bócio nodular ou Graves latente com Doppler hipervascular; tionamida não age na tireoide que está se destruindo.

B) Destruição folicular / metimazol
Errada. O mecanismo está certo, mas tionamida não reduz a liberação de hormônio pré-formado.

C) Síntese aumentada / prednisona
Errada. Combina o mecanismo do tipo 1 com o tratamento do tipo 2.

D) Destruição folicular / prednisona CORRETA
Correta. Glândula normal prévia, TRAb negativo e fluxo ausente ao Doppler definem o tipo 2, tratado com glicocorticoide.

Para levar. Tireotoxicose por amiodarona: glândula doente com fluxo aumentado é tipo 1 (tionamida); glândula normal com fluxo ausente é tipo 2 (prednisona). Captação baixa ocorre nos dois.

ATA Guidelines for Hyperthyroidism and Other Causes of Thyrotoxicosis 2016; European Thyroid Association Guidelines for amiodarone-associated thyroid dysfunction 2018.

---

23 Hematologia · Esferocitose hereditária no adulto jovem: Coombs direto negativo separa da anemia hemolítica autoimune

Negativo no meio **Gabarito D**

Homem de 23 anos é avaliado no pré-operatório de colecistectomia por colelitíase sintomática. Refere "olhos amarelados" em episódios desde a infância, que pioram nas gripes. A mãe foi esplenectomizada na juventude,

por motivo que ele desconhece. Usa apenas dipirona eventual. Exame: icterícia 1+/4, baço palpável a 3 cm do rebordo costal. Exames: Hb 11,2 g/dL, VCM 84 fL, CHCM 37,8 g/dL (VR 32 a 36), RDW 17%, reticulócitos 8%, LDH 410 U/L, bilirrubina indireta 3,1 mg/dL, haptoglobina 12 mg/dL (baixa), teste de Coombs direto negativo, dosagem de G6PD normal. Esfregaço: microesferócitos frequentes, sem esquizócitos. O diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

teste de Coombs direto negativo

Resolução. Esferócitos com hemólise extravascular puxam para anemia hemolítica autoimune quente, que é a causa adquirida mais comum de esferocitose no adulto. O negativo no meio dos exames decide: Coombs direto negativo. Somam-se hemólise desde a infância, colelitíase pigmentar aos 23 anos, mãe esplenectomizada e CHCM alto, que reflete a desidratação da hemácia esférica e é o índice hematimétrico que mais aponta esferocitose. A confirmação é feita pelo teste de ligação da eosina-5-maleimida (EMA) por citometria ou pela fragilidade osmótica, e a indicação de esplenectomia junto com a colecistectomia depende da gravidade. A deficiência de piruvato quinase não forma esferócitos, e Gilbert não tem reticulocitose nem haptoglobina baixa.

A) Deficiência de piruvato quinase
Errada. Seria a resposta em hemólise hereditária com Coombs negativo e esfregaço sem esferócitos, com hemácias espiculadas; CHCM alto não combina.

B) Anemia hemolítica autoimune quente ARMADILHA
Errada. É a armadilha: a AHAI quente forma esferócitos, mas teria Coombs direto positivo (IgG) e não explicaria hemólise desde a infância com mãe esplenectomizada.

C) Síndrome de Gilbert com colelitíase
Errada. Gilbert eleva bilirrubina indireta sem hemólise; reticulócitos de 8% e haptoglobina baixa provam hemólise.

D) Esferocitose hereditária CORRETA
Correta. Hemólise crônica com esferócitos, CHCM alto, história familiar e Coombs direto negativo é esferocitose hereditária.

Para levar. Esferócitos aparecem na esferocitose hereditária e na AHAI quente: o Coombs direto separa, e CHCM alto com história familiar fecha esferocitose (confirmar com EMA).

BSH guidelines for the diagnosis and management of hereditary spherocytosis, atualização 2011 (Bolton-Maggs et al., Br J Haematol 2012); ICSH 2015 para diagnóstico laboratorial dos distúrbios de membrana eritrocitária (King et al.).

---

24 Hepatologia · Doença hepática crônica avançada compensada: carvedilol pela elastografia, sem endoscopia de rastreio (Baveno VII)

Limiar Gabarito A

Homem de 57 anos, com doença hepática por álcool, abstinente há 2 anos, hipertenso em uso de losartana, é encaminhado após elastografia hepática transitória de 27 kPa, confirmada em segunda medida em jejum. Nunca teve ascite, icterícia, encefalopatia ou sangramento. Exame: PA 142 × 88 mmHg, FC 82 bpm, IMC 25 kg/m², sem estigmas de hepatopatia, baço não palpável. Exames: plaquetas 138.000/mm³, albumina 4,0 g/dL, bilirrubina 0,9 mg/dL, INR 1,1, creatinina 0,9 mg/dL. Ultrassonografia: fígado de contornos levemente irregulares, sem ascite e

sem nódulos. Não há contraindicação a betabloqueador. Para prevenir a primeira descompensação, a conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

elastografia hepática transitória de 27 kPa

Resolução. O reflexo é pedir endoscopia para procurar varizes antes de decidir, que era a regra antiga. O Baveno VII mudou o alvo: na doença hepática crônica avançada compensada, elastografia de 25 kPa ou mais confirma hipertensão portal clinicamente significativa (em etiologia viral, alcoólica e metabólica sem obesidade), e o betabloqueador não seletivo, preferencialmente o carvedilol, reduz o risco de primeira descompensação (estudo PREDESCI), e não só de sangramento. Quem vai usar betabloqueador não precisa de endoscopia de rastreio, porque o resultado não muda a conduta; a endoscopia fica para quem não pode ou não tolera betabloqueador, para decidir por ligadura. As plaquetas de 138.000 não mudam nada: o corte de plaquetas acima de 150.000 com elastografia abaixo de 20 kPa serve para dispensar rastreio, e não para indicar tratamento.

A) Carvedilol, sem endoscopia de rastreio CORRETA
Correta. Elastografia de 27 kPa confirma hipertensão portal clinicamente significativa; carvedilol previne descompensação e dispensa endoscopia de rastreio.

B) Endoscopia para rastrear varizes ARMADILHA
Errada. É a isca: seria o passo em quem tem contraindicação ou intolerância a betabloqueador, para indicar ligadura; aqui o carvedilol cabe e a endoscopia não muda a conduta.

C) Repetir elastografia em 12 meses
Errada. Repetir elastografia anualmente é o seguimento de quem não tem hipertensão portal confirmada; 27 kPa já decide.

D) Ligadura elástica após endoscopia
Errada. Ligadura profilática é para varizes de alto risco em quem não usa betabloqueador; não é a conduta inicial com elastografia de 27 kPa e betabloqueador possível.

Para levar. Na doença hepática avançada compensada, elastografia de 25 kPa ou mais indica carvedilol para prevenir descompensação, sem endoscopia de rastreio em quem vai usar betabloqueador.

Baveno VII (2022); AASLD Practice Guidance on risk stratification and management of portal hypertension and varices in cirrhosis (2024)

---

25 Pneumologia · Derrame pleural: pseudoexsudato por diurético reclassificado pelos gradientes

Limiar | Gabarito A

Homem de 74 anos, com cardiomiopatia isquêmica (fração de ejeção de 30%), está internado há 5 dias por dispneia aos mínimos esforços, ortopneia e edema de membros inferiores. Recebe furosemida venosa em dose dobrada desde a admissão, com perda de 6 kg, mas persiste derrame pleural à direita, de volume moderado. Nega febre, tosse produtiva e perda de peso. Exame: PA 108 × 66 mmHg, FC 84 bpm, SpO2 94% em ar ambiente, estertores finos em bases, edema residual em tornozelos. Toracocentese diagnóstica: líquido citrino, proteína 3,3 g/dL, LDH 170 U/L, albumina 1,5 g/dL, glicose 112 mg/dL, pH 7,46, 620 células/mm³ (70% linfócitos e

25% células mesoteliais), ADA 9 U/L. Sangue: proteína total 6,5 g/dL, albumina 3,0 g/dL, LDH 260 U/L (limite superior da normalidade 250 U/L). A interpretação mais adequada do líquido pleural é:

O DADO QUE DECIDE

albumina 1,5 g/dL

Resolução. Os três critérios de Light dão exsudato por pouco (proteína 0,51, LDH 0,65 e LDH pleural de 170, acima de dois terços de 250), e o líquido linfocítico convida a investigar tuberculose ou neoplasia. Mas o paciente está no quinto dia de diurético venoso com 6 kg perdidos, e o diurético retira água do espaço pleural mais depressa que proteína e LDH, empurrando um transudato para a faixa de exsudato. Nessa situação o desempate é o gradiente soro menos líquido: albumina 3,0 menos 1,5 dá 1,5 g/dL (acima de 1,2) e proteína 6,5 menos 3,3 dá 3,2 g/dL (acima de 3,1), os dois indicando transudato. ADA de 9, glicose e pH normais e ausência de febre ou perda de peso completam o quadro de derrame da insuficiência cardíaca. O passo seguinte é otimizar o tratamento da IC, sem biópsia nem toracoscopia.

A) Transudato concentrado pelo diurético CORRETA
Correta. Light limítrofe sob diurético, com gradiente de albumina de 1,5 g/dL e de proteína de 3,2 g/dL: pseudoexsudato da insuficiência cardíaca.

B) Transudato por hipoalbuminemia
Errada. É transudato, mas albumina sérica de 3,0 g/dL não explica derrame isolado; hipoalbuminemia grave (nefrose, cirrose) daria derrame bilateral e anasarca, e aqui há IC descompensada com congestão.

C) Exsudato por neoplasia pleural
Errada. Neoplasia daria exsudato verdadeiro, com gradiente de albumina abaixo de 1,2, em geral perda de peso e LDH mais alto; nada disso está presente.

D) Exsudato linfocítico a esclarecer ARMADILHA
Errada, e é a armadilha. Seria a leitura certa sem diurético ou com gradiente de albumina até 1,2; aqui os dois gradientes reclassificam o líquido como transudato e a celularidade linfocítica é a esperada no derrame crônico da IC.

Para levar. Exsudato limítrofe em paciente sob diurético se reclassifica pelo gradiente soro menos líquido: albumina acima de 1,2 g/dL ou proteína acima de 3,1 g/dL indicam transudato.

BTS Guideline for pleural disease 2023; Light RW, Pleural Diseases, 6ª ed. (2013)

---

26 Infectologia · Dengue no idoso com comorbidades: hipotensão postural como sinal de alarme

Rótulo verdadeiro **Gabarito B**

Mulher de 71 anos, hipertensa e diabética, em uso de losartana e metformina, procura a UPA no 5º dia de febre, cefaleia, mialgia e dor retro-orbitária, com NS1 reagente no 2º dia. A febre cedeu ontem. Refere náuseas, aceita líquidos e nega sangramentos, vômitos, dor abdominal ou dispneia. Ao levantar-se da maca para ir ao banheiro, teve escurecimento visual e precisou sentar. Exame: T 36,6 °C, FC 92 bpm; PA 128 × 78 mmHg deitada e 104 x 70 mmHg após 3 minutos em pé, com FC de 118 bpm; enchimento capilar de 2 segundos, extremidades quentes, fígado não palpável, sem derrames clinicamente detectáveis; prova do laço negativa. Hematócrito 41% (basal desconhecido), plaquetas 62.000/mm³, creatinina 1,0 mg/dL. Segundo o Ministério da Saúde, a classificação de risco desta paciente é:

O DADO QUE DECIDE

104 × 70 mmHg após 3 minutos em pé, com FC de 118 bpm

Resolução. Idade acima de 65 anos, hipertensão e diabetes são condições que, por si, colocam a paciente no grupo B, e é aí que o rótulo verdadeiro para a leitura. Mas a classificação sobe pelo pior achado, e o caso traz um sinal de alarme no meio da história e do exame: hipotensão postural (lipotimia ao levantar, queda de 24 mmHg na sistólica e FC de 118 bpm em pé), no momento de maior risco, a defervescência do 5º dia. Sinal de alarme define grupo C: internação, expansão volêmica venosa imediata com cristaloide (10 mL/kg na primeira hora no manual de 2024), reavaliação clínica e do hematócrito após a etapa. Não é grupo D porque não há choque: PA deitada normal, perfusão periférica preservada, sem pressão convergente ou hipotensão em repouso. Plaquetas de 62.000 não mudam o grupo e não indicam transfusão.

A) Grupo D, por choque
Errada. Grupo D exige sinais de choque ou de gravidade (hipotensão em repouso, PA convergente, má perfusão, sangramento grave); a PA deitada e a perfusão estão normais.

B) Grupo C, por sinal de alarme CORRETA
Correta. Hipotensão postural com lipotimia é sinal de alarme e define o grupo C, com internação e hidratação venosa.

C) Grupo B, pela idade e comorbidades ARMADILHA
Errada. É a armadilha: idade e comorbidades seriam grupo B na ausência de sinais de alarme; a hipotensão postural sobe a paciente para o grupo C.

D) Grupo A, sem sinais de alarme
Errada. Grupo A é para quem não tem sinal de alarme, comorbidade nem condição de risco; ela tem as duas coisas.

Para levar. Na dengue, o grupo é definido pelo pior achado: sinal de alarme (inclusive hipotensão postural ou lipotimia) passa à frente da idade e da comorbidade e define o grupo C.

Dengue: diagnóstico e manejo clínico, adulto e criança (MS, 6ª edição, 2024).

27

Neurologia · Encefalopatia de Wernicke após gastrectomia vertical, sem álcool: tiamina IV em dose alta antes da glicose

Cronologia **Gabarito B**

Mulher de 34 anos, 10 semanas após gastrectomia vertical, é admitida por vômitos persistentes há 3 semanas, com perda de 14 kg no período. Nega uso de álcool e de outras substâncias. Há 4 dias está confusa e desatenta, e há 2 dias tem dificuldade para andar e visão dupla. Exame: PA 100/64 mmHg, FC 108 bpm, desidratada, nistagmo horizontal no olhar lateral bilateral, paresia do reto lateral direito, marcha atáxica de base alargada, sem rigidez de nuca. Glicemia capilar 58 mg/dL, sódio 134 mEq/L, potássio 2,9 mEq/L, magnésio 1,2 mg/dL (VR 1,7 a 2,4). A conduta inicial mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

vômitos persistentes há 3 semanas

Resolução. Sem álcool, o rótulo de Wernicke some, e o apressado corrige a glicemia e pede imagem. Mas a reserva corporal de tiamina dura de 2 a 3 semanas, e 3 semanas de vômitos após cirurgia bariátrica bastam

para esgotá-la. Confusão, nistagmo, paresia do VI e ataxia de marcha completam a tríade, que aparece inteira em menos de um terço dos casos. A conduta é tiamina IV em dose alta (500 mg três vezes ao dia por 2 a 3 dias, depois 250 mg) imediatamente, antes ou junto da glicose, porque a carga de glicose consome a tiamina restante e pode precipitar ou agravar a lesão; a hipoglicemia é corrigida em seguida, sem esperar exame. O magnésio baixo também precisa ser reposto, porque é cofator da transcetolase e sem ele a tiamina não age. A RM pode mostrar hipersinal periaquedutal e talâmico medial, mas é normal em boa parte dos casos e não deve atrasar o tratamento.

A) Tiamina 100 mg oral diária
Errada. Tiamina oral em dose baixa serve para prevenção ou manutenção; com vômitos e quadro neurológico instalado a absorção é incerta e a dose é insuficiente.

B) Tiamina 500 mg IV antes da glicose CORRETA
Correta. Tiamina IV em dose alta imediatamente, antes da glicose, com reposição de magnésio, na paciente com 3 semanas de vômitos após bariátrica e a tríade completa.

C) Punção lombar e aciclovir empírico
Errada. Seria a conduta na suspeita de encefalite herpética (febre, crise, alteração temporal); aqui não há febre nem sinais meníngeos, e o quadro é carencial.

D) Glicose IV e RM de encéfalo ARMADILHA
Errada, é a armadilha. Dar glicose sem tiamina pode precipitar a lesão, e a RM normal não afasta Wernicke; o diagnóstico é clínico e o tratamento não espera imagem.

Para levar. Wernicke não exige álcool: vômitos por mais de 2 a 3 semanas (bariátrica, hiperêmese, desnutrição) esgotam a tiamina. Tratar com 500 mg IV antes da glicose, sem esperar RM, e repor magnésio.

EFNS 2010 (encefalopatia de Wernicke); ASMBS 2019 (micronutrientes após cirurgia bariátrica); Royal College of Physicians.

---

28 Cardiologia · Marca-passo recém-implantado: perda de captura com rótulo de síncope ortostática

Rótulo verdadeiro | Gabarito B

Homem de 74 anos recebeu marca-passo definitivo unicameral ventricular (VVI, frequência programada de 70 bpm) há 3 semanas por bloqueio atrioventricular total. Há 10 dias iniciou tansulosina por hiperplasia prostática. É trazido após dois episódios de perda de consciência em 3 dias, o último ao levantar-se à noite para urinar, com recuperação em segundos e sem pródromos. PA 112×60 mmHg deitado e 108×58 mmHg em pé, FC 35 bpm. ECG: espículas de marca-passo regulares a cada 857 ms; complexos QRS largos a 35 bpm, cada um logo após uma espícula; ondas P dissociadas dos QRS. Potássio 4,3 mEq/L. A interpretação do traçado é:

O DADO QUE DECIDE
complexos QRS largos a 35 bpm, cada um logo após uma espícula

Resolução. A tansulosina, a nictúria e a síncope ao levantar compõem um rótulo verdadeiro de hipotensão ortostática, e o traçado convida à leitura apressada: todo QRS vem logo depois de uma espícula, então o marca-passo funciona. Mas a PA não cai em pé, e a conta do ECG desmonta a leitura: espículas a cada 857 ms são 70 por minuto, exatamente a frequência programada, e os QRS são 35 por minuto. Metade das espículas, portanto, não despolariza o ventrículo, e isso é falha de captura. Falha de sensibilidade seria

espícula caindo sobre QRS próprios ou na onda T, e sensibilidade excessiva seria pausa sem espícula alguma, com o aparelho inibido por sinal espúrio. Três semanas após o implante, a causa mais provável de perda de captura é deslocamento do eletrodo (ou aumento de limiar na interface), e a conduta é interrogar o aparelho e reposicionar o eletrodo. Em portador de marca-passo com síncope, a causa cardíaca vem antes de qualquer hipótese reflexa ou ortostática.

A) Falha de sensibilidade (undersensing)
Errada. Na falha de sensibilidade o aparelho ignora o ritmo próprio e dispara espículas sobre QRS ou ondas T nativas; não há QRS próprio neste traçado.

B) Falha de captura ventricular CORRETA
Correta. Espículas a 70 por minuto e QRS a 35, cada QRS logo após uma espícula: metade das espículas não captura. No primeiro mês após o implante, o deslocamento do eletrodo é a causa principal.

C) Marca-passo com função normal ARMADILHA
Errada, e é a armadilha. Todo QRS vir após uma espícula não basta: função normal exige um QRS após cada espícula; espículas a 70 por minuto com QRS a 35 significam que metade não captura.

D) Sensibilidade excessiva (oversensing)
Errada. Na sensibilidade excessiva o aparelho se inibe por miopotenciais ou interferência e surgem pausas sem espícula; aqui as espículas estão todas no intervalo programado.

Para levar. Espícula sem QRS é falha de captura; espícula sobre ritmo próprio é falha de sensibilidade; pausa sem espícula é sensibilidade excessiva. Síncope em portador de marca-passo é cardíaca até prova em contrário.

ESC 2021 (cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy); Diretriz Brasileira de Dispositivos Cardíacos Eletrônicos Implantáveis (SBC)

29

Nefrologia · Elevação da creatinina após iniciar inibidor de SGLT2 · queda hemodinâmica esperada e manutenção da droga

Grade X / Y **Gabarito B**

Homem de 63 anos, com diabetes tipo 2 e doença renal crônica (TFGe 38 mL/min/1,73 m², relação albumina/creatinina 620 mg/g), em uso de losartana 100 mg/dia, metformina 500 mg duas vezes ao dia e anlodipino, iniciou empagliflozina 10 mg/dia há quatro semanas. Sem diarreia, vômitos, anti-inflamatório ou contraste. Exame: PA 126/78 mmHg (era 136/82), sem hipotensão postural, sem edema, perdeu 1,5 kg. Exames: creatinina de 1,90 para 2,20 mg/dL (TFGe 32), potássio 4,7 mEq/L (era 5,0), bicarbonato 23 mEq/L, hemoglobina de 12,6 para 13,1 g/dL, urina sem hematúria ou leucocitúria. A explicação para a variação da creatinina e a conduta são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

creatinina de 1,90 para 2,20 mg/dL

Resolução. Creatinina subindo e TFGe caindo de 38 para 32 logo após começar um remédio parecem lesão renal, e a reação é suspender a droga, erro que ele já cometeu com o iSGLT2. Os inibidores de SGLT2 aumentam a oferta de sódio à mácula densa, restauram o feedback tubuloglomerular e contraem a arteríola aferente: a pressão intraglomerular cai e, com ela, a filtração, numa queda esperada de 3 a 6 mL/min nas primeiras semanas. É essa queda hemodinâmica que protege o rim a longo prazo. Sem depleção (sem

diarreia, sem hipotensão postural), sem nefrotóxico e com sedimento limpo, a elevação de cerca de 16% é a esperada; o potássio que caiu e a hemoglobina que subiu são outros efeitos de classe. A KDIGO 2024 orienta não suspender pela queda inicial e manter até a diálise; a metformina, com TFGe entre 30 e 45, fica em no máximo 1.000 mg/dia, a dose que ele já usa.

A) Queda hemodinâmica da filtração / suspender a empagliflozina ARMADILHA
Errada, é a armadilha. O mecanismo está certo, mas suspender pela queda inicial joga fora a nefroproteção; só se reavalia com elevação acima de 30% ou depleção de volume.

B) Queda hemodinâmica da filtração / manter a empagliflozina CORRETA
Correta. Elevação de cerca de 16% da creatinina nas primeiras semanas de iSGLT2, sem depleção, é hemodinâmica e esperada; a droga deve ser mantida.

C) Lesão tubular aguda / suspender a empagliflozina
Errada. Lesão tubular aguda exigiria um insulto (depleção, nefrotóxico, hipotensão) e traria sedimento com cilindros granulosos ou células tubulares; nada disso existe.

D) Lesão tubular aguda / manter a empagliflozina
Errada. Manter seria certo, mas o mecanismo não é lesão tubular; se fosse, a droga teria de ser revista.

Para levar. A queda inicial da TFGe com iSGLT2 (como com IECA ou BRA) é hemodinâmica e nefroprotetora: mantenha a droga e reavalie só com elevação da creatinina acima de 30% ou depleção de volume.

KDIGO 2024 (Evaluation and Management of CKD); KDIGO 2022 (Diabetes Management in CKD); EMPA-KIDNEY (NEJM 2023).

30

Oncologia · Dispneia refratária no câncer avançado com DPOC hipercápnica: morfina em dose baixa

Rótulo verdadeiro **Gabarito A**

Homem de 74 anos com carcinoma pulmonar de não pequenas células metastático, em cuidados exclusivamente paliativos após progressão em duas linhas de tratamento, tem DPOC (VEF1 de 38% do previsto) com PaCO2 basal de 52 mmHg. Está internado por dispneia em repouso, progressiva há 2 semanas, sem febre ou escarro purulento. Já tratados: derrame pleural drenado com pleurodese, broncodilatadores otimizados, ventilador direcionado ao rosto e posicionamento. Exame: lúcido, FR 30 irpm, SpO2 92% com cateter nasal a 2 L/min, sem sibilos, PA 118 × 72 mmHg; PPS 30%. Gasometria: pH 7,37, PaCO2 54 mmHg, bicarbonato 31 mEq/L. Refere a dispneia como 8 em 10 e pede alívio. A conduta mais adequada para o sintoma é:

O DADO QUE DECIDE

Já tratados: derrame pleural drenado com pleurodese, broncodilatadores otimizados, ventilador direcionado ao rosto e posicionamento

Resolução. DPOC com PaCO2 de 54 mmHg é o rótulo que faz evitar opioide. Nas doses usadas para dispneia (morfina oral de 2,5 a 5 mg a cada 4 horas, ou cerca de 10 mg/dia de liberação prolongada, titulada), o opioide reduz a percepção de falta de ar sem depressão respiratória clinicamente relevante, inclusive na DPOC grave com hipercapnia crônica compensada (pH 7,37). As causas reversíveis já foram tratadas (derrame drenado, broncodilatador otimizado) e as medidas não farmacológicas já foram feitas: a dispneia é refratária e o próximo degrau é o opioide. Aumentar o oxigênio com SpO2 de 92% não alivia a dispneia e, no

hipercápnico, pode piorar a retenção de CO2; benzodiazepínico não é primeira linha e fica para ansiedade associada, depois do opioide.

A) Morfina oral em dose baixa, titulada CORRETA
Correta. Dispneia refratária com causas reversíveis tratadas: morfina oral em dose baixa e titulada, segura mesmo na DPOC hipercápnica compensada.

B) Aumentar o oxigênio para 5 L/min
Errada. Oxigênio alivia quando corrige hipoxemia; com SpO2 de 92% não há ganho sintomático e, no retentor de CO2, há risco de piorar a hipercapnia.

C) Evitar opioide pela hipercapnia ARMADILHA
Errada. É a isca: hipercapnia crônica compensada não contraindica opioide em dose de dispneia, e evitar o opioide deixa o sintoma sem tratamento.

D) Diazepam como primeira linha
Errada. Benzodiazepínico tem papel na ansiedade associada e como segunda linha; não substitui o opioide como primeira escolha para dispneia.

Para levar. Dispneia refratária no câncer avançado, com ou sem DPOC hipercápnica: morfina em dose baixa e titulada é a primeira linha; oxigênio só alivia quem está hipoxêmico.

ASCO Guideline: Management of Dyspnea in Advanced Cancer (2021); ATS Official Statement: Update on the Mechanisms, Assessment, and Management of Dyspnea (2012); GOLD 2025

---

31 Reumatologia · Doença relacionada à IgG4 com dacrioadenite e periaortite: a histologia que confirma

Dado omitido **Gabarito D**

Homem de 64 anos, ex-tabagista, procura atendimento por aumento indolor e bilateral das pálpebras superiores há 8 meses, com olhos secos, e dor lombar surda há 3 meses. Tem asma de início há 2 anos e rinossinusite crônica. Nega febre, sudorese noturna, epistaxe, hemoptise, parestesias e lesões de pele. Exame físico: glândulas lacrimais aumentadas, endurecidas e indolores, submandibulares discretamente aumentadas, PA 146 x 90 mmHg, sem linfonodomegalias periféricas. Exames: creatinina 1,9 mg/dL (1,0 há 1 ano), eosinófilos 820/mm³, IgE total 1.100 UI/mL, VHS 64 mm/h, PCR 0,6 mg/dL, c-ANCA e p-ANCA não reagentes, FAN, anti-Ro e anti-La não reagentes, gamaglobulina policlonal de 2,9 g/dL. TC: tecido de partes moles envolvendo a aorta abdominal infrarrenal e as artérias ilíacas, com hidronefrose bilateral, e glândulas lacrimais aumentadas, sem erosão óssea. Na biópsia da glândula lacrimal, o achado esperado é:

O DADO QUE DECIDE

tecido de partes moles envolvendo a aorta abdominal infrarrenal e as artérias ilíacas

Resolução. Asma de início tardio, rinossinusite e eosinofilia são verdadeiras e puxam para granulomatose eosinofílica com poliangeíte; a massa orbitária puxa para granulomatose com poliangeíte. Mas não há vasculite: sem mononeurite, púrpura, glomerulonefrite ou hemoptise, ANCA negativo e nenhuma erosão óssea. O conjunto de dacrioadenite e sialadenite bilaterais indolores, periaortite com fibrose retroperitoneal causando hidronefrose, homem idoso, gamaglobulina policlonal alta, VHS alta com PCR quase normal e eosinofilia com IgE alta, que são comuns na doença, é doença relacionada à IgG4. A IgG4 sérica foi omitida de propósito: ela é normal em parte dos casos e alta em mimetizadores, e o diagnóstico é histológico. A

tríade da biópsia é infiltrado linfoplasmocitário denso, fibrose estoriforme e flebite obliterante, com plasmócitos IgG4 positivos aumentados e relação IgG4/IgG acima de 40%. O tratamento é glicocorticoide, com resposta rápida, e a hidronefrose pode exigir cateter ureteral.

A) Granulomas necrosantes com vasculite
Errada. Seria o achado na granulomatose com poliangeíte orbitária, que costuma erodir osso e vir com ANCA anti-PR3 e lesão de via aérea destrutiva.

B) Infiltrado eosinofílico com vasculite necrosante ARMADILHA
Errada. Seria a granulomatose eosinofílica com poliangeíte, mas aqui não há vasculite clínica; eosinofilia e IgE altas também ocorrem na doença por IgG4.

C) Infiltrado linfocítico focal periductal
Errada. É o padrão da síndrome de Sjögren, que tem anti-Ro e anti-La reagentes e não causa periaortite nem fibrose retroperitoneal.

D) Fibrose estoriforme e flebite obliterante CORRETA
Correta. Dacrioadenite, sialadenite e periaortite com hidronefrose em homem idoso: a histologia da doença por IgG4 é fibrose estoriforme e flebite obliterante com plasmócitos IgG4.

Para levar. Doença por IgG4 se confirma na biópsia (linfoplasmócitos, fibrose estoriforme, flebite obliterante), não na IgG4 sérica. Eosinofilia e IgE alta fazem parte dela e não mudam o diagnóstico para vasculite.

ACR/EULAR 2019 classification criteria for IgG4-related disease; Consensus statement on the pathology of IgG4-related disease (Deshpande, 2012); International Consensus Guidance Statement on management of IgG4-RD (2015).

---

32 Hematologia · Hematoma subdural com craniotomia de urgência em plaquetopenia de quimioterapia: alvo de 100.000 plaquetas

Limiar **Gabarito B**

Homem de 68 anos, em quimioterapia com carboplatina e etoposídeo por carcinoma de pulmão de pequenas células, está no 12º dia do ciclo. Caiu da própria altura há 6 horas e evolui com sonolência e hemiparesia esquerda. Não usa antiagregantes nem anticoagulantes. Exame: Glasgow 12, pupilas isocóricas, PA 150 × 86 mmHg. Tomografia: hematoma subdural agudo frontoparietal direito com 14 mm de espessura e desvio da linha média de 8 mm; a neurocirurgia indica craniotomia de urgência. Exames: Hb 10,1 g/dL, leucócitos 2.400/mm³, plaquetas 64.000/mm³, INR 1,1, TTPa 31 s (controle 30 s), fibrinogênio 310 mg/dL. Em relação à hemostasia, a conduta mais adequada antes da cirurgia é:

O DADO QUE DECIDE
a neurocirurgia indica craniotomia de urgência

Resolução. O número de 64.000 plaquetas está acima de 50.000, o limiar que o candidato memoriza para cirurgia de grande porte, e o apressado libera a operação sem transfusão. O limiar, porém, depende do sítio: em neurocirurgia e cirurgia do segmento posterior do olho, onde um sangramento pequeno é catastrófico e não comprimível, as diretrizes indicam manter plaquetas acima de 100.000/mm³. O dado que decide é o procedimento, uma craniotomia de urgência, num paciente cuja plaquetopenia é de produção (nadir da quimioterapia), situação em que a transfusão rende bem. O coagulograma e o fibrinogênio estão normais, então plasma não tem indicação, e a desmopressina serve para von Willebrand, hemofilia A leve e disfunção

plaquetária urêmica, não para plaquetopenia. É o contraponto da regra de não transfundir: o limiar sobe quando o sítio exige.

A) Operar sem transfusão ARMADILHA
Errada. É a armadilha: 64.000 bastaria para cirurgia de grande porte fora do sistema nervoso central; em craniotomia o alvo é acima de 100.000.

B) Plaquetas até acima de 100.000 CORRETA
Correta. Neurocirurgia exige plaquetas acima de 100.000/mm³; com plaquetopenia de produção, transfunde-se antes e confere a contagem.

C) Plasma fresco congelado antes
Errada. Plasma corrige deficiência de fatores, e INR, TTPa e fibrinogênio estão normais.

D) Desmopressina antes da incisão
Errada. A desmopressina libera fator de von Willebrand e ajuda na uremia e na hemofilia A leve, mas não corrige plaquetopenia.

Para levar. Limiar de plaquetas por procedimento: acima de 50.000 para cirurgia de grande porte e acima de 100.000 para neurocirurgia e cirurgia ocular posterior.

BSH 2017 guidelines for the use of platelet transfusions (Estcourt et al.); Ministério da Saúde, Guia para uso de hemocomponentes (2ª edição, 2015).

---

33 Endocrinologia · Hiperparatireoidismo primário assintomático: critério densitométrico no rádio

Limiar **Gabarito B**

Mulher de 63 anos, assintomática, tem hipercalcemia descoberta em exames de rotina e persistente em três dosagens. Nega nefrolitíase, fraturas, uso de tiazídico, lítio ou suplemento de cálcio. Exames: cálcio total 10,8 mg/dL (8,5 a 10,2), albumina 4,2 g/dL, fósforo 2,6 mg/dL, PTH 98 pg/mL (15 a 65), 25-hidroxivitamina D 36 ng/mL, creatinina 0,8 mg/dL (TFG estimada 82 mL/min/1,73 m²), cálcio urinário de 24 horas 240 mg, relação de depuração cálcio/creatinina 0,021. Ultrassonografia renal sem cálculos ou nefrocalcinose. Radiografia de coluna sem fraturas vertebrais. Densitometria: T-score de -1,9 em coluna lombar, -1,6 em colo femoral e -2,7 no terço distal do rádio. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE
-2,7 no terço distal do rádio

Resolução. Paciente assintomática, com cálcio apenas 0,6 mg/dL acima do limite, função renal normal, sem cálculos e com coluna e fêmur em osteopenia: a leitura apressada conclui que ela não preenche critério cirúrgico e opta por vigiar. O limiar que decide está no sítio esquecido da densitometria: T-score igual ou menor que -2,5 em qualquer sítio, incluindo o terço distal do rádio, é indicação de cirurgia. O rádio distal é osso cortical, justamente o compartimento que o PTH mais consome, por isso ele aparece no critério. Os outros critérios (cálcio mais de 1 mg/dL acima do limite, TFG abaixo de 60, calciúria acima de 250 mg em mulher com risco de cálculo, nefrolitíase, fratura vertebral, idade abaixo de 50) não estão presentes, mas basta um. A relação de depuração de 0,021 afasta hipercalcemia hipocalciúrica familiar.

A) Cinacalcete e seguimento
Errada. Cinacalcete controla o cálcio de quem não pode ou não quer operar, mas não melhora a massa óssea.

B) Paratireoidectomia CORRETA
Correta. T-score de -2,5 ou menor em qualquer sítio, incluindo o terço distal do rádio, indica paratireoidectomia no hiperparatireoidismo primário assintomático.

C) Alendronato e nova densitometria
Errada. Bifosfonato é opção para quem tem indicação e não pode operar; com cirurgia possível, ela é o tratamento que cura e recupera osso.

D) Seguimento clínico com densitometria anual ARMADILHA
Errada. Seria a conduta sem nenhum critério; o T-score de -2,7 no rádio já é critério cirúrgico.

Para levar. No hiperparatireoidismo primário assintomático, olhe os três sítios da densitometria: T-score de -2,5 ou menor no terço distal do rádio já indica cirurgia.

Fifth International Workshop on Primary Hyperparathyroidism (J Bone Miner Res 2022); AAES Guidelines for Primary Hyperparathyroidism 2016.

---

34 Pneumologia · Crise grave de asma com escarro amarelado: magnésio intravenoso, sem antibiótico

Rótulo verdadeiro **Gabarito A**

Mulher de 31 anos, com asma desde a infância, chega à emergência com dispneia intensa há 10 horas, iniciada após quadro gripal de 4 dias, com tosse e escarro amarelado espesso. Usa budesonida-formoterol apenas quando tem falta de ar. Fala frases curtas, está sentada inclinada para frente, com uso de musculatura acessória. T 37,2 °C, FC 124 bpm, FR 30 irpm, SpO2 90% em ar ambiente, sibilos difusos, murmúrio simétrico. Pico de fluxo 35% do previsto. Radiografia de tórax: hiperinsuflação, sem consolidação. Após uma hora de salbutamol e ipratrópio inalatórios repetidos, oxigênio e metilprednisolona venosa, o pico de fluxo é de 40%, FR 28 irpm, e ela ainda fala frases curtas, consciente. Gasometria com O2: pH 7,40, PaCO2 41 mmHg, PaO2 68 mmHg. Além de manter o tratamento, a medida mais adequada neste momento é:

O DADO QUE DECIDE
Radiografia de tórax: hiperinsuflação, sem consolidação

Resolução. Escarro amarelado e espesso depois de um quadro gripal puxa para antibiótico, mas a causa mais comum da crise é viral, e escarro amarelo na asma costuma ser eosinofílico: sem febre e sem consolidação na radiografia não há indicação de antibiótico (GINA). O que importa é a gravidade: pico de fluxo de 40% após uma hora de tratamento máximo e PaCO2 de 41 numa paciente taquipneica, que deveria estar hipocápnica, é sinal de fadiga. Nessa situação, a recomendação é sulfato de magnésio venoso (2 g em 20 minutos), que reduz internação nos que não respondem ao tratamento inicial, e admissão em unidade intensiva. Intubação está indicada por rebaixamento, exaustão ou parada iminente, e ela está consciente e falando. Aminofilina acrescenta toxicidade sem benefício sobre o broncodilatador inalatório.

A) Sulfato de magnésio intravenoso CORRETA
Correta. Crise grave com pico de fluxo de 40% após uma hora de tratamento: magnésio venoso, com vigilância em UTI pela PaCO2 normal.

B) Amoxicilina-clavulanato ARMADILHA

Errada, e é a armadilha. Antibiótico na crise de asma só com evidência forte de infecção bacteriana (febre com escarro purulento, consolidação na radiografia); escarro amarelo depois de quadro viral, sem febre e sem consolidação, não basta.

C) Intubação orotraqueal imediata

Errada por enquanto. Seria a conduta com rebaixamento de consciência, exaustão, silêncio respiratório ou PaCO2 em ascensão com acidose; ela está consciente, falando e com pH normal.

D) Aminofilina intravenosa

Errada. Aminofilina não acrescenta broncodilatação ao beta-agonista inalatório e tem toxicidade (arritmia, convulsão); não é recomendada pela GINA.

Para levar. Na crise grave que não responde à primeira hora, o adjuvante é o magnésio venoso; escarro amarelo pós-viral, sem febre e sem consolidação, não indica antibiótico.

GINA 2024 (manejo da exacerbação); Recomendações SBPT para o manejo da asma 2020

---

35 Infectologia · Meningite bacteriana: quando a TC de crânio não deve preceder a punção lombar

Negativo no meio | Gabarito A

Homem de 58 anos, hipertenso em uso de anlodipino, é trazido ao pronto-socorro por febre alta, cefaleia intensa holocraniana e vômitos iniciados há 18 horas. Exame: T 39,3 °C, FC 112 bpm, PA 146 × 88 mmHg, Glasgow 15, orientado, rigidez de nuca e sinal de Kernig presentes, pupilas isocóricas e fotorreagentes, sem papiledema à fundoscopia, sem déficit motor ou de pares cranianos. Não há história de crise convulsiva, de doença neurológica prévia, de imunossupressão ou de trauma craniano. Hemoculturas colhidas. O próximo passo mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

sem papiledema à fundoscopia, sem déficit motor ou de pares cranianos

Resolução. Cefaleia intensa com vômitos em hipertenso puxa a imagem antes de tudo, e a TC 'por segurança' é o passo a mais. A TC antes da punção só é indicada quando há risco de lesão com efeito de massa: imunossupressão, doença prévia do SNC, crise convulsiva recente, papiledema, alteração do nível de consciência ou déficit neurológico focal. O caso nega todos, um a um, no meio do exame e da história. Sem nenhum desses critérios, a punção é feita de imediato, e dexametasona e antibiótico entram logo após a coleta (ou antes, se houver qualquer atraso), sem esperar resultado. Pela idade acima de 50 anos, o empírico é ceftriaxona com ampicilina, mais vancomicina onde houver pneumococo resistente. Fazer TC sem indicação atrasa a punção e, quase sempre, o antibiótico.

A) Punção lombar imediata, sem TC CORRETA

Correta. Nenhum critério para TC (consciência normal, sem papiledema, sem déficit focal, sem crise, sem imunossupressão): punção imediata e antibiótico logo em seguida.

B) TC de crânio antes da punção ARMADILHA

Errada. É a armadilha: seria o passo se houvesse papiledema, déficit focal, rebaixamento, crise recente ou imunossupressão, todos negados no caso.

C) Antibiótico e punção após 48 horas

Errada. Adiar a punção por 48 horas perde a cultura e o diagnóstico etiológico; a punção só é postergada quando contraindicada.

D) Ressonância de encéfalo com contraste

Errada. Ressonância não é exame de emergência na meningite e só atrasaria punção e tratamento.

Para levar. TC antes da punção só com imunossupressão, doença prévia do SNC, crise recente, papiledema, rebaixamento ou déficit focal; sem eles, punção imediata e antibiótico sem atraso.

IDSA Practice Guidelines for the Management of Bacterial Meningitis (2004, reafirmado); ESCMID Guideline: diagnosis and treatment of acute bacterial meningitis (2016).

---

36 Neurologia · Trombólise no AVC isquêmico com PA acima de 185/110: baixar e trombolisar com tenecteplase

Grade X / Y **Gabarito B**

Homem de 68 anos, hipertenso em uso irregular de anlodipino, é trazido ao PS 1 hora e 40 minutos após início súbito, presenciado pela esposa, de hemiparesia direita e afasia. NIHSS 12. Glicemia capilar 136 mg/dL. Usa AAS e clopidogrel desde angioplastia coronária há 8 meses; não usa anticoagulante e não tem cirurgia ou sangramento recente. PA 204/112 mmHg, confirmada em duas medidas com 5 minutos de intervalo, FC 84 bpm, ritmo regular. TC de crânio sem contraste: sem hemorragia, ASPECTS 9. Angiotomografia: sem oclusão de grande vaso. Plaquetas 230.000/mm³. Quanto à pressão arterial e à reperfusão, a conduta mais adequada é, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

PA 204/112 mmHg

Resolução. Duas regras verdadeiras competem. A hipertensão permissiva (não reduzir até 220/120) vale para quem NÃO vai receber trombolítico; para quem vai, a PA precisa estar abaixo de 185/110 antes do bolus e abaixo de 180/105 nas 24 horas seguintes. PA acima de 185/110 que cede a labetalol, nicardipino ou clevidipino não é contraindicação: é uma precondição a cumprir. O paciente está dentro de 4,5 horas, com déficit incapacitante, sem anticoagulante e sem sangue na TC; a dupla antiagregação prévia aumenta pouco o risco de sangramento e não contraindica a trombólise: é candidato a trombólise, e a tenecteplase 0,25 mg/kg em bolus único (máximo 25 mg) é alternativa equivalente à alteplase, preferida pela praticidade. Sem oclusão de grande vaso, não há alvo para trombectomia. Quem marca 'não reduzir / sem trombolítico' aplica a regra de quem não trombolisa e perde a reperfusão por um número que se corrige em minutos.

A) Reduzir abaixo de 185/110 / trombectomia

Errada na segunda metade. Reduzir a PA está certo, mas a angiotomografia não mostra oclusão de grande vaso, então não há indicação de trombectomia.

B) Reduzir abaixo de 185/110 / tenecteplase CORRETA

Correta. Reduzir com labetalol ou nicardipino IV até abaixo de 185/110 e trombolisar com tenecteplase 0,25 mg/kg dentro de 4,5 horas.

C) Não reduzir / tenecteplase
Errada na primeira metade. Não reduzir a PA vale para quem não recebe trombolítico; trombolisar com 204/112 aumenta a transformação hemorrágica.

D) Não reduzir / sem trombolítico ARMADILHA
Errada, é a armadilha. Seria a conduta se a PA não cedesse ao tratamento ou se o paciente estivesse fora da janela; nem a PA elevada controlável nem a dupla antiagregação contraindicam trombólise.

Para levar. PA acima de 185/110 no candidato a trombólise é para baixar, não para desistir. Tenecteplase no AVC: 0,25 mg/kg em bolus, máximo 25 mg.

AHA/ASA 2026 (manejo precoce do AVC isquêmico agudo); ESO 2023 (tenecteplase); Diretriz brasileira de trombólise no AVC (SBDCV/MS).

---

37 Cardiologia · Pericardite aguda de baixo risco: tratamento ambulatorial sem investigação etiológica extensa

Grade X / Y **Gabarito A**

Homem de 34 anos, hígido, procura a emergência por dor torácica há 3 dias, em pontada, que piora ao deitar e à inspiração e alivia sentado, iniciada uma semana após resfriado. Não usa anticoagulante, não é imunossuprimido, nega trauma e neoplasia. Exame: Tax 37,6 °C, PA 128×78 mmHg, FC 92 bpm, sem pulso paradoxal, atrito pericárdico. ECG: supradesnivelamento côncavo difuso de ST com infradesnivelamento de PR. Troponina I normal em duas dosagens. PCR 36 mg/L. Ecocardiograma: derrame pericárdico de 6 mm, sem sinais de restrição ao enchimento, função ventricular normal. O plantonista quer interná-lo para pesquisar FAN, PPD, TSH e sorologias virais. O local de tratamento e a investigação etiológica mais adequados são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE
derrame pericárdico de 6 mm, sem sinais de restrição ao enchimento

Resolução. A proposta do plantonista é a armadilha: soa cuidadosa e é exatamente o passo a mais. A decisão de internar e de investigar a causa depende dos marcadores de mau prognóstico: febre acima de 38 °C, curso subagudo, derrame volumoso (acima de 20 mm) ou tamponamento, falha do AINE após uma semana, e os menores (miopericardite, imunossupressão, trauma, anticoagulação oral). Aqui não há nenhum: febre de 37,6 °C, derrame de 6 mm, troponina normal, sem anticoagulante nem imunossupressão. Nesse cenário a causa é viral ou idiopática em quase todos, o tratamento é ambulatorial com AINE em dose plena mais colchicina por 3 meses, e a pesquisa etiológica só se justifica se surgir um marcador ou se não houver resposta em uma semana. Pedir FAN, PPD e TSH a todos não muda a conduta e produz achados incidentais.

A) Ambulatorial / nenhuma investigação adicional CORRETA
Correta. Sem nenhum marcador de alto risco, trata-se em casa com AINE e colchicina, reavaliando em 1 semana, sem rastreio etiológico.

B) Internação / FAN, PPD, TSH e sorologias ARMADILHA
Errada, e é a armadilha. Seria a conduta com febre acima de 38 °C, derrame acima de 20 mm, curso subagudo ou imunossupressão; nenhum está presente.

C) Ambulatorial / FAN, PPD, TSH e sorologias
Errada na segunda metade. O local está certo, mas o painel etiológico não muda o tratamento num quadro viral de baixo risco.

D) Internação / nenhuma investigação adicional
Errada na primeira metade. A internação é para quem tem marcador de mau prognóstico ou suspeita de tamponamento.

Para levar. Pericardite sem febre acima de 38 °C, sem derrame acima de 20 mm, sem curso subagudo, sem imunossupressão, anticoagulação ou miocardite: ambulatório, AINE e colchicina, e investigação só se falhar em 1 semana.

ESC 2025 (myocarditis and pericarditis); ESC 2015 (pericardial diseases); I Diretriz Brasileira de Miocardites e Pericardites (SBC 2013)

---

38 Hepatologia · Hepatite alcoólica grave: escore de Lille no 7º dia e suspensão do corticoide

Cronologia · Gabarito B

Mulher de 44 anos, etilista de 120 g/dia até a internação, foi admitida há 7 dias com icterícia de 3 semanas, febre baixa e hepatomegalia dolorosa. Na admissão: bilirrubina total 14,2 mg/dL, AST 212 U/L, ALT 88 U/L, TP 24 s (controle 12 s), creatinina 0,8 mg/dL, leucócitos 14.000/mm³. Hemoculturas, urocultura, radiografia de tórax e paracentese diagnóstica sem infecção; sem sangramento digestivo. Com fator discriminante de Maddrey de 61, iniciou prednisolona 40 mg/dia. Hoje, 7º dia de corticoide: lúcida, sem febre, bilirrubina 13,6 mg/dL, creatinina 0,9 mg/dL, escore de Lille 0,62. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE
escore de Lille 0,62

Resolução. Quem começou prednisolona pensa em completar os 28 dias, e é essa a isca. O escore de Lille no 7º dia mede a resposta: acima de 0,45 o doente é não respondedor, a sobrevida não melhora com a continuação do corticoide e o risco de infecção cresce. A conduta é suspender a prednisolona, manter abstinência e suporte nutricional e encaminhar para avaliação de transplante precoce em centro com protocolo. A pentoxifilina não tem benefício de sobrevida (STOPAH) e não é resgate para não respondedor; aumentar a dose do corticoide só acrescenta infecção. A bilirrubina quase parada (14,2 para 13,6) é o que o Lille traduz em número.

A) Manter prednisolona até 28 dias ARMADILHA
Errada. É a isca: seria a conduta com Lille abaixo de 0,45 no 7º dia (respondedor); com 0,62, continuar só expõe a infecção sem ganho de sobrevida.

B) Suspender a prednisolona CORRETA
Correta. Lille de 0,62 no 7º dia define não resposta; suspende-se o corticoide e considera-se transplante precoce em centro com protocolo.

C) Substituir por pentoxifilina
Errada. A pentoxifilina não reduziu mortalidade no STOPAH e não funciona como resgate para quem não respondeu ao corticoide.

D) Aumentar prednisolona para 60 mg/dia
Errada. Não existe escalonamento de dose na hepatite alcoólica; a não resposta é biológica, e não de dose.

Para levar. Hepatite alcoólica com Maddrey de 32 ou mais: prednisolona 40 mg/dia; no 7º dia, Lille acima de 0,45 manda suspender.

AASLD Practice Guidance: alcohol-associated liver disease (2024); EASL Clinical Practice Guidelines on alcohol-related liver disease (2018); STOPAH (N Engl J Med, 2015)

---

39 Nefrologia · Síndrome nefrótica abrupta na diabética em uso de naproxeno · quando não é doença renal do diabetes

Negativo no meio · Gabarito A

Mulher de 61 anos, com diabetes tipo 2 há sete anos (HbA1c 7,1%) e hipertensão, em uso de metformina e losartana 50 mg/dia. Em consulta de seis meses atrás tinha creatinina 0,9 mg/dL, fundoscopia sem retinopatia e relação albumina/creatinina urinária de 18 mg/g. Há cinco semanas usa naproxeno 500 mg duas vezes ao dia por bursite no ombro. Há dez dias tem edema progressivo e ganhou 6 kg. Exame: PA 146/88 mmHg, edema 4+ até a raiz das coxas, sem exantema, sem artrite. Exames: albumina 1,9 g/dL, colesterol total 382 mg/dL, creatinina 1,7 mg/dL, proteinúria de 24 h de 9,8 g, urina com 3 hemácias e 25 leucócitos por campo, sem bactérias, urocultura negativa, C3 e C4 normais, anti-PLA2R não reagente, FAN, HBsAg, anti-HCV e anti-HIV negativos, eletroforese de proteínas sem pico monoclonal. Ultrassonografia: rins de 11 cm. O diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE
fundoscopia sem retinopatia e relação albumina/creatinina urinária de 18 mg/g

Resolução. Diabetes há sete anos com síndrome nefrótica parece doença renal do diabetes, e a maioria para no rótulo. Mas a doença do diabetes evolui ao longo de anos, de albuminúria moderada para grave, quase sempre acompanhada de retinopatia: seis meses atrás havia albuminúria normal e fundo de olho sem retinopatia, e o salto para 9,8 g de proteinúria em semanas não é dela. Ausência de retinopatia, início súbito, proteinúria explosiva, sedimento ativo e queda rápida da função são os sinais que mandam procurar outra glomerulopatia no diabético. A droga em uso explica tudo: anti-inflamatório por semanas, síndrome nefrótica abrupta e leucocitúria estéril com creatinina subindo é a dupla lesão do AINE, lesão mínima com nefrite intersticial aguda. A membranosa também se associa a AINE, mas não traz o componente intersticial, e o anti-PLA2R negativo não a sustenta. Conduta: suspender o naproxeno; a biópsia aqui se justifica exatamente porque o quadro não é o da doença do diabetes.

A) Lesão mínima com nefrite intersticial CORRETA
Correta. Proteinúria nefrótica abrupta com leucocitúria estéril e queda da função após semanas de naproxeno é a dupla lesão do AINE: podocitopatia (lesão mínima) e nefrite intersticial.

B) Doença renal do diabetes ARMADILHA
Errada, é a armadilha. Seria a resposta na diabética de longa data com retinopatia e albuminúria crescente ao longo de anos; aqui havia albuminúria normal há seis meses e fundo de olho sem retinopatia.

C) Nefropatia membranosa secundária
Errada. A membranosa pode ser secundária a AINE, mas costuma se instalar de forma mais insidiosa e não explica a leucocitúria estéril com perda de função, que é intersticial.

D) Glomeruloesclerose segmentar e focal
Errada. A GESF primária não teria a ligação temporal com a droga nem o componente intersticial, e a secundária cursa com proteinúria sem hipoalbuminemia importante.

Para levar. No diabético, síndrome nefrótica sem retinopatia, de início abrupto ou com sedimento ativo não é doença renal do diabetes até prova em contrário; com AINE em uso, pense em lesão mínima com nefrite intersticial.

KDIGO 2021 (Glomerular Diseases); KDIGO 2022 (Diabetes Management in CKD); Harrison 21ª ed. (Tubulointerstitial Diseases).

---

40 Reumatologia · Hipertensão arterial pulmonar na esclerose sistêmica limitada: cateterismo direito antes do vasodilatador

Negativo no meio | Gabarito A

Mulher de 58 anos tem esclerose sistêmica cutânea limitada há 11 anos, com Raynaud, esclerodactilia, telangiectasias e anticorpo anticentrômero reagente. Há 6 meses nota dispneia aos esforços moderados, hoje classe funcional II, sem tosse. Exame físico: SpO2 95% em repouso e 89% ao subir um lance de escada, hiperfonese de B2 em foco pulmonar, sem estertores, sem edema. Provas de função pulmonar: CVF 94% do previsto e DLCO 41% do previsto. TC de tórax de alta resolução sem doença intersticial. Ecocardiograma: velocidade de regurgitação tricúspide de 3,2 m/s, átrio direito aumentado, fração de ejeção do VE de 64%, função diastólica normal, sem valvopatia. Cintilografia de ventilação e perfusão normal. NT-proBNP 610 pg/mL. O próximo exame mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

Cintilografia de ventilação e perfusão normal

Resolução. O raciocínio que derruba o candidato é sentir falta de um exame de imagem a mais antes do invasivo. Na esclerose sistêmica limitada com anticentrômero, DLCO isoladamente baixa com CVF preservada é a assinatura da hipertensão arterial pulmonar (grupo 1). Os negativos do caso já excluíram as outras causas: sem doença intersticial na TC e CVF normal (grupo 3), função diastólica e valvas normais (grupo 2) e cintilografia normal, que é o exame de triagem do tromboembolismo crônico (grupo 4) e torna a angiotomografia redundante. Com velocidade tricúspide de 3,2 m/s e átrio direito aumentado, a probabilidade ecocardiográfica é alta, e o diagnóstico exige cateterismo direito (pressão média acima de 20 mmHg, pressão de oclusão até 15 e resistência acima de 2 unidades Wood), que também estratifica o risco antes de escolher a terapia combinada. Repetir em 12 meses seria o rastreio anual da paciente assintomática, não desta.

A) Cateterismo cardíaco direito CORRETA
Correta. Probabilidade ecocardiográfica alta, com grupos 2, 3 e 4 afastados, pede cateterismo direito para confirmar e estratificar antes de tratar.

B) Repetir ecocardiograma em 12 meses
Errada. É o rastreio anual da esclerose sistêmica sem sintomas e com ecocardiograma de baixa probabilidade; aqui há dispneia e velocidade de 3,2 m/s.

C) Angiotomografia de artérias pulmonares ARMADILHA
Errada. Seria útil se a cintilografia mostrasse defeitos de perfusão; com cintilografia normal, o tromboembolismo crônico está afastado.

D) Ecocardiograma sob esforço

Errada. O ecocardiograma de esforço não é critério diagnóstico de hipertensão pulmonar e só atrasa o exame que confirma.

Para levar. Esclerose sistêmica com DLCO isolada baixa e eco de probabilidade alta, com grupos 2, 3 e 4 afastados: cateterismo direito antes de qualquer vasodilatador pulmonar.

ESC/ERS 2022 Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension; EULAR 2023 recommendations for the treatment of systemic sclerosis.

---

41 Hematologia · Linfoma de Hodgkin clássico em contato de tuberculose: a imuno-histoquímica decide

Rótulo verdadeiro **Gabarito C**

Homem de 26 anos, cujo irmão completou tratamento de tuberculose pulmonar há 1 ano, procura atendimento por febre vespertina, sudorese noturna e perda de 6 kg há 3 meses, com "caroço" no pescoço há 2 meses. Exame: T 37,8 °C, linfonodos supraclaviculares esquerdos coalescentes de 4 cm, indolores, sem fistulização. Radiografia de tórax: alargamento do mediastino anterior, sem lesão parenquimatosa. PPD de 14 mm. Hemograma: Hb 11,4 g/dL, leucócitos 12.800/mm³ com 11% de eosinófilos, linfócitos 700/mm³, plaquetas 450.000/mm³. VHS 88 mm/h. Biópsia excisional: granulomas epitelioides sem necrose caseosa, entremeados a nódulos separados por faixas de colágeno com células grandes binucleadas CD30+ e CD15+, CD20 e CD45 negativas, em fundo de eosinófilos e linfócitos reativos; pesquisa de BAAR e teste molecular para M. tuberculosis negativos. O diagnóstico é:

O DADO QUE DECIDE

CD30+ e CD15+, CD20 e CD45 negativas

Resolução. O rótulo verdadeiro é a tuberculose: contato domiciliar, PPD de 14 mm, febre vespertina, sudorese, emagrecimento, linfonodo supraclavicular coalescente e, na biópsia, granulomas epitelioides. O PPD, porém, só prova infecção, os granulomas não têm necrose caseosa e BAAR e teste molecular são negativos; granulomas sem caseificação são reação comum ao Hodgkin e não fecham tuberculose. O que decide é a imuno-histoquímica: célula grande binucleada CD30+ e CD15+, com CD20 e CD45 negativos, num fundo rico em eosinófilos e com faixas de colágeno, é a célula de Reed-Sternberg do Hodgkin clássico, subtipo esclerose nodular, o mais comum em jovens com massa mediastinal. Eosinofilia, linfopenia e VHS alta reforçam. O linfoma primário do mediastino também é de jovem e pode expressar CD30, mas é CD20+ e CD45+, e o T periférico seria CD3+.

A) Tuberculose ganglionar ARMADILHA

Errada. É a armadilha: contato, PPD e granulomas são verdadeiros, mas granuloma sem caseificação, BAAR e teste molecular negativos e células CD30+ CD15+ não são tuberculose.

B) Linfoma primário do mediastino de células B

Errada. Seria a resposta em adulto jovem com massa mediastinal volumosa e células B CD20+ e CD45+, às vezes com CD30 fraco; aqui CD20 e CD45 são negativos.

C) Linfoma de Hodgkin clássico CORRETA

Correta. Célula binucleada CD30+ CD15+ com CD20 e CD45 negativos em fundo reativo com faixas de colágeno é Hodgkin clássico esclerose nodular; os granulomas são reação ao linfoma.

D) Linfoma T periférico
Errada. O T periférico também cursa com eosinofilia e sintomas B, mas as células neoplásicas seriam CD3+ e CD45+, sem o fenótipo de Reed-Sternberg.

Para levar. Hodgkin clássico é CD30+ CD15+ com CD20 e CD45 negativos e pode vir com granulomas sem caseificação; PPD positivo prova infecção latente, não a causa da massa.

Classificação OMS 2022 (5ª edição) das neoplasias linfoides; NCCN Hodgkin Lymphoma 2025.

---

42 Terapia intensiva · Choque séptico: cristaloide balanceado e noradrenalina periférica sem esperar o acesso central

Grade X / Y **Gabarito B**

Homem de 67 anos, com doença renal crônica estágio 3b, chega à emergência com febre, tosse produtiva e confusão há 2 dias. PA 78 × 42 mmHg (PAM 54), FC 122 bpm, FR 28 irpm, SpO2 92% com cateter de O2, tempo de enchimento capilar de 5 segundos, extremidades frias. Radiografia: consolidação em lobo inferior direito. Exames: lactato 4,6 mmol/L, Na 138 mEq/L, K 5,6 mEq/L, Cl 111 mEq/L, HCO3 14 mEq/L, creatinina 2,8 mg/dL (basal 1,8). Foram colhidas hemoculturas e iniciados ceftriaxona e azitromicina. Recebeu 1.500 mL de soro fisiológico a 0,9% em 40 minutos e está com PAM de 56 mmHg. A passagem do cateter venoso central está prevista para daqui a 2 horas, quando chegar o plantonista da UTI. O cristaloide a manter e o momento de iniciar a noradrenalina são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE
Cl 111 mEq/L, HCO3 14 mEq/L

Resolução. O potássio de 5,6 com DRC faz muitos evitarem o Ringer lactato, que contém 4 mEq/L de potássio. Mas já há acidose metabólica hiperclorêmica (cloro 111, bicarbonato 14, ânion gap de 13), que a DRC favorece e cada litro de soro fisiológico agrava, e a acidose desloca potássio para fora da célula: o soro fisiológico piora o potássio, e o cristaloide balanceado não o eleva. A Surviving Sepsis recomenda cristaloide balanceado em vez de soro fisiológico. Quanto ao vasopressor, PAM abaixo de 65 apesar de volume com hipoperfusão persistente (lactato 4,6, enchimento capilar lento) pede noradrenalina já, por veia periférica calibrosa e proximal, sem esperar o acesso central: atrasar o vasopressor por 2 horas prolonga a hipotensão, e o uso periférico por curto período tem baixo risco de extravasamento. O cateter central vem depois, sem adiar o alvo de PAM de 65.

A) Ringer lactato / após o cateter central
Errada. Acerta o fluido e erra o tempo: esperar o cateter central atrasa o vasopressor num choque com lactato de 4,6.

B) Ringer lactato / imediatamente, em veia periférica CORRETA
Correta. Cristaloide balanceado diante da hipercloremia e noradrenalina imediata em veia periférica, com alvo de PAM de 65 mmHg.

C) Soro fisiológico / após o cateter central
Errada nas duas metades. Mantém o fluido que agrava a acidose hiperclorêmica e deixa o paciente hipotenso por 2 horas à espera do acesso.

D) Soro fisiológico / imediatamente, em veia periférica ARMADILHA

Errada, e é a armadilha. Acerta o vasopressor, mas o medo do potássio do Ringer não procede: o soro fisiológico agrava a acidose e o potássio.

Para levar. No choque séptico, cristaloide balanceado é preferível ao soro fisiológico (mesmo com potássio alto), e a noradrenalina começa por veia periférica, sem esperar o acesso central.

Surviving Sepsis Campaign 2021; SMART (N Engl J Med 2018); BaSICS (JAMA 2021)

---

43 Endocrinologia · Hiperprolactinemia assintomática: macroprolactina antes da imagem

Negativo no meio | Gabarito C

Mulher de 31 anos traz exames de check-up solicitados pela empresa, que incluíram prolactina por iniciativa do médico do trabalho. Ciclos menstruais regulares a cada 28 dias, sem galactorreia à expressão, sem cefaleia ou queixa visual, libido preservada. Usa apenas omeprazol 20 mg/dia há dois meses por dispepsia. Não usa antidepressivo, antipsicótico, metoclopramida ou anticoncepcional. Exame físico normal. Exames: prolactina 94 ng/mL (até 25), repetida em nova coleta em repouso, 92 ng/mL; beta-hCG negativo; TSH 1,8 µUI/mL; creatinina 0,7 mg/dL. A conduta diagnóstica mais adequada neste momento é:

O DADO QUE DECIDE

Ciclos menstruais regulares a cada 28 dias, sem galactorreia à expressão

Resolução. A prolactina de 94 ng/mL, confirmada, com gestação, hipotireoidismo e insuficiência renal excluídos, empurra para a ressonância de sela. O que decide é o negativo no meio do caso: ciclos regulares, sem galactorreia e libido preservada. Prolactina monomérica de 90 ng/mL quase sempre produz hipogonadismo; uma mulher eumenorreica com esse valor sugere macroprolactinemia, um complexo de prolactina com IgG biologicamente inativo, que responde por 10 a 25% das hiperprolactinemias. O exame é a precipitação com polietilenoglicol, e só se a prolactina monomérica estiver elevada se segue com imagem. O omeprazol é o rótulo de droga, mas inibidor de bomba não eleva prolactina de forma relevante (quem eleva é a cimetidina).

A) Cabergolina em dose baixa

Errada. Tratar número em assintomática, sem saber se a prolactina é ativa, é tratar o laboratório.

B) Suspender o omeprazol e repetir a dosagem

Errada. Seria o caminho com droga que eleva prolactina (antipsicótico, metoclopramida, cimetidina); inibidor de bomba não explica 94 ng/mL.

C) Pesquisa de macroprolactina CORRETA

Correta. Hiperprolactinemia sem sintomas em mulher eumenorreica pede pesquisa de macroprolactina antes de qualquer imagem.

D) Ressonância magnética de sela túrcica ARMADILHA

Errada. Seria o passo com prolactina monomérica elevada ou com hipogonadismo; em assintomática, a imagem pode achar um incidentaloma e induzir tratamento desnecessário.

Para levar. Prolactina alta sem amenorreia, galactorreia ou hipogonadismo: pesquise macroprolactina (PEG) antes de pedir ressonância ou tratar.

Endocrine Society, Diagnosis and Treatment of Hyperprolactinemia 2011; Pituitary Society consensus on prolactinomas 2023.

---

44 Infectologia · Pneumocistose: duração do tratamento e corticoide pela PaO2 com saturação de repouso preservada

Grade X / Y **Gabarito D**

Homem de 38 anos, com diagnóstico de HIV há 4 anos e sem TARV há 1 ano, procura atendimento por tosse seca e dispneia progressiva há 3 semanas, com febre baixa vespertina. Nega expectoração purulenta e hemoptise. Exame: T 37,8 °C, FR 24 irpm, FC 104 bpm, PA 118 × 74 mmHg, SpO2 94% em ar ambiente em repouso, que cai para 86% após caminhar no corredor; placas esbranquiçadas removíveis em palato; raros estertores finos bibasais. TC de tórax: opacidades em vidro fosco bilaterais e difusas, com predomínio peri-hilar, e cistos de paredes finas em lobos superiores, sem derrame pleural ou linfonodomegalia. CD4 62 células/mm³, LDH 520 U/L, beta-D-glucana sérica positiva. Gasometria arterial em ar ambiente: pH 7,46, PaO2 66 mmHg, PaCO2 31 mmHg, HCO3 22 mEq/L. Sem alergias conhecidas. Além de sulfametoxazol-trimetoprima, a duração do tratamento e a indicação de corticoide são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

PaO2 66 mmHg

Resolução. A saturação de 94% em repouso dá a impressão de doença leve, e quem lê só o oxímetro deixa o corticoide de fora. O critério do corticoide adjuvante na pneumocistose da pessoa com HIV é gasométrico: PaO2 abaixo de 70 mmHg em ar ambiente ou gradiente alvéolo-arterial de 35 mmHg ou mais. Aqui a PaO2 é de 66 mmHg e o gradiente passa de 40 mmHg (PAO2 de cerca de 111 menos 66), e a dessaturação ao esforço confirma a gravidade moderada. O corticoide deve começar junto do antimicrobiano, até 72 horas do início, com prednisona 40 mg de 12/12 horas por 5 dias, 40 mg/dia por 5 dias e 20 mg/dia até o 21º dia. Na pessoa com HIV, o tratamento dura 21 dias, e não os 14 dias usados em parte dos imunossuprimidos sem HIV. Depois vem a profilaxia secundária até CD4 acima de 200 por mais de 3 meses em TARV.

A) 14 dias / não indicado

Errada. Seria a resposta de uma pneumocistose leve fora do HIV (14 dias, PaO2 de 70 ou mais); a PaO2 de 66 mmHg e o HIV derrubam as duas metades.

B) 14 dias / indicado

Errada. O corticoide está certo, mas 14 dias é a duração aceita em parte dos imunossuprimidos sem HIV; com HIV, são 21 dias.

C) 21 dias / não indicado ARMADILHA

Errada. É a armadilha: acerta a duração, mas lê a SpO2 de repouso como gravidade e ignora a PaO2 de 66 mmHg, que indica corticoide.

D) 21 dias / indicado CORRETA

Correta. 21 dias na pessoa com HIV, e corticoide porque a PaO2 em ar ambiente está abaixo de 70 mmHg.

Para levar. Na pneumocistose com HIV, trate por 21 dias e decida o corticoide pela gasometria (PaO2 abaixo de 70 mmHg ou gradiente A-a de 35 ou mais), não pela saturação de repouso.

PCDT para Manejo da Infecção pelo HIV em Adultos (MS, 2024); NIH/CDC/IDSA Guidelines for Opportunistic Infections in Adults and Adolescents with HIV (Pneumocystis, atualização 2024).

---

45 Hepatologia · Hepatite B crônica HBeAg negativo com HBV-DNA baixo: quando não tratar

Omissão **Gabarito D**

Homem de 38 anos teve HBsAg reagente descoberto há 6 anos em doação de sangue; a mãe tem hepatite B. Assintomático, sem etilismo, IMC 24 kg/m², sem comorbidades e sem uso de medicamentos; não há história familiar de carcinoma hepatocelular. Exame físico normal. Nos últimos 2 anos, quatro dosagens de ALT entre 18 e 26 U/L (referência até 40 U/L). Exames atuais: HBeAg não reagente, anti-HBe reagente, HBV-DNA 410 UI/mL, plaquetas 236.000/mm³; anti-HCV, anti-HDV e anti-HIV não reagentes. Elastografia hepática transitória: 4,8 kPa. Ultrassonografia abdominal normal. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

HBV-DNA 410 UI/mL

Resolução. HBsAg reagente há anos, com mãe portadora, empurra para iniciar antiviral, e é isso que o apressado faz. A indicação de tratamento depende de HBV-DNA, ALT e fibrose, além de situações especiais (cirrose, história familiar de carcinoma hepatocelular, imunossupressão programada, coinfecção, manifestação extra-hepática). Aqui o HBV-DNA é de 410 UI/mL, abaixo de 2.000, a ALT está normal em quatro dosagens e a elastografia de 4,8 kPa afasta fibrose significativa, sem nenhuma situação especial. É a infecção crônica HBeAg negativo (antigo portador inativo), que se acompanha com ALT e HBV-DNA periódicos, sem antiviral. Biópsia não acrescenta nada quando a elastografia é normal e os marcadores são concordantes.

A) Entecavir até perder o HBsAg
Errada. Entecavir seria opção se houvesse indicação, mas não há, e a perda do HBsAg é rara e não serve como horizonte de tratamento.

B) Tenofovir por tempo indeterminado ARMADILHA
Errada. É a isca: seria a conduta com HBV-DNA acima de 2.000 UI/mL e ALT elevada, fibrose ao menos moderada, cirrose ou situação especial; nada disso existe aqui.

C) Biópsia hepática para estadiamento
Errada. Biópsia fica para marcadores discordantes ou dúvida sobre fibrose; elastografia de 4,8 kPa com ALT e DNA baixos já estadia.

D) ALT e HBV-DNA periódicos, sem antiviral CORRETA
Correta. HBV-DNA de 410 UI/mL, ALT persistentemente normal e elastografia normal: infecção crônica HBeAg negativo, seguimento periódico sem antiviral.

Para levar. HBsAg reagente não é indicação de tratamento: trata-se por HBV-DNA acima de 2.000 com ALT alta, fibrose significativa, cirrose ou situação especial; o resto se acompanha.

PCDT para Hepatite B e Coinfecções (Ministério da Saúde, 2017); EASL Clinical Practice Guidelines on hepatitis B (2025); WHO guidelines for chronic hepatitis B (2024)

---

46 Cardiologia · ICFEr com bloqueio de ramo esquerdo largo após otimização: ressincronização com desfibrilador, e não CDI isolado

Limiar **Gabarito B**

Homem de 63 anos, com cardiopatia isquêmica (infarto anterior há 6 anos, angioplastia da descendente anterior) e IC de fração de ejeção reduzida em classe funcional II a III da NYHA, sem internação no último ano. Há 5 meses usa, nas doses máximas toleradas e com boa adesão, sacubitril-valsartana 97/103 mg duas vezes ao dia, bisoprolol 10 mg, espironolactona 25 mg e dapagliflozina 10 mg ao dia. Nega síncope e palpitações. Exame: PA 106 × 64 mmHg, FC 62 bpm regular, sem turgência jugular, pulmões limpos, sem edema. Potássio 4,8 mEq/L, creatinina 1,2 mg/dL. ECG: ritmo sinusal, bloqueio de ramo esquerdo com QRS de 158 ms, já presente em traçados de 2 anos atrás. Ecocardiograma de controle: VE dilatado, fração de ejeção de 29% (era 27% antes da otimização), sem trombo. Holter de 24 horas: extrassístoles ventriculares isoladas, sem taquicardia ventricular. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

bloqueio de ramo esquerdo com QRS de 158 ms

Resolução. A fração de ejeção de 29% após mais de 3 meses de tratamento otimizado, em cardiopatia isquêmica, ativa o reflexo do cardiodesfibrilador para prevenção primária, e essa indicação existe. O que muda o dispositivo é o ECG, que vem rotulado como antigo e por isso tende a ser lido como enfeite: ritmo sinusal com bloqueio de ramo esquerdo e QRS de 158 ms. Com fração de ejeção de 35% ou menos, sintomas apesar do tratamento otimizado e bloqueio de ramo esquerdo com QRS de 150 ms ou mais, a terapia de ressincronização é classe I, porque melhora sintomas e reduz internação e mortalidade, o que o CDI isolado não faz. Como também há indicação de CDI (isquêmico, fração de ejeção abaixo de 35%, boa expectativa de vida), o dispositivo é o ressincronizador com função de desfibrilador. Manter só o tratamento clínico desperdiça as duas indicações, e a ivabradina exige FC de 70 bpm ou mais em ritmo sinusal, e ele está com 62 bpm em bisoprolol 10 mg.

A) Cardiodesfibrilador implantável isolado ARMADILHA

Errada. É a armadilha: seria a indicação com fração de ejeção de 35% ou menos após otimização e QRS estreito; o bloqueio de ramo esquerdo de 158 ms acrescenta a ressincronização.

B) Ressincronizador com desfibrilador CORRETA

Correta. Fração de ejeção de 29% sintomática após 5 meses de tratamento otimizado, ritmo sinusal e bloqueio de ramo esquerdo com QRS de 158 ms: ressincronização, com desfibrilador pela indicação de prevenção primária na cardiopatia isquêmica.

C) Manter o tratamento clínico atual

Errada. Seria a conduta se a fração de ejeção tivesse subido acima de 35% com a otimização; continua em 29%.

D) Associar ivabradina

Errada. Seria opção em ritmo sinusal com FC de 70 bpm ou mais apesar do betabloqueador na dose máxima tolerada; a FC é de 62 bpm.

Para levar. Na ICFEr com fração de ejeção de 35% ou menos após 3 meses de tratamento otimizado, olhe o QRS antes de escolher o dispositivo: bloqueio de ramo esquerdo com 150 ms ou mais em ritmo sinusal indica ressincronização, e o CDI isolado fica para o QRS estreito.

ESC 2021 (insuficiência cardíaca aguda e crônica) e atualização focada de 2023; Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica e Aguda (SBC 2018).

---

47 Neurologia · Síndrome vestibular aguda no idoso vascular com HINTS plus inteiramente periférico: neurite vestibular

Rótulo verdadeiro | Gabarito C

Homem de 71 anos, hipertenso, diabético e com angioplastia coronária há 3 anos, em uso de AAS, losartana e metformina, acorda com tontura rotatória contínua, náuseas e vômitos, há 14 horas, que pioram com o movimento da cabeça mas não cessam em repouso. Teve infecção de vias aéreas superiores há 9 dias. Nega hipoacusia, zumbido, cefaleia, diplopia, disartria e episódios prévios. PA 164/94 mmHg, FC 88 bpm, ritmo regular, glicemia 168 mg/dL. Exame: nistagmo horizontal-torcional batendo para a direita no olhar primário, que aumenta no olhar para a direita, diminui com a fixação e não muda de direção no olhar para a esquerda; teste do impulso cefálico com sacada corretiva ao girar a cabeça para a esquerda; sem desvio vertical na cobertura alternada; audição simétrica no teste de atrito dos dedos; coordenação apendicular normal; anda sem apoio, com desvio para a esquerda. TC de crânio sem contraste normal. O diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

teste do impulso cefálico com sacada corretiva ao girar a cabeça para a esquerda

Resolução. O rótulo é verdadeiro e pesado: idoso hipertenso, diabético e coronariopata com vertigem aguda é o paciente em que o AVC de fossa posterior mais assusta, e a TC normal não o afasta. Mas na síndrome vestibular aguda quem separa periférico de central é o exame à beira do leito (HINTS plus), mais sensível que a RM com difusão nas primeiras 48 horas. Aqui os quatro componentes são periféricos: impulso cefálico anormal para a esquerda (a sacada corretiva mostra o reflexo vestíbulo-ocular lesado no nervo), nistagmo unidirecional que bate para o lado são e diminui com a fixação, ausência de desvio vertical e audição preservada. Somam-se o pródromo viral, a coordenação apendicular normal e a marcha possível sem apoio, com desvio para o lado lesado. O impulso anormal só deixa de proteger se vier com hipoacusia nova (infarto da artéria cerebelar anteroinferior) ou com qualquer outro sinal central, e nenhum está presente. O diagnóstico é neurite vestibular esquerda: tratamento sintomático por poucos dias e reabilitação vestibular precoce, deixando a RM para o exame duvidoso ou para o surgimento de sinal central.

A) Vertigem posicional paroxística benigna

Errada. VPPB dá crises de segundos desencadeadas pela mudança de posição, com nistagmo provocado pela manobra de Dix-Hallpike, e não tontura contínua há 14 horas com nistagmo espontâneo.

B) Infarto cerebelar ARMADILHA

Errada, é a armadilha. Seria a resposta com impulso cefálico normal, nistagmo que muda de direção, desvio vertical, hipoacusia nova ou incapacidade de ficar de pé; o risco vascular é verdadeiro, mas os quatro componentes do HINTS plus são periféricos.

C) Neurite vestibular CORRETA

Correta. Vertigem contínua após quadro viral, impulso cefálico anormal para a esquerda, nistagmo unidirecional para a direita inibido pela fixação, sem desvio vertical e com audição preservada.

D) Labirintite viral

Errada. Labirintite é o mesmo processo com envolvimento coclear: teria hipoacusia ou zumbido do lado afetado, e a audição está simétrica.

Para levar. Impulso cefálico ANORMAL, nistagmo unidirecional, sem desvio vertical e sem hipoacusia nova: síndrome vestibular aguda periférica, mesmo no idoso vascular. Um único componente central (impulso normal, nistagmo que muda de direção, desvio vertical) ou hipoacusia nova muda para AVC.

Kattah et al., Stroke 2009 (HINTS); Newman-Toker et al., Acad Emerg Med 2013 (HINTS plus); ACEP/SAEM GRACE-3 2023 (tontura aguda no departamento de emergência).

48

Nefrologia · Lesão renal aguda com creatinina alta e sem indicação dialítica · não dialisar pelo número

Omissão **Gabarito C**

Homem de 67 anos, no sexto dia de internação por peritonite fecal operada, recebeu noradrenalina nos três primeiros dias, suspensa há 72 horas. Evolui com lesão renal aguda: creatinina 0,9 mg/dL na admissão, 3,8 mg/dL no terceiro dia e 6,9 mg/dL hoje; ureia 186 mg/dL. Diurese de 1.350 mL nas últimas 24 horas, sem diurético, com balanço hídrico acumulado de +1.200 mL. Exame: lúcido, sem asterixe, sem atrito pericárdico, PA 128/74 mmHg, FC 88 bpm, SpO2 96% em ar ambiente, murmúrio vesicular sem estertores, edema 1+. Exames: sódio 137 mEq/L, potássio 5,3 mEq/L, bicarbonato 19 mEq/L, pH 7,33, fósforo 5,9 mg/dL, hemoglobina 9,8 g/dL. Quanto à terapia renal substitutiva, a conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

Diurese de 1.350 mL nas últimas 24 horas, sem diurético

Resolução. Creatinina de 6,9 e ureia de 186 impressionam e puxam para a diálise, e a ureia perto de 200 ainda aparece em apostilas como gatilho. Mas a terapia renal substitutiva na lesão renal aguda se indica por complicação que o rim não está resolvendo, e não pelo número da creatinina: hipercalemia refratária (acima de 6,5 mEq/L ou com ECG alterado), acidose grave (pH abaixo de 7,15 a 7,2), sobrecarga de volume refratária com hipoxemia, uremia sintomática (encefalopatia, pericardite, sangramento) ou intoxicação dialisável. Este paciente está lúcido, sem pericardite, em ar ambiente, com 1,35 L de diurese espontânea, potássio de 5,3 e pH de 7,33. Os ensaios AKIKI, IDEAL-ICU, STARRT-AKI e AKIKI-2 mostraram que iniciar sem essas indicações não reduz mortalidade e expõe a cateter, hipotensão e mais dependência de diálise, e boa parte dos pacientes da estratégia expectante nunca precisa dela. A conduta é suporte, ajuste de doses, evitar nefrotóxicos e reavaliar diariamente.

A) Hemodiálise intermitente hoje ARMADILHA

Errada, é a armadilha. A hemodiálise intermitente seria o método num paciente estável com uma indicação presente; aqui não há nenhuma, e creatinina alta não é indicação.

B) Hemodiálise contínua hoje

Errada. O método contínuo é o preferido no instável hemodinamicamente ou com hipertensão intracraniana, mas o problema anterior é que não há indicação de diálise.

C) Não iniciar e reavaliar diariamente CORRETA

Correta. Sem hipercalemia refratária, acidose grave, congestão refratária ou uremia sintomática, e com diurese preservada, a estratégia expectante com reavaliação diária é a recomendada.

D) Cateter de longa permanência para diálise

Errada. Cateter de longa permanência antecipa uma dependência crônica que ninguém pode prever no sexto dia de uma necrose tubular com diurese preservada.

Para levar. Diálise na lesão renal aguda se indica por complicação refratária (potássio, acidose, volume, uremia, intoxicação), não por creatinina ou ureia; sem indicação, esperar e reavaliar todos os dias.

KDIGO 2012 (Acute Kidney Injury) e KDIGO Controversies Conference 2020; STARRT-AKI (NEJM 2020); AKIKI-2 (Lancet 2021).

49

Reumatologia · Doença de Still do adulto: síndrome de ativação macrofágica incipiente com contagens que parecem normais

Rótulo verdadeiro

Gabarito A

Homem de 29 anos tem doença de Still do adulto diagnosticada há 5 semanas (febre quotidiana, exantema evanescente, artrite de punhos, leucocitose neutrofílica, FAN e FR negativos; infecção e neoplasia afastadas, inclusive por biópsia de linfonodo), em uso de prednisona 40 mg/dia, com melhora inicial. Há 6 dias voltou a ter febre contínua de 39,5 °C, agora sem exantema e sem artrite. Exame físico: PA 102 × 64 mmHg, FC 118 bpm, baço a 4 cm do rebordo costal, sem foco infeccioso aparente. Exames de 3 semanas atrás e de hoje, respectivamente: leucócitos 19.400 e 6.100/mm³; plaquetas 540.000 e 182.000/mm³; Hb 11,2 e 10,1 g/dL; ferritina 6.800 e 41.000 ng/mL; AST 54 e 310 U/L; fibrinogênio 520 e 150 mg/dL; VHS 92 e 30 mm/h. Triglicerídeos 380 mg/dL. Hemoculturas e urocultura negativas após 72 horas, procalcitonina 0,3 ng/mL, PCR para CMV e EBV não detectadas. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

plaquetas 540.000 e 182.000/mm³

Resolução. Leucócitos de 6.100, plaquetas de 182.000 e VHS de 30 parecem melhora, e é aí que a questão pega: na doença de Still ativa o esperado é leucocitose e trombocitose, então números normais com febre alta são queda. A queda relativa das plaquetas e dos leucócitos, com ferritina subindo de 6.800 para 41.000, fibrinogênio caindo (o que derruba a VHS), AST em ascensão, triglicerídeos altos e esplenomegalia, define síndrome de ativação macrofágica incipiente. Infecção, o principal diferencial, foi razoavelmente afastada por culturas, procalcitonina e PCR virais. O tratamento é glicocorticoide em dose alta (pulso de metilprednisolona) associado a bloqueio de IL-1 com anakinra, que tem início rápido e é a base das recomendações atuais para a ativação macrofágica do Still. Etoposídeo fica para a refratariedade, e metotrexato é poupador de corticoide da doença articular crônica, sem papel na emergência.

A) Pulso de metilprednisolona e anakinra CORRETA

Correta. Ativação macrofágica no Still pede corticoide em dose alta com anakinra, e a queda relativa das contagens com ferritina e AST em ascensão já basta para tratar.

B) Associar metotrexato 15 mg/semana

Errada. Seria o passo no Still com artrite persistente dependente de corticoide; não controla a tempestade de citocinas da ativação macrofágica.

C) Etoposídeo associado a dexametasona

Errada. O protocolo com etoposídeo é reservado à linfo-histiocitose refratária ao corticoide e ao anti-IL-1; usá-lo primeiro é tratamento a mais, com mielotoxicidade.

D) Manter prednisona e reavaliar em 1 semana ARMADILHA

Errada. Leucócitos, plaquetas e VHS normais parecem resposta, mas no Still a normalização com ferritina em ascensão e fibrinogênio em queda é consumo, e esperar 1 semana custa a vida.

Para levar. No Still, leucócitos, plaquetas e VHS que normalizam enquanto a ferritina sobe e o fibrinogênio cai são ativação macrofágica, não resposta. Trata-se com corticoide em dose alta e anakinra.

EULAR/PReS 2024 recommendations for Still's disease (inclui ativação macrofágica); Kelley & Firestein's Textbook of Rheumatology, 11ª ed. (2021).

50

Hematologia · Leucemia promielocítica aguda com coagulopatia: ATRA na suspeita, antes da confirmação molecular

Cronologia **Gabarito A**

Mulher de 34 anos, previamente hígida, é admitida com gengivorragia e equimoses extensas há 3 dias. Exame: PA 118 × 74 mmHg, FC 104 bpm, equimoses em tronco e membros, sem esplenomegalia. Exames: Hb 7,8 g/dL, leucócitos 1.900/mm³, plaquetas 18.000/mm³, INR 1,7, TTPa 38 s (controle 30 s), fibrinogênio 85 mg/dL, D-dímero muito elevado. Esfregaço de sangue periférico: células imaturas com granulação grosseira, núcleo bilobulado e múltiplos bastonetes de Auer em feixes. Foi coletado sangue para RT-PCR de PML-RARA e cariótipo, com resultado previsto em 72 horas; o mielograma está agendado para amanhã. Além de crioprecipitado e transfusão de plaquetas, a conduta mais adequada neste momento é:

O DADO QUE DECIDE

múltiplos bastonetes de Auer em feixes

Resolução. O raciocínio de manual é confirmar antes de tratar: o mielograma de amanhã e o PML-RARA em 72 horas parecem a ordem natural, e esperar só até o mielograma soa prudente. O que decide é a morfologia já disponível no sangue periférico: promielócitos hipergranulares com bastonetes de Auer em feixes, junto de fibrinogênio de 85 e D-dímero muito alto, é suspeita de leucemia promielocítica com coagulopatia, e a principal causa de morte na LPA é hemorragia nos primeiros dias, pela coagulopatia de consumo e hiperfibrinólise. Por isso a suspeita obriga o ácido all-trans retinoico na hora, sem esperar mielograma nem genética: ele diferencia os promielócitos e corrige a coagulopatia em dias, e se a confirmação vier negativa o ATRA é suspenso sem prejuízo. O suporte mira fibrinogênio acima de 100 a 150 mg/dL e plaquetas acima de 30.000 a 50.000/mm³. Com leucócitos abaixo de 10.000, é LPA de baixo risco, tratada com ATRA e trióxido de arsênio.

A) Iniciar ácido all-trans retinoico já CORRETA

Correta. Suspeita morfológica de LPA com coagulopatia: ATRA imediato, sem esperar a confirmação, porque a mortalidade hemorrágica precoce se concentra nos primeiros dias.

B) Aguardar o PML-RARA para iniciar ATRA

Errada. Esperar 72 horas pela biologia molecular deixa a coagulopatia ativa no período de maior risco de hemorragia fatal; a confirmação define o esquema depois, não o início do ATRA.

C) Iniciar ATRA após o mielograma ARMADILHA

Errada. É a armadilha: parece prudente esperar só um dia, mas o mielograma não é condição para o ATRA; a suspeita no sangue periférico com coagulopatia já o indica, e o primeiro dia é o de maior risco de hemorragia fatal.

D) Indução com citarabina e antraciclina

Errada. Seria a indução de uma LMA não promielocítica; na LPA a base é ATRA com arsênio, e quimioterapia sem ATRA piora a coagulopatia.

Para levar. Suspeita de LPA (promielócitos com bastonetes de Auer em feixes e coagulopatia) indica ATRA na hora, antes do mielograma e do PML-RARA, com suporte de fibrinogênio e plaquetas.

ELN 2019 recomendações para LPA (Sanz et al., Blood 2019); NCCN Acute Myeloid Leukemia 2025.

---

51 Infectologia · Pneumonia por Mycoplasma com anemia hemolítica por crioaglutinina no tabagista com DPOC: escolha do antimicrobiano

Rótulo verdadeiro — Gabarito C

Homem de 62 anos, tabagista de 40 maços-ano, com DPOC GOLD 2 em uso de tiotrópio, procura atendimento por tosse seca persistente, febre baixa, cefaleia e mal-estar há 9 dias; há 3 dias notou urina escura e cansaço desproporcional. A neta de 15 anos, que mora com ele, teve quadro respiratório semelhante há 3 semanas. Exame: T 37,9 °C, FR 20 irpm, FC 96 bpm, PA 128 × 80 mmHg, SpO2 94% em ar ambiente, mucosas descoradas 2+/4+ e ictéricas 1+/4+, estertores finos em base esquerda; orientado. Radiografia: infiltrado reticulonodular em lobo inferior esquerdo, sem consolidação lobar. Hb 9,1 g/dL, reticulócitos 6%, leucócitos 9.800/mm³, bilirrubina indireta 2,8 mg/dL, LDH 640 U/L, haptoglobina indetectável, ureia 34 mg/dL. O esfregaço mostra aglutinação de hemácias à temperatura ambiente. Teste de antiglobulina direto positivo para C3d e negativo para IgG. O antimicrobiano mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

Teste de antiglobulina direto positivo para C3d e negativo para IgG

Resolução. O tabagista com DPOC traz o rótulo de pneumonia por pneumococo e H. influenzae, e amoxicilina-clavulanato é o reflexo (e uma posição frequente da própria UERJ na PAC). Mas o quadro tem assinatura etiológica: tosse seca arrastada, cefaleia, infiltrado reticulonodular, caso semelhante em adolescente da casa e, sobretudo, hemólise com aglutinação a frio e Coombs direto positivo só para C3d, que é a marca do anticorpo frio (IgM) da crioaglutinina. Isso é Mycoplasma pneumoniae, que não tem parede celular: nenhum betalactâmico funciona, por mais amplo que seja. O tratamento é um macrolídeo (azitromicina), com doxiciclina ou quinolona respiratória como alternativas. A hemólise costuma ser autolimitada; proteger do frio e transfundir aquecido se necessário.

A) Amoxicilina-clavulanato ARMADILHA

Errada. É a armadilha: cobre pneumococo e H. influenzae do DPOC, mas não age em Mycoplasma, que não tem parede; o Coombs C3d define o agente.

B) Cefuroxima

Errada. Cefalosporina oral seria opção em PAC por pneumococo ou hemófilo; é inativa contra Mycoplasma pela mesma razão.

C) Azitromicina CORRETA

Correta. Macrolídeo trata o Mycoplasma, apontado pela anemia hemolítica por crioaglutinina (C3d positivo, IgG negativo).

D) Ceftriaxona

Errada. Ceftriaxona seria parte do esquema hospitalar de PAC grave, associada a macrolídeo; isolada, falha no Mycoplasma.

Para levar. Pneumonia com hemólise e Coombs direto positivo só para C3d é crioaglutinina, e crioaglutinina na pneumonia é Mycoplasma: betalactâmico não serve, trate com macrolídeo, doxiciclina ou quinolona.

Diretrizes Brasileiras para Pneumonia Adquirida na Comunidade em Adultos (SBPT, 2018); ATS/IDSA Community-Acquired Pneumonia Guideline (2019).

---

52 Pneumologia · TEP de risco intermediário-alto: anticoagulação e vigilância, sem trombólise primária

Grade X / Y **Gabarito D**

Mulher de 58 anos, no 9º dia de pós-operatório de artroplastia de quadril, apresenta dispneia súbita e dor pleurítica. Exame: PA 112 × 70 mmHg (habitual 130 × 80 mmHg), FC 112 bpm, FR 24 irpm, SpO2 91% em ar ambiente, sem sinais de hipoperfusão, diurese preservada. Lactato 1,6 mmol/L. Angiotomografia: falhas de enchimento em ambas as artérias pulmonares principais, com relação VD/VE de 1,3. Troponina I ultrassensível 96 ng/L (VR até 16). Na hora seguinte, sob heparina não fracionada, mantém PA sistólica entre 104 e 112 mmHg. A classificação de risco e a conduta mais adequada são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

mantém PA sistólica entre 104 e 112 mmHg

Resolução. Trombo em ambas as pulmonares principais, VD dilatado e troponina alta assustam e puxam para a trombólise. Mas a classificação de alto risco da ESC exige instabilidade hemodinâmica: PA sistólica abaixo de 90 mmHg (ou queda de 40 mmHg ou mais) por mais de 15 minutos, necessidade de vasopressor ou parada. A paciente mantém sistólica acima de 100, sem hipoperfusão e com lactato normal. Com sPESI de 1 (FC acima de 110), disfunção de VD na imagem e troponina elevada, ela é de risco intermediário-alto. Nesse grupo, o PEITHO mostrou que a trombólise sistêmica evita descompensação à custa de mais sangramento grave e AVC hemorrágico, sem ganho de mortalidade: a conduta é anticoagular (heparina não fracionada, que permite reversão rápida) e monitorizar, com trombólise de resgate se houver deterioração. A cirurgia de grande porte há 9 dias ainda aumenta o risco de sangramento.

A) Alto / trombólise sistêmica imediata

Errada. Seria a resposta com choque ou hipotensão sustentada; a paciente não preenche critério de alto risco.

B) Alto / anticoagulação e monitorização

Errada na classificação. A conduta estaria certa, mas sem instabilidade hemodinâmica não é alto risco, e chamar de alto risco levaria à trombólise.

C) Intermediário-alto / trombólise sistêmica imediata ARMADILHA

Errada, e é a armadilha. A classificação está certa, mas trombólise primária no intermediário-alto aumenta sangramento sem reduzir mortalidade; fica reservada ao resgate se houver deterioração.

D) Intermediário-alto / anticoagulação e monitorização CORRETA

Correta. sPESI 1, VD/VE de 1,3 e troponina alta sem hipotensão: intermediário-alto, com anticoagulação parenteral e monitorização em unidade intensiva.

Para levar. Trombólise sistêmica primária é para o TEP de alto risco (instabilidade hemodinâmica); no intermediário-alto, anticoagula, monitoriza e reserva a trombólise para o resgate.

ESC 2019 (embolia pulmonar aguda); PEITHO (N Engl J Med 2014)

---

53 Endocrinologia · Hipoglicemia hiperinsulinêmica: sulfonilureia antes de localizar insulinoma

Rótulo verdadeiro | Gabarito A

Mulher de 44 anos, técnica de enfermagem em enfermaria de clínica médica, sem diabetes, é levada ao pronto-socorro pela terceira vez em dois meses por sudorese, confusão e fala arrastada, que melhoram com glicose venosa. Mora com a mãe, que tem diabetes tipo 2. Nega etilismo, emagrecimento ou uso de medicamentos. Exame: IMC 24 kg/m², sem alterações. No episódio de hoje, antes da glicose: glicemia 36 mg/dL, insulina 28 µUI/mL (na hipoglicemia, abaixo de 3), peptídeo C 3,9 ng/mL (abaixo de 0,6), pró-insulina 14 pmol/L (abaixo de 5), beta-hidroxibutirato 0,1 mmol/L (acima de 2,7), anticorpo anti-insulina negativo. Creatinina, cortisol e função hepática normais. O próximo passo mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

Mora com a mãe, que tem diabetes tipo 2

Resolução. Glicemia de 36 com insulina, peptídeo C e pró-insulina inapropriadamente altos e cetona suprimida é hiperinsulinismo endógeno, e o rótulo verdadeiro (perfil de insulinoma) leva direto à imagem do pâncreas. Só que esse mesmo perfil é idêntico ao da ingestão de secretagogo: a sulfonilureia estimula a célula beta, que libera insulina, peptídeo C e pró-insulina juntos. Insulina exógena seria a outra factícia, mas daria peptídeo C suprimido. Por isso o passo obrigatório antes de localizar é a pesquisa de sulfonilureias e glinidas no plasma colhido no episódio. Profissional de saúde com acesso a hipoglicemiantes em casa (a mãe diabética) aumenta a probabilidade pré-teste. O jejum de 72 horas é desnecessário quando a hipoglicemia espontânea já foi documentada com os exames.

A) Dosagem de sulfonilureias no plasma CORRETA

Correta. Insulina, peptídeo C e pró-insulina altos não separam insulinoma de sulfonilureia; a dosagem do fármaco é o que falta antes da imagem.

B) Jejum supervisionado de 72 horas

Errada. Serve para provocar a hipoglicemia quando ela não foi documentada; aqui a tríade de Whipple e os exames já foram obtidos no episódio.

C) Ecoendoscopia pancreática

Errada. É o exame de localização mais sensível para insulinoma, mas vem depois da confirmação bioquímica completa.

D) Tomografia de pâncreas com contraste ARMADILHA

Errada. Seria o passo com rastreio de secretagogos negativo; localizar antes de excluir a factícia pode levar a pancreatectomia sem tumor.

Para levar. Hiperinsulinismo endógeno (insulina, peptídeo C e pró-insulina altos) só vira insulinoma depois de rastreio negativo para sulfonilureia; peptídeo C baixo aponta insulina exógena.

Endocrine Society, Evaluation and Management of Adult Hypoglycemic Disorders (Cryer et al., J Clin Endocrinol Metab 2009).

---

54 Oncologia · CEA elevado em tabagista assintomático: marcador tumoral não é rastreamento

Omissão **Gabarito B**

Homem de 63 anos, tabagista ativo de 40 maços-ano, assintomático, fez exames de rotina em check-up particular, que incluíram antígeno carcinoembrionário (CEA) de 6,1 ng/mL (referência até 5,0 ng/mL). Colonoscopia de rastreamento há 2 anos sem pólipos. TC de tórax de baixa dose, feita no programa de rastreamento de câncer de pulmão há 4 meses: Lung-RADS 1. Sem perda de peso, sem alteração do hábito intestinal, sem anemia; hemograma e funções hepática e renal normais; exame físico normal. Diante do CEA, a conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

tabagista ativo de 40 maços-ano, assintomático

Resolução. CEA acima da referência em um homem de 63 anos parece pedir caça ao tumor, e a TC de tórax, abdome e pelve é o que o apressado solicita. Mas marcador tumoral não serve para rastreamento nem para diagnóstico em assintomático: o CEA tem baixa sensibilidade e especificidade, e o tabagismo ativo o eleva até cerca de 10 ng/mL em pessoas sem câncer. Este paciente está em dia com os rastreamentos que importam (colonoscopia há 2 anos e TC de baixa dose há 4 meses, Lung-RADS 1), sem sinal de alarme. A conduta é não investigar nem repetir o marcador; o uso adequado do CEA é o seguimento após ressecção de câncer colorretal.

A) PET-CT de corpo inteiro

Errada. PET-CT para marcador isolado em assintomático gera achados incidentais e procedimentos sem benefício; nenhuma diretriz o indica.

B) Nenhum exame adicional pelo CEA CORRETA

Correta. CEA de 6,1 ng/mL em tabagista assintomático, com rastreamentos em dia, não se investiga: marcador não é exame de rastreamento.

C) TC de tórax, abdome e pelve ARMADILHA

Errada. É a isca: seria pertinente com sintoma, sinal de alarme ou câncer tratado em seguimento; aqui é investigação de um exame que não deveria ter sido pedido.

D) Nova colonoscopia

Errada. A colonoscopia sem pólipos de 2 anos atrás vale por 10 anos; o CEA não antecipa o intervalo.

Para levar. Marcadores tumorais (CEA, CA 19-9, CA-125, CA 15-3) não rastreiam nem diagnosticam câncer em assintomático; tabagismo eleva o CEA.

ASCO 2006 Update of Recommendations for the Use of Tumor Markers in Gastrointestinal Cancer; INCA, Detecção precoce do câncer (2021)

---

55 Reumatologia · Artrite psoriásica com fator reumatoide positivo e psoríase oculta na fenda interglútea

Rótulo verdadeiro **Gabarito C**

Mulher de 46 anos refere dor e edema em mãos e pés há 8 meses, com rigidez matinal de 40 minutos. Nos últimos 2 meses, o terceiro pododáctilo direito ficou inteiro edemaciado e doloroso. A mãe tem nódulos nos dedos desde os 50 anos. Usa apenas dipirona. Exame físico: artrite das interfalângicas distais do 2º e 3º dedos da mão direita e da interfalângica proximal do 4º dedo esquerdo, poupando as demais, edema difuso e doloroso de todo o terceiro pododáctilo direito, depressões puntiformes em 4 unhas com onicólise distal, e placa eritematodescamativa de 3 cm na fenda interglútea, que a paciente atribuía a micose. Exames: VHS 38 mm/h, PCR 2,1 mg/dL, fator reumatoide 24 UI/mL (VR < 14), anti-CCP não reagente, ácido úrico 5,8 mg/dL. Radiografia de mãos: erosão em interfalângica distal com proliferação óssea adjacente. O diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

edema difuso e doloroso de todo o terceiro pododáctilo direito

Resolução. O fator reumatoide positivo e a poliartrite de mãos puxam para artrite reumatoide, e os nódulos da mãe puxam para osteoartrite. Mas o padrão é assimétrico, com interfalângicas distais, e há dactilite (o dedo inteiro edemaciado, em salsicha), distrofia ungueal (depressões puntiformes e onicólise), uma placa de psoríase escondida na fenda interglútea e, na radiografia, erosão com neoformação óssea justa-articular. Pelos critérios CASPAR, psoríase atual (2 pontos), distrofia ungueal, dactilite e neoformação óssea somam 5, muito acima dos 3 necessários, mesmo sem o ponto do fator reumatoide negativo. O fator reumatoide em título baixo existe em parte da população e em até 10% da artrite psoriásica, e o anti-CCP negativo enfraquece a artrite reumatoide. A artrite reumatoide poupa as interfalângicas distais e não faz dactilite nem proliferação óssea.

A) Osteoartrite erosiva de mãos

Errada. A osteoartrite erosiva acomete interfalângicas com erosão central em asa de gaivota, sem dactilite, sem distrofia ungueal e sem provas inflamatórias altas.

B) Gota poliarticular

Errada. A gota poliarticular cursa com hiperuricemia e tofos, e o ácido úrico normal fora de crise e a dactilite com unha psoriásica não sustentam.

C) Artrite psoriásica CORRETA

Correta. Dactilite, unha, psoríase na fenda interglútea e neoformação óssea fecham CASPAR com folga, e o fator reumatoide baixo não exclui.

D) Artrite reumatoide soropositiva ARMADILHA

Errada. Seria a resposta com poliartrite simétrica de metacarpofalângicas e interfalângicas proximais, anti-CCP reagente e erosões marginais sem neoformação; aqui há interfalângica distal, dactilite e unha.

Para levar. Dactilite, interfalângica distal e unha com depressões são artrite psoriásica até prova contrária; procure a psoríase no couro cabeludo, umbigo e fenda interglútea. Fator reumatoide baixo não muda o diagnóstico.

Critérios CASPAR (2006); GRAPPA 2021 treatment recommendations; Kelley & Firestein's Textbook of Rheumatology, 11ª ed. (2021).

---

56 Neurologia · Transtorno do controle de impulsos por agonista dopaminérgico fora da doença de Parkinson

Droga a deduzir **Gabarito A**

Mulher de 58 anos, professora, é trazida pelo marido porque, nos últimos 4 meses, gastou as economias do casal em apostas on-line e passou a comprar compulsivamente roupas que não usa; ela minimiza o problema. Há 14 meses iniciou tratamento para desconforto nas pernas ao deitar, com necessidade de movê-las, que melhorava ao caminhar; a dose do medicamento foi aumentada há 6 meses, com bom controle. Nega episódios prévios de humor elevado, redução da necessidade de sono, uso de álcool e história familiar psiquiátrica. Exame neurológico normal, sem parkinsonismo. Mini-exame do estado mental 29. Ferritina 110 ng/mL. A causa mais provável do comportamento atual é:

O DADO QUE DECIDE

Há 14 meses iniciou tratamento para desconforto nas pernas ao deitar

Resolução. A droga não é nomeada: o desconforto nas pernas ao deitar, que obriga a movê-las e melhora ao caminhar, é síndrome das pernas inquietas, e a primeira linha por muitos anos foram os agonistas dopaminérgicos (pramipexol, ropinirol, rotigotina). Jogo patológico e compras compulsivas iniciados meses depois de aumento de dose são transtorno do controle de impulsos, efeito de classe dos agonistas (receptor D3), que aparece também fora da doença de Parkinson e em doses baixas. A demência frontotemporal atrai pela idade e pela desinibição, mas não começa por compulsão isolada com cognição e exame normais, e a cronologia com a droga é o dado que decide. Hipomania exigiria humor elevado e redução da necessidade de sono, negados. O fenômeno de aumento é complicação dopaminérgica real, mas é piora dos próprios sintomas sensitivos (mais cedo no dia, em mais segmentos), não mudança de comportamento. A conduta é reduzir e retirar o agonista devagar e migrar para alfa-2-delta, primeira linha atual.

A) Efeito adverso de agonista dopaminérgico CORRETA
Correta. Pernas inquietas tratadas com agonista dopaminérgico, aumento de dose e, meses depois, jogo e compras compulsivas: transtorno do controle de impulsos induzido pela droga.

B) Episódio hipomaníaco de transtorno bipolar
Errada. Hipomania explicaria gastos excessivos, mas exige humor elevado e menor necessidade de sono, ambos negados.

C) Demência frontotemporal, variante comportamental ARMADILHA
Errada, é a armadilha. Desinibição aos 58 anos lembra a variante comportamental, mas ela vem com apatia, perda de empatia e alteração executiva progressivas; aqui há só compulsão, com relação temporal com a droga.

D) Fenômeno de aumento (augmentation)
Errada. O aumento é a piora das pernas inquietas induzida pelo tratamento dopaminérgico (sintomas mais precoces e extensos), não alteração de comportamento.

Para levar. Jogo, compras, hipersexualidade ou hiperfagia novos: procurar agonista dopaminérgico, inclusive o das pernas inquietas. Conduta: retirar devagar e trocar por alfa-2-delta.

AASM 2024 (tratamento da síndrome das pernas inquietas); MDS Evidence-Based Review 2018 (transtornos do controle de impulsos).

---

57 Cardiologia · Atividade elétrica sem pulso com QRS largo e lento: hipercalemia em IC com bloqueio do SRAA

Rótulo verdadeiro **Gabarito C**

Homem de 71 anos, com IC de fração de ejeção reduzida (FE 25%) e cardiodesfibrilador implantável, em uso de sacubitril-valsartana, espironolactona, carvedilol e dapagliflozina, e doença renal crônica com creatinina basal de 1,8 mg/dL, teve diarreia aquosa por 4 dias com pouca ingesta. É levado à emergência por fraqueza e perde a consciência na triagem. Monitor: ritmo organizado com QRS de 200 ms, a 40 bpm, sem pulso central palpável. O cardiodesfibrilador não disparou. Iniciadas compressões e adrenalina. Glicemia capilar 132 mg/dL. Antes da parada não havia turgência jugular, e não há trauma. A causa mais provável da parada é:

O DADO QUE DECIDE

ritmo organizado com QRS de 200 ms, a 40 bpm

Resolução. A diarreia de 4 dias com pouca ingesta é um rótulo verdadeiro que puxa para hipovolemia, uma das causas reversíveis da atividade elétrica sem pulso. Mas o ritmo decide: AESP de QRS estreito e rápido sugere causa mecânica (hipovolemia, tamponamento, pneumotórax, TEP), e AESP de QRS largo e lento sugere causa metabólica ou isquêmica, com hipercalemia à frente. Este paciente reúne todos os ingredientes da hipercalemia: sacubitril-valsartana e espironolactona, doença renal crônica e lesão renal aguda pré-renal pela diarreia, que derruba a excreção de potássio. A conduta, além do protocolo, é gluconato ou cloreto de cálcio IV imediatamente, seguido de insulina com glicose e bicarbonato; a dosagem de potássio em gasometria confirma, mas não deve atrasar o cálcio.

A) Síndrome coronariana aguda
Errada. Síndrome coronariana pode dar AESP de QRS largo, mas não há dor, e o contexto de drogas, rim e diarreia aponta outra causa mais provável.

B) Tromboembolismo pulmonar
Errada. O TEP maciço dá AESP com QRS estreito e taquicárdico, com turgência jugular e dilatação de VD; a turgência estava ausente.

C) Hipercalemia CORRETA
Correta. QRS de 200 ms a 40 bpm, em quem usa sacubitril-valsartana e espironolactona, com doença renal e desidratação: hipercalemia, tratada com cálcio IV já.

D) Hipovolemia ARMADILHA
Errada, e é a armadilha. A hipovolemia existe, mas produz AESP de QRS estreito e rápido; QRS muito largo e lento não é dela.

Para levar. Na AESP, olhe o QRS: estreito e rápido sugere causa mecânica (hipovolemia, tamponamento, TEP, pneumotórax); largo e lento sugere metabólica (hipercalemia, acidose, intoxicação por bloqueador de sódio) ou isquemia extensa.

AHA 2020 (adult advanced life support) e atualização focada 2023; Atualização da Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de Emergência da SBC (2019); KDIGO Controversies Conference 2020 (potassium)

---

58 Infectologia · Coinfecção HIV e tuberculose: ajuste do dolutegravir com rifampicina

Droga a deduzir **Gabarito D**

Homem de 41 anos, vivendo com HIV há 2 anos, em uso regular do esquema antirretroviral inicial preconizado pelo Ministério da Saúde (um comprimido de tenofovir com lamivudina e um comprimido do terceiro fármaco, ambos uma vez ao dia), tem carga viral indetectável e CD4 410 células/mm³. Há 5 semanas apresenta tosse produtiva, febre vespertina e perda de 5 kg. Radiografia: cavitação em ápice direito. TRM-TB no escarro: M. tuberculosis detectado, sem resistência à rifampicina. Creatinina 0,9 mg/dL, ALT 28 U/L. Inicia-se RHZE em dose plena por peso. Em relação ao esquema antirretroviral, a conduta mais adequada é:

> O DADO QUE DECIDE
>
> *um comprimido de tenofovir com lamivudina e um comprimido do terceiro fármaco, ambos uma vez ao dia*

Resolução. O enunciado não nomeia o terceiro fármaco, mas o esquema inicial do Ministério da Saúde é tenofovir com lamivudina e dolutegravir 50 mg uma vez ao dia. Quem não deduz a droga mantém o esquema, já que a carga viral está indetectável. A rifampicina é indutora potente de UGT1A1 e CYP3A4 e reduz muito o nível do dolutegravir; a solução é dobrar a dose para 50 mg de 12/12 horas durante todo o uso de rifampicina e por mais 15 dias após o fim dela, sem trocar o esquema que funciona. Efavirenz foi a escolha antiga para TB e HIV, e rifabutina é a saída quando o paciente usa inibidor de protease potencializado, situação em que a rifampicina é contraindicada.

A) Manter o esquema sem alteração ARMADILHA
Errada. É a armadilha: manter seria correto se a tuberculose fosse tratada sem rifampicina (com rifabutina, por exemplo); com dolutegravir uma vez ao dia, a rifampicina derruba o nível do antirretroviral e expõe a falha virológica e a resistência.

B) Trocar o terceiro fármaco por efavirenz
Errada. Efavirenz era a opção antiga para coinfecção; hoje se mantém o dolutegravir com ajuste de dose, sem trocar um esquema suprimido.

C) Substituir rifampicina por rifabutina
Errada. Rifabutina é indicada quando o esquema contém inibidor de protease potencializado com ritonavir; com dolutegravir, a rifampicina é mantida.

D) Dolutegravir 50 mg de 12/12 horas CORRETA
Correta. O terceiro fármaco do esquema inicial é dolutegravir, que deve ser dobrado para 12/12 horas enquanto durar a rifampicina e por 15 dias depois.

Para levar. Rifampicina com dolutegravir: dobre o dolutegravir (50 mg de 12/12 h) até 15 dias após o fim da rifampicina; rifabutina é reservada para quem usa inibidor de protease potencializado.

PCDT para Manejo da Infecção pelo HIV em Adultos (MS, 2024); Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil (MS, 2019, atualizado).

---

59 Nefrologia · Acidose hiperclorêmica no Sjögren · ânion gap urinário: acidose tubular distal x perda intestinal

Rótulo verdadeiro **Gabarito C**

Mulher de 46 anos, com síndrome de Sjögren primária (anti-Ro reagente) há seis anos, em uso de hidroxicloroquina, procura atendimento por fraqueza e cãibras há três semanas. Há cinco semanas toma diariamente um chá de sene para emagrecer, com quatro a cinco evacuações amolecidas por dia. Nega litíase renal. Exame: PA 108/70 mmHg, FC 96 bpm, sem edema. Exames séricos: sódio 137 mEq/L, potássio 2,9 mEq/L, cloro 114 mEq/L, bicarbonato 14 mEq/L, pH 7,29, pCO2 30 mmHg, albumina 4,0 g/dL, creatinina 0,8 mg/dL. Urina de amostra: pH 6,0, sódio 38 mEq/L, potássio 30 mEq/L e cloro 92 mEq/L. A causa mais provável da acidose é:

O DADO QUE DECIDE

sódio 38 mEq/L, potássio 30 mEq/L e cloro 92 mEq/L

Resolução. Sjögren com acidose hiperclorêmica, hipocalemia e pH urinário de 6,0 parece fechar acidose tubular distal, e é para lá que o anti-Ro empurra. Mas o pH urinário engana na diarreia: a hipocalemia estimula a amoniogênese, e a amônia tampona a urina, que pode ficar acima de 5,5 mesmo com excreção ácida máxima. Quem separa é o ânion gap urinário (sódio mais potássio menos cloro), que estima o amônio: 38 + 30 - 92 = -24, negativo, ou seja, o rim excreta muito amônio (acompanhado de cloro), a resposta adequada a uma perda extrarrenal de bicarbonato. Na ATR distal o rim não consegue excretar amônio e o ânion gap urinário é positivo. O ânion gap sérico é 9, normal, e a pCO2 de 30 está dentro do esperado por Winters (1,5 × 14 + 8 = 29 ± 2). O chá de sene diário é a causa.

A) Acidose tubular renal proximal (tipo 2)
Errada. A ATR proximal estabiliza o bicarbonato entre 15 e 18, acidifica a urina quando o bicarbonato está baixo e costuma vir com glicosúria, fosfatúria e hipouricemia (Fanconi); nada disso aparece.

B) Acidose tubular renal distal (tipo 1) ARMADILHA
Errada, é a armadilha. Sjögren é a causa adquirida mais lembrada de ATR distal, e o pH urinário acima de 5,5 parece confirmar, mas na ATR distal o ânion gap urinário seria positivo; o valor de -24 mostra amônio urinário alto.

C) Perda intestinal de bicarbonato CORRETA
Correta. Acidose hiperclorêmica com ânion gap urinário negativo indica excreção renal de amônio preservada e perda de bicarbonato fora do rim: as evacuações do laxante.

D) Acidose tubular renal tipo 4
Errada. A ATR tipo 4 cursa com hipercalemia, não hipocalemia, e ânion gap urinário positivo; é a do diabético com hipoaldosteronismo hiporreninêmico ou em uso de IECA, espironolactona ou trimetoprima.

Para levar. Na acidose hiperclorêmica, o ânion gap urinário (Na + K - Cl) negativo indica perda intestinal, e positivo indica acidose tubular; o pH urinário acima de 5,5 não separa quando há hipocalemia.

Kraut e Madias, Nat Rev Nephrol 2010 (acidose metabólica e ânion gap urinário); Harrison 21ª ed. (Acid-Base Disorders); UpToDate 2025 (Approach to the adult with metabolic acidosis).

---

60 Geriatria · Delirium hipoativo no pós-operatório confundido com depressão

Negativo no meio **Gabarito C**

Mulher de 82 anos, viúva há 3 meses, está no 3º dia de pós-operatório de fratura de fêmur. Antes da queda era independente, administrava as próprias finanças e teve MEEM de 28 pontos há 6 meses. Usa tramadol para a dor e oxibutinina, iniciada ontem por urgência miccional após retirada da sonda. Desde ontem passa a maior parte do dia sonolenta, responde com monossílabos, não consegue dizer os meses do ano de trás para frente e em alguns momentos não reconhece a filha, mas no fim da tarde conversou normalmente. A filha diz que "a mãe está deprimida pela viuvez". Não apresenta agitação, alucinações ou febre. Exame: PA 132 × 74 mmHg, FC 86 bpm, SpO2 95%, sem déficit focal. Glicemia 118 mg/dL, Na 137 mEq/L. O diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

não consegue dizer os meses do ano de trás para frente

Resolução. A viuvez recente, a lentidão e as respostas monossilábicas fazem a família, e muitos médicos, falarem em depressão, e a ausência de agitação afasta o delirium para quem o imagina sempre hiperativo. Mas o quadro tem início agudo (desde ontem), flutuação (normal no fim da tarde), desatenção objetiva (falha nos meses ao contrário) e alteração do nível de consciência (sonolência): preenche o CAM. Há gatilhos claros: idosa no pós-operatório de fratura de fêmur, opioide (tramadol) e anticolinérgico (oxibutinina) iniciados. O subtipo hipoativo é o mais frequente no idoso e o mais subdiagnosticado, com pior prognóstico. Depressão não flutua em horas nem compromete a atenção desse modo, e demência não começa em um dia em quem tinha MEEM de 28.

A) Episódio depressivo maior ARMADILHA
Errada, e é a armadilha. Depressão tem curso de semanas, sem flutuação ao longo do dia e com atenção preservada; a viuvez é verdadeira, mas não explica o início abrupto nem a desatenção.

B) Demência com corpos de Lewy
Errada. Lewy flutua, mas é demência de evolução crônica, com alucinações visuais e parkinsonismo; não surge em um dia em quem era independente.

C) Delirium hipoativo CORRETA
Correta. Início agudo, flutuação, desatenção e sonolência no pós-operatório, com opioide e anticolinérgico: delirium hipoativo pelo CAM.

D) Doença de Alzheimer
Errada. Alzheimer é insidioso, com perda de memória ao longo de anos; MEEM de 28 há 6 meses e início abrupto afastam.

Para levar. Delirium é diagnóstico de atenção e de tempo (início agudo e flutuação), não de agitação; o hipoativo é o mais comum no idoso e se confunde com depressão.

CAM (Inouye, 1990); American Geriatrics Society 2015 (delirium pós-operatório); NICE CG103 (atualização 2023); Critérios de Beers AGS 2023

---

61 Hematologia · Deficiência de cobre após bariátrica com displasia medular: excluir causa secundária antes de rotular SMD

Rótulo verdadeiro **Gabarito D**

Mulher de 54 anos, submetida a derivação gástrica em Y de Roux há 9 anos, procura atendimento por cansaço progressivo e formigamento nos pés há 6 meses, com desequilíbrio ao andar no escuro. Usa polivitamínico de forma irregular e, por conta própria, comprimidos de zinco 50 mg/dia há 2 anos "para a imunidade". Exame: hipocorada 2+/4, Romberg positivo, reflexos patelares vivos, sensibilidade vibratória abolida até os joelhos. Exames: Hb 8,4 g/dL, VCM 101 fL, reticulócitos 0,6%, leucócitos 2.100/mm³ (neutrófilos 700/mm³), plaquetas 198.000/mm³, vitamina B12 610 pg/mL, ácido metilmalônico normal, folato e TSH normais. Mielograma: vacuolização citoplasmática em precursores eritroides e mieloides, sideroblastos em anel em 18% dos eritroblastos, displasia discreta e blastos 1%. O próximo exame mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

comprimidos de zinco 50 mg/dia há 2 anos

Resolução. O mielograma com displasia e sideroblastos em anel é um rótulo verdadeiro que puxa para síndrome mielodisplásica, e o passo seguinte de manual seria o cariótipo. Mas a OMS só aceita chamar de SMD depois de excluir causas secundárias de displasia, e o caso tem três pistas de deficiência de cobre: bariátrica disabsortiva, zinco em dose alta por anos (o zinco induz metalotioneína no enterócito, que sequestra o cobre) e mieloneuropatia de cordão posterior com B12 e ácido metilmalônico normais. A vacuolização de precursores e a neutropenia com anemia são a assinatura medular da falta de cobre, que também produz sideroblastos em anel. O exame que decide é cobre sérico com ceruloplasmina; a reposição corrige as citopenias em semanas, e a neuropatia melhora parcialmente. Rotular SMD aqui levaria a tratamento de neoplasia numa carência reversível.

A) Ressonância de medula cervical

Errada. Seria a resposta numa mielopatia com sinais de compressão; a ressonância pode até mostrar hipersinal de cordão posterior, mas não aponta a causa nem explica as citopenias.

B) Cariótipo de medula óssea ARMADILHA

Errada. Seria o passo para SMD depois de excluídas as causas secundárias; aqui a displasia tem explicação reversível que não foi testada.

C) Pesquisa de mutação SF3B1

Errada. SF3B1 define SMD com sideroblastos em anel quando há neoplasia; sideroblastos em anel também aparecem na falta de cobre e no álcool, e a mutação não se pesquisa antes de excluí-los.

D) Cobre sérico e ceruloplasmina CORRETA

Correta. Bariátrica, zinco em dose alta, mieloneuropatia com B12 normal e vacuolização de precursores apontam deficiência de cobre, que se confirma com cobre e ceruloplasmina baixos.

Para levar. Citopenia com vacuolização de precursores, sideroblastos em anel e mieloneuropatia após bariátrica ou uso de zinco é deficiência de cobre até prova em contrário: dose cobre antes de chamar de SMD.

Classificação OMS 2022 (5ª edição) das neoplasias mieloides; NCCN Myelodysplastic Syndromes 2025; AACE/TOS/ASMBS 2019, diretriz de suporte nutricional, metabólico e não cirúrgico do paciente bariátrico (Mechanick et al.).

---

62 Oncologia · Síndrome da veia cava superior sem sinais de gravidade: biópsia antes de radioterapia ou corticoide

Negativo no meio **Gabarito C**

Homem de 58 anos, tabagista de 50 maços-ano, há 3 semanas tem edema progressivo de face e pescoço, pletora facial e turgência das veias do tórax, piores ao deitar. Sem estridor, sem rouquidão, sem cefaleia, confusão ou síncope. Exame: FR 18 irpm, SpO2 95% em ar ambiente, PA 136 × 84 mmHg, sem tiragem; linfonodo supraclavicular direito de 1,8 cm, endurecido. TC de tórax: massa mediastinal anterior e paratraqueal direita de 7 cm comprimindo a veia cava superior, com colaterais, sem compressão traqueal significativa. Não há diagnóstico histológico e ele não recebeu corticoide. O próximo passo mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

Sem estridor, sem rouquidão, sem cefaleia, confusão ou síncope

Resolução. Síndrome da veia cava superior soa como emergência e puxa radioterapia ou corticoide imediatos, como era a conduta antiga. Hoje a síndrome só é emergência com estridor ou compressão de via aérea, edema cerebral ou instabilidade, e então o primeiro passo é stent endovascular. Sem esses sinais, como aqui, há tempo para o diagnóstico histológico, que define o tratamento: carcinoma de pequenas células e linfoma respondem à quimioterapia, e o linfoma pode ser descaracterizado por corticoide ou radioterapia prévios. O linfonodo supraclavicular palpável oferece o acesso menos invasivo para a biópsia.

A) Stent endovascular imediato
Errada. Stent é a primeira medida quando há estridor, edema laríngeo ou cerebral ou sintomas graves; não é o caso, e ele não substitui o diagnóstico.

B) Dexametasona intravenosa imediata
Errada. Corticoide sem diagnóstico pode mascarar linfoma; tem papel no linfoma confirmado e no edema da via aérea, não como primeiro passo.

C) Biópsia do linfonodo supraclavicular CORRETA
Correta. Sem estridor nem sinais neurológicos, a prioridade é a histologia, e o linfonodo supraclavicular é o acesso mais simples.

D) Radioterapia mediastinal de urgência ARMADILHA
Errada. É a isca: radioterapia empírica antes da histologia pode impedir o diagnóstico, sobretudo de linfoma, e não é necessária sem compressão de via aérea ou edema cerebral.

Para levar. Síndrome da veia cava superior sem estridor, edema cerebral ou instabilidade não é emergência: biópsia antes de radioterapia ou corticoide; com sintomas graves, stent primeiro.

Yu, Wilson e Detterbeck: classificação e algoritmo da síndrome da veia cava superior (J Thorac Oncol, 2008); NCCN Non-Small Cell Lung Cancer (2025)

---

63 Endocrinologia · Hipocalcemia pós-tireoidectomia por Graves: fome óssea x hipoparatireoidismo

Rótulo verdadeiro **Gabarito C**

Mulher de 41 anos, com doença de Graves de difícil controle (T3 total de 520 ng/dL na última consulta, apesar de metimazol 40 mg/dia) e fosfatase alcalina de 410 U/L no pré-operatório, foi submetida a tireoidectomia total sem intercorrências, com identificação e preservação das quatro paratireoides descritas pelo cirurgião. No segundo dia pós-operatório refere parestesias periorais e nas mãos. Exame: sinal de Chvostek positivo, ferida sem hematoma, voz normal. Exames: cálcio total 7,1 mg/dL (8,5 a 10,2), albumina 3,9 g/dL, fósforo 1,9 mg/dL (2,5 a 4,5), magnésio 1,5 mg/dL (1,7 a 2,4), PTH 112 pg/mL (15 a 65), 25-hidroxivitamina D 32 ng/mL. A causa mais provável da hipocalcemia é:

O DADO QUE DECIDE

PTH 112 pg/mL (15 a 65)

Resolução. Hipocalcemia sintomática no segundo dia de tireoidectomia total é, por frequência, hipoparatireoidismo por lesão ou desvascularização das paratireoides, e esse rótulo verdadeiro decide a resposta de quem não lê o PTH. O PTH de 112 com fósforo baixo diz o contrário: as paratireoides funcionam e estão respondendo à hipocalcemia. A explicação é a fome óssea: a tireotoxicose grave e prolongada causa alta remodelação (a fosfatase alcalina de 410 é o marcador), e a retirada súbita do excesso hormonal faz o osso captar cálcio, fósforo e magnésio. O magnésio baixo é consequência e não causa, porque hipomagnesemia que provoca hipocalcemia suprime ou torna ineficaz o PTH. A vitamina D é suficiente. O tratamento exige cálcio em dose alta, calcitriol e reposição de magnésio, às vezes por semanas.

A) Hipoparatireoidismo pós-cirúrgico ARMADILHA
Errada. Seria a causa com PTH baixo ou inapropriadamente normal e fósforo alto; aqui o PTH está alto e o fósforo baixo.

B) Hipomagnesemia
Errada. Hipomagnesemia causa hipocalcemia com PTH baixo; um magnésio de 1,5 com PTH de 112 é parte da fome óssea.

C) Síndrome da fome óssea CORRETA
Correta. Hipocalcemia com hipofosfatemia, PTH alto e fosfatase alcalina elevada após correção cirúrgica de tireotoxicose grave.

D) Deficiência de vitamina D
Errada. Daria PTH alto e fósforo baixo, mas de forma crônica; 25-hidroxivitamina D de 32 ng/mL é suficiente.

Para levar. Hipocalcemia pós-operatória com PTH alto e fósforo baixo é fome óssea, não hipoparatireoidismo; ocorre após paratireoidectomia e também após tireoidectomia por tireotoxicose grave.

ATA Guidelines for Hyperthyroidism 2016; Second International Workshop on Hypoparathyroidism (J Bone Miner Res 2022).

---

64 Infectologia · Pielonefrite não complicada com leucocitose alta: só urocultura, sem imagem e sem hemocultura

Omissão **Gabarito A**

Mulher de 31 anos, previamente hígida, com beta-HCG negativo, procura o pronto-socorro com febre de 39,4 °C, calafrios, disúria e dor lombar direita há 2 dias. Teve um episódio de cistite há 5 meses, tratado com nitrofurantoína. Nega cálculo urinário, diabetes ou uso recente de antibiótico. Tolera dieta e medicação oral, sem vômitos. Exame: T 38,9 °C, FC 98 bpm, PA 118 × 76 mmHg, FR 16 irpm, bom estado geral, punho-percussão lombar dolorosa à direita, abdome sem defesa. Leucócitos 17.600/mm³ com 8% de bastões, PCR 18 mg/dL, creatinina 0,8 mg/dL. EAS com piócitos incontáveis, nitrito positivo e hematúria microscópica. Após dipirona, fica afebril e sem dor. Antes da primeira dose de antibiótico, a investigação complementar mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

Nega cálculo urinário, diabetes ou uso recente de antibiótico

Resolução. Febre alta, leucocitose com desvio e PCR de 18 mg/dL impressionam e puxam para a imagem, como se fossem sinais de complicação. Não são: a pielonefrite aguda faz exatamente isso. Imagem na pielonefrite é para suspeita de obstrução ou cálculo, sepse, gestação, imunossupressão, recorrência precoce ou falta de melhora em 48 a 72 horas de antibiótico, e hemocultura é para quem interna, está séptico ou imunossuprimido. Esta paciente não tem cálculo, diabetes nem gestação, está estável e tolera via oral: o único exame que muda a conduta é a urocultura com antibiograma, colhida antes do antibiótico para ajustar o esquema depois. O tratamento é oral e ambulatorial (ciprofloxacino por 7 dias, ou uma dose inicial de ceftriaxona antes do oral se a resistência local a quinolona passar de 10%), com reavaliação em 48 a 72 horas.

A) Urocultura, apenas CORRETA
Correta. Pielonefrite sem fator de complicação, em paciente estável que tolera via oral: urocultura com antibiograma é o único exame que muda a conduta.

B) Urocultura e TC de abdome ARMADILHA
Errada. É a armadilha: TC seria indicada sem melhora em 72 horas, com sepse, cálculo conhecido ou suspeita de abscesso; leucocitose e PCR altas, sozinhas, não são critério.

C) Urocultura e ultrassonografia renal
Errada. Ultrassonografia caberia na suspeita de obstrução (cólica, cálculo prévio, rim único) ou na gestante; nenhum desses dados está no caso.

D) Hemoculturas e urocultura
Errada. Hemoculturas entram na paciente internada, séptica ou imunossuprimida; na pielonefrite não complicada tratada em casa, não mudam o manejo.

Para levar. Na pielonefrite, imagem e hemocultura dependem da clínica (obstrução, sepse, gestação, imunossupressão, falha em 72 horas), não da altura da febre, dos leucócitos ou da PCR; a urocultura é sempre colhida.

IDSA/ESCMID Guideline for Acute Uncomplicated Cystitis and Pyelonephritis in Women (2010); EAU Guidelines on Urological Infections (2024).

---

65 Reumatologia · Arterite de células gigantes com amaurose fugaz: corticoide antes da biópsia e janela para a biópsia

Grade X / Y **Gabarito A**

Mulher de 76 anos, hipertensa e diabética tipo 2 (HbA1c 7,4%), procura o pronto-socorro por cefaleia temporal direita há 3 semanas, dor na mandíbula ao mastigar e dor e rigidez nos ombros pela manhã. Ontem teve dois episódios de perda visual monocular direita, indolor, que duraram 5 minutos cada e reverteram totalmente. Exame físico: PA 150 × 86 mmHg, artéria temporal direita espessada, dolorosa e sem pulso, acuidade visual normal, fundoscopia sem edema de papila. Exames: VHS 96 mm/h, PCR 8,4 mg/dL, plaquetas 520.000/mm³, glicemia 210 mg/dL. Ultrassonografia de artérias temporais e biópsia só estão disponíveis no ambulatório do hospital em 5 dias. A dose inicial do glicocorticoide e o momento de iniciá-lo são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

Ontem teve dois episódios de perda visual monocular direita

Resolução. O diabetes mal controlado e a vontade de confirmar o diagnóstico antes de dar corticoide em dose alta empurram para a ordem errada: biopsiar e depois tratar. Na arterite de células gigantes, amaurose fugaz é aviso de neuropatia óptica isquêmica iminente, e a perda visual, quando instalada, raramente volta. Com sintomas visuais, a recomendação é iniciar glicocorticoide imediatamente, de preferência metilprednisolona venosa em pulso por 3 dias, seguida de prednisona em dose alta. A biópsia não perde valor com o corticoide se feita em até 2 semanas, porque a inflamação granulomatosa persiste por semanas, e o ultrassom deve ser feito o quanto antes, de preferência na primeira semana. Prednisona 15 mg é dose de polimialgia isolada, insuficiente para a arterite, e a dor nos ombros aqui é a polimialgia associada, não o diagnóstico principal.

A) Pulso de metilprednisolona / agora CORRETA
Correta. Sintoma visual impõe glicocorticoide em dose alta já, de preferência em pulso venoso; a biópsia continua útil se feita nas 2 semanas seguintes.

B) Pulso de metilprednisolona / após a biópsia ARMADILHA
Errada na segunda metade. A dose está certa, mas esperar 5 dias pela biópsia expõe a paciente à perda visual definitiva, e o corticoide não invalida a biópsia feita em até 2 semanas.

C) Prednisona 15 mg/dia / agora
Errada na primeira metade. Começar já está certo, mas 15 mg/dia é dose de polimialgia reumática isolada e não protege o nervo óptico.

D) Prednisona 15 mg/dia / após a biópsia
Errada nas duas metades. Dose de polimialgia e ainda adiada: seria aceitável só na polimialgia isolada, sem cefaleia, claudicação mandibular ou sintoma visual, e mesmo nela sem esperar biópsia.

Para levar. Arterite de células gigantes com sintoma visual: corticoide em dose alta na hora, biópsia ou ultrassom nas 2 semanas seguintes. O diagnóstico de certeza não justifica esperar.

BSR 2020 guideline for the management of giant cell arteritis; EULAR 2018 recommendations for large vessel vasculitis; ACR/Vasculitis Foundation 2021 GCA guideline.

---

66 Gastroenterologia · Diarreia por ácidos biliares após ressecção ileal curta na doença de Crohn

Rótulo verdadeiro **Gabarito B**

Mulher de 34 anos com doença de Crohn ileal foi submetida há 5 meses a ressecção ileocecal de 60 cm por estenose e está em uso de adalimumabe desde então. Há 4 meses tem 5 a 7 evacuações aquosas por dia, sobretudo após as refeições, sem sangue, sem despertar noturno para evacuar e sem febre; o peso está estável e as fezes não têm gordura visível nem odor fétido. Exame: IMC 22 kg/m², abdome indolor, cicatriz sem fístula. Exames: hemoglobina 12,8 g/dL, PCR 3 mg/L, calprotectina fecal 42 µg/g, albumina 4,1 g/dL, vitamina B12 360 pg/mL. Pesquisa de toxinas de C. difficile negativa. Ileocolonoscopia: anastomose íleo-cólica com mucosa íntegra (Rutgeerts i0). A causa mais provável da diarreia é:

O DADO QUE DECIDE

ressecção ileocecal de 60 cm

Resolução. O rótulo de Crohn puxa para recidiva e troca de biológico, mas a ileocolonoscopia mostra anastomose íntegra (Rutgeerts i0) e a calprotectina é normal: não há atividade inflamatória. A diarreia começou depois da ressecção ileocecal de 60 cm e é aquosa, pós-prandial, sem gordura e com peso estável. Com menos de 100 cm de íleo ressecado, os ácidos biliares deixam de ser reabsorvidos e chegam ao cólon, onde estimulam secreção de água e eletrólitos: diarreia colerética, que responde a sequestrador (colestiramina). Acima de 100 cm o pool de sais biliares se esgota, faltam micelas e o quadro vira esteatorreia com perda de peso, e então a colestiramina piora. Supercrescimento bacteriano é possível sem a válvula ileocecal, mas a B12 normal e a ausência de distensão não o sustentam.

A) Esteatorreia por depleção de sais biliares
Errada. É o quadro da ressecção maior que 100 cm, com fezes gordurosas e fétidas e emagrecimento; com 60 cm e peso estável, o pool de sais biliares está preservado.

B) Má absorção de ácidos biliares CORRETA
Correta. Ressecção ileal menor que 100 cm e diarreia aquosa pós-prandial sem esteatorreia: má absorção de ácidos biliares, tratada com colestiramina.

C) Recidiva pós-operatória do Crohn ARMADILHA
Errada. É a isca: seria a resposta com lesões na anastomose (Rutgeerts i2 ou mais) ou calprotectina elevada; aqui a mucosa está íntegra e a calprotectina é de 42 µg/g.

D) Supercrescimento bacteriano do delgado
Errada. Seria considerado com distensão, flatulência, B12 baixa ou folato alto; a B12 normal e o quadro aquoso pós-prandial apontam para ácido biliar.

Para levar. Ressecção ileal: menos de 100 cm dá diarreia colerética aquosa (colestiramina); mais de 100 cm dá esteatorreia por depleção (dieta pobre em gordura e TCM, sem colestiramina).

BSG guidelines for the investigation of chronic diarrhoea in adults (2018); AGA Clinical Practice Guidelines on the laboratory evaluation of functional diarrhea (2019)

---

67 Neurologia · Morte encefálica após PCR: tempo mínimo de observação na encefalopatia hipóxico-isquêmica

Limiar **Gabarito C**

Pela Resolução CFM nº 2.173/2017, no paciente em coma não perceptivo após parada cardiorrespiratória, com encefalopatia hipóxico-isquêmica como causa, o tempo mínimo de tratamento e observação hospitalar antes de iniciar os procedimentos de determinação de morte encefálica é de:

O DADO QUE DECIDE

encefalopatia hipóxico-isquêmica como causa

Resolução. A regra geral da resolução é de no mínimo 6 horas de tratamento e observação em ambiente hospitalar, e é o número que o apressado marca. A exceção está no qualificador: quando a causa primária é encefalopatia hipóxico-isquêmica (após PCR), a observação mínima é de 24 horas. A razão é que o edema e a depressão pós-anóxica, somados à sedação e à hipotermia do pós-PCR, podem simular ausência de função de tronco nas primeiras horas. As 72 horas são o prazo de prognóstico neurológico no comatoso pós-PCR que não preenche morte encefálica, outra decisão. Os demais pré-requisitos seguem valendo: causa conhecida e irreversível, temperatura acima de 35 °C, SatO2 acima de 94% e PAS de pelo menos 100 mmHg (ou PAM de 65).

A) 6 horas ARMADILHA

Errada, é a armadilha. 6 horas é a regra geral da resolução, que não vale quando a causa é hipóxico-isquêmica.

B) 12 horas

Errada. Na resolução, 12 horas é o intervalo mínimo entre os dois exames clínicos na criança de 2 a 24 meses, não o tempo de observação antes de abrir o protocolo.

C) 24 horas CORRETA

Correta. Na encefalopatia hipóxico-isquêmica, observação mínima de 24 horas após a PCR antes de iniciar o protocolo.

D) 72 horas

Errada. 72 horas é a janela de prognóstico neurológico no coma pós-PCR (ERC/ESICM), não pré-requisito para abrir o protocolo de morte encefálica.

Para levar. Morte encefálica (CFM 2.173/2017): 6 horas de observação em geral, 24 horas se a causa for hipóxico-isquêmica.

Resolução CFM nº 2.173/2017; ERC/ESICM 2021 (prognóstico pós-PCR).

---

68 Cardiologia · Espondilite anquilosante: insuficiência aórtica e bloqueio atrioventricular

Grade X / Y **Gabarito C**

A lesão valvar e o distúrbio do sistema de condução mais associados à espondilite anquilosante são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

espondilite anquilosante

Resolução. A cardiopatia das espondiloartrites ligadas ao HLA-B27 é uma aortite da raiz: a inflamação dilata o anel e retrai as cúspides, e o resultado é insuficiência, não estenose. A fibrose da raiz desce pela cortina mitroaórtica até o septo membranoso, por onde passa o feixe de His, e por isso o distúrbio de condução é o bloqueio atrioventricular (do primeiro grau ao total). A armadilha (estenose aórtica com bloqueio) acerta a metade da condução e erra a da valva, e atrai quem pensa em 'aorta doente, valva calcificada': estenose aórtica com bloqueio é a doença degenerativa do idoso. Estenose mitral com fibrilação atrial troca reumatológica por reumática. É a mesma família de inferência do Marfan e da sífilis terciária: doença da raiz da aorta produz insuficiência aórtica.

A) Estenose mitral / fibrilação atrial
Errada. Estenose mitral com fibrilação atrial é a sequela da febre reumática; 'doença reumatológica' não é 'doença reumática'.

B) Insuficiência aórtica / pré-excitação ventricular
Errada na segunda metade. A valva está certa, mas pré-excitação é via acessória congênita (Wolff-Parkinson-White, anomalia de Ebstein), sem relação com aortite.

C) Insuficiência aórtica / bloqueio atrioventricular CORRETA
Correta. Aortite da raiz com dilatação do anel dá insuficiência aórtica, e a fibrose que invade o septo membranoso dá bloqueio atrioventricular.

D) Estenose aórtica / bloqueio atrioventricular ARMADILHA
Errada na primeira metade, e é a armadilha. O bloqueio está certo, mas a doença da raiz dilata o anel e produz refluxo; estenose aórtica com bloqueio é a calcificação degenerativa do idoso.

Para levar. Doença da raiz da aorta (espondilite, Marfan, sífilis, dissecção) produz insuficiência aórtica; na espondilite e nas espondiloartrites HLA-B27, a fibrose da raiz invade o septo e causa bloqueio atrioventricular.

Braunwald's Heart Disease, 12ª ed. (rheumatic diseases and the heart); ACC/AHA 2020 (valvular heart disease)

---

69 Nefrologia · Síndrome nefrítica após piodermite com FAN reagente · C3 baixo com C4 normal: acompanhar o C3 sem biópsia

Rótulo verdadeiro **Gabarito D**

Homem de 19 anos, previamente hígido, teve lesões crostosas e purulentas nas pernas há três semanas, tratadas com pomada. Há quatro dias nota urina escura, inchaço nas pálpebras e cefaleia. Exame: PA 162/100 mmHg, FC 76 bpm, edema 1+ em membros inferiores, sem estertores, sem lesões cutâneas ativas, sem artrite, sem úlceras orais. Exames: creatinina 1,6 mg/dL na admissão e 1,5 mg/dL após 48 horas, potássio 4,9 mEq/L,

hemograma normal; urina com proteína 2+, 80 hemácias por campo, 70% dismórficas, e cilindros hemáticos; relação proteína/creatinina urinária de 1,1 g/g; anti-DNase B 960 U/mL (até 200); C3 38 mg/dL (90 a 180) e C4 24 mg/dL (10 a 40); FAN reagente 1:80, padrão nuclear pontilhado fino; anti-DNA não reagente. Diurese de 900 mL/dia com furosemida e restrição de sódio. Além do suporte, o próximo passo é:

O DADO QUE DECIDE

C3 38 mg/dL (90 a 180) e C4 24 mg/dL (10 a 40)

Resolução. O FAN reagente e o consumo de complemento puxam para nefrite lúpica e, daí, para a biópsia, que é o exame do degrau seguinte. Mas o padrão do complemento discrimina: C3 baixo com C4 normal indica ativação da via alternativa, que é a da glomerulonefrite pós-estreptocócica (e da glomerulopatia C3); na nefrite lúpica a via clássica consome C3 e C4. FAN 1:80 em padrão pontilhado fino com anti-DNA negativo é achado frequente em pessoas saudáveis e não define lúpus. Há latência compatível (cerca de três semanas após piodermite), anti-DNase B alto (melhor marcador que a ASLO na infecção de pele), creatinina já em queda e proteinúria abaixo da faixa nefrótica. Sem sinal de atipia, a conduta é suporte (restrição de sódio, diurético, anti-hipertensivo) e documentar a normalização do C3, esperada em até seis a oito semanas; a biópsia fica para C3 baixo além de oito semanas, perda rápida de função, proteinúria nefrótica persistente ou sinais sistêmicos.

A) Biópsia renal percutânea ARMADILHA
Errada, é a armadilha. A biópsia seria indicada com C3 baixo após oito semanas, perda rápida de função ou proteinúria nefrótica; aqui a creatinina já cai e o quadro é o da doença autolimitada.

B) Pulsoterapia com metilprednisolona
Errada. Pulso de corticoide é para glomerulonefrite rapidamente progressiva com crescentes e creatinina subindo em dias; na pós-estreptocócica não há benefício do imunossupressor.

C) Dosar ANCA e anti-MBG
Errada. ANCA e anti-MBG investigam glomerulonefrite pauci-imune ou linear, que cursam com complemento normal; o C3 baixo aponta imunocomplexo ou via alternativa.

D) Repetir C3 em oito semanas CORRETA
Correta. C3 baixo com C4 normal, anti-DNase B alto e latência de três semanas após piodermite configuram pós-estreptocócica; o seguimento do C3 confirma o diagnóstico e define se haverá biópsia.

Para levar. Na síndrome nefrítica, C3 baixo com C4 normal é via alternativa (pós-estreptocócica, glomerulopatia C3), e C3 e C4 baixos é via clássica (lúpus, crioglobulinemia). Na pós-estreptocócica o C3 normaliza em até oito semanas, e só a persistência indica biópsia.

KDIGO 2021 (Glomerular Diseases), glomerulonefrite associada a infecção; Riella, Princípios de Nefrologia e Distúrbios Hidroeletrolíticos (2024).

---

70 Hematologia · Hemocomponente após fludarabina: irradiar, e o filtro de leucócitos não substitui a irradiação

Grade X / Y **Gabarito B**

Homem de 71 anos, com leucemia linfocítica crônica tratada há 8 meses com esquema que incluiu fludarabina, vai receber concentrado de hemácias por anemia sintomática. Não tem antecedente de reação transfusional

nem deficiência de IgA. No hemocentro, todos os concentrados de hemácias já são desleucocitados por filtração. Quanto à irradiação e à lavagem do hemocomponente, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

esquema que incluiu fludarabina

Resolução. O hemocomponente já desleucocitado é o que faz o apressado dispensar tudo: a crença é que o filtro de leucócitos previne a doença do enxerto contra o hospedeiro transfusional. Os filtros, porém, deixam linfócitos T viáveis em número suficiente para causá-la, e só a irradiação (25 Gy) os inativa. Os análogos de purina (fludarabina, cladribina, pentostatina) e a bendamustina causam linfopenia T profunda e duradoura, e a diretriz britânica indica componentes irradiados por tempo indeterminado após o uso deles. A doença do enxerto contra o hospedeiro transfusional é quase sempre fatal, por isso a irradiação não se dispensa. A lavagem, que remove o plasma, é para reação alérgica grave de repetição ou deficiência de IgA com anafilaxia, e não acrescenta nada aqui: indicá-la seria fazer a mais.

A) Indicada / indicada
Errada. A irradiação está certa, mas a lavagem é para anafilaxia ou deficiência de IgA, que ele não tem; seria procedimento a mais.

B) Indicada / dispensável CORRETA
Correta. Após análogo de purina, irradiar (prevenção de DECH transfusional, por tempo indeterminado); lavar não tem indicação.

C) Dispensável / indicada
Errada. Erra as duas metades: lavagem não remove linfócitos T de modo confiável nem tem indicação aqui, e sem irradiação o risco de DECH persiste.

D) Dispensável / dispensável ARMADILHA
Errada. É a armadilha: a desleucocitação por filtro não previne DECH transfusional, e quem usou fludarabina precisa de componente irradiado.

Para levar. Fludarabina, cladribina, bendamustina, transplante de células-tronco e linfoma de Hodgkin pedem componente irradiado; desleucocitar não substitui irradiar, e lavar é para anafilaxia e deficiência de IgA.

BSH 2020 guidelines on the use of irradiated blood components (Foukaneli et al.); Ministério da Saúde, Guia para uso de hemocomponentes (2ª edição, 2015).

---

71 Pneumologia · Nódulo pulmonar sólido de alta probabilidade com PET captante: ressecção sem biópsia prévia

Rótulo verdadeiro **Gabarito C**

Homem de 66 anos, ex-tabagista (45 maços-ano, parou há 6 anos), com DPOC leve e tuberculose pulmonar tratada há 30 anos, faz TC de tórax de rastreio. Há nódulo sólido de 24 mm, espiculado, no segmento anterior do lobo superior direito, ausente em TC de 2 anos atrás, e estrias fibróticas apicais bilaterais antigas. PET-CT: captação no nódulo (SUV máximo 7,8), sem captação em linfonodos hilares, mediastinais ou à distância; linfonodos mediastinais menores que 1 cm na TC. Baciloscopia e teste rápido molecular no escarro negativos. Espirometria: VEF1 78% do previsto; DLCO 72%. Sem dispneia, ECOG 0. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

ausente em TC de 2 anos atrás

Resolução. A tuberculose antiga é verdadeira e lembra que granuloma também capta no PET, o que empurra para confirmar antes de operar ou para esperar. O que decide é a probabilidade pré-teste: nódulo sólido novo (ausente há 2 anos), espiculado, de 24 mm, em lobo superior, em ex-tabagista de 45 maços-ano com DPOC, e ainda captante, tem probabilidade de malignidade muito alta. Em paciente operável com doença aparentemente localizada, a ressecção é diagnóstica e terapêutica ao mesmo tempo, e biópsia prévia só atrasa: um resultado negativo não mudaria a indicação. Tumor periférico de até 3 cm com mediastino negativo na TC e no PET dispensa estadiamento mediastinal invasivo. Função pulmonar e estado funcional permitem a cirurgia.

A) Biópsia transtorácica guiada por TC ARMADILHA

Errada, e é a armadilha. Biópsia percutânea é para probabilidade intermediária, para quem não vai operar ou antes de radioterapia estereotáxica; aqui a probabilidade é alta e o negativo não mudaria a conduta.

B) Ecobroncoscopia com punção mediastinal

Errada. EBUS com punção é o estadiamento mediastinal invasivo de tumor central, maior que 3 cm, ou com linfonodo aumentado ou captante; nenhum desses critérios está presente.

C) Ressecção anatômica sem biópsia prévia CORRETA

Correta. Nódulo novo, espiculado, de 24 mm e captante em ex-tabagista operável: ressecção anatômica com amostragem linfonodal, sem biópsia prévia.

D) TC de tórax de controle em 3 meses

Errada. Controle tomográfico é para nódulo de baixa probabilidade ou subsólido; nódulo sólido que surgiu em 2 anos e capta no PET não se observa.

Para levar. Nódulo sólido de alta probabilidade em paciente operável vai direto à ressecção; biópsia antes só se a probabilidade for intermediária ou se o paciente não for candidato à cirurgia.

ACCP 2013 (avaliação do nódulo pulmonar e estadiamento do câncer de pulmão); BTS 2015 (nódulo pulmonar); ESTS 2014 (estadiamento mediastinal pré-operatório)

---

72 Endocrinologia · Apoplexia hipofisária: hidrocortisona antes da descompressão

Rótulo verdadeiro **Gabarito A**

Homem de 63 anos, hipertenso em losartana, é trazido ao pronto-socorro com cefaleia retro-orbitária súbita e intensa há seis horas, seguida de vômitos e visão dupla. Sem trauma, sem febre. Refere há um ano redução de libido e cansaço, não investigados. Exame: sonolento, mas orientado, PA 88/54 mmHg, FC 112 bpm, T 37,2 °C, ptose palpebral e midríase à direita, hemianopsia bitemporal à confrontação, sem rigidez de nuca. Exames: sódio 127 mEq/L, potássio 4,3 mEq/L, glicemia 68 mg/dL, creatinina 1,2 mg/dL. Tomografia de crânio: massa selar de 2,6 cm com área hiperdensa e extensão suprasselar, sem hemorragia subaracnóidea. Colhido sangue para cortisol, TSH, T4 livre e prolactina. A conduta imediata mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

PA 88/54 mmHg, FC 112 bpm

Resolução. A perda de campo visual e a paralisia do terceiro nervo são o rótulo verdadeiro que puxa para a cirurgia: há massa comprimindo quiasma e seio cavernoso. Mas o que mata nas primeiras horas da apoplexia é a deficiência aguda de ACTH, e o caso a mostra: hipotensão, taquicardia, hiponatremia e glicemia de 68, com libido baixa prévia sugerindo hipopituitarismo antigo. A primeira medida, antes de qualquer imagem adicional ou de levar ao centro cirúrgico, é hidrocortisona 100 mg venosa e depois 50 mg a cada 6 horas, sem esperar o cortisol colhido. A descompressão é considerada depois da estabilização, para déficit visual grave ou progressivo ou rebaixamento de consciência, e muitos pacientes evoluem bem com conduta conservadora.

A) Hidrocortisona venosa em dose de estresse CORRETA
Correta. Hipotensão, hiponatremia e hipoglicemia na apoplexia são deficiência de cortisol até prova em contrário: hidrocortisona venosa imediata.

B) Descompressão transesfenoidal de urgência ARMADILHA
Errada. Seria discutida depois da estabilização, para déficit visual grave ou piora neurológica; operar com insuficiência adrenal não tratada arrisca colapso.

C) Angiotomografia arterial cerebral
Errada. Seria o exame de cefaleia súbita com terceiro nervo sem massa selar (aneurisma de comunicante posterior); aqui a tomografia já mostrou a causa.

D) Cabergolina em dose alta
Errada. Agonista dopaminérgico é tratamento de prolactinoma, e o tipo do adenoma nem é conhecido; não corrige a urgência.

Para levar. Na apoplexia hipofisária, a primeira conduta é hidrocortisona venosa em dose de estresse; a massa espera, o cortisol não.

UK Guidelines for the management of pituitary apoplexy (Rajasekaran et al., Clin Endocrinol 2011); Endocrine Society, Hormonal Replacement in Hypopituitarism 2016.

---

73 Infectologia · Candidemia em nutrição parenteral com urocultura positiva: o tempo diferencial de positividade aponta o cateter

Limiar **Gabarito B**

Mulher de 63 anos, no 18º dia de pós-operatório de colectomia por adenocarcinoma de cólon complicada por fístula enterocutânea, recebe nutrição parenteral total por cateter venoso central em subclávia direita há 14 dias e tem sonda vesical de demora. Há 2 dias tem febre de até 38,7 °C com calafrios. Exame: FC 108 bpm, PA 112 x 70 mmHg, óstio do cateter sem hiperemia ou secreção, abdome sem sinais de peritonite, débito da fístula estável. Radiografia de tórax: atelectasia laminar em base esquerda. EAS com 40 leucócitos por campo e urocultura com mais de 100.000 UFC/mL de Candida sp. TC de abdome sem coleções. Foram colhidas ao mesmo tempo, com o mesmo volume, uma hemocultura pelo cateter e outra por punção periférica, e ambas cresceram Candida parapsilosis: a do cateter positivou com 9 horas de incubação e a periférica, com 13 horas. O diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

a do cateter positivou com 9 horas de incubação e a periférica, com 13 horas

Resolução. A urocultura com Candida e a sonda vesical são reais e oferecem um foco pronto, e a cirurgia abdominal com fístula oferece outro. Mas candidúria em paciente sondado é quase sempre colonização, e a espécie do sangue é a C. parapsilosis, que vive na pele e forma biofilme em cateter e em nutrição parenteral. O dado que decide é o tempo diferencial de positividade: com amostras colhidas ao mesmo tempo e com o mesmo volume, a do cateter positivar 2 horas ou mais antes da periférica indica que a carga de microrganismos está no dispositivo. Aqui a diferença é de 4 horas, e o óstio limpo não afasta a infecção, que nos cateteres de longa permanência é intraluminal. A conduta é retirar o cateter, iniciar antifúngico sistêmico, repetir hemoculturas até a negativação, fazer fundoscopia e tratar por 14 dias a partir da primeira hemocultura negativa.

A) Candidíase invasiva de origem abdominal
Errada. Seria pensada com coleção, peritonite ou perfuração intestinal; a TC sem coleções, a espécie de pele e o tempo diferencial apontam o cateter.

B) Infecção de corrente sanguínea pelo cateter CORRETA
Correta. A hemocultura do cateter positivou 4 horas antes da periférica (limiar de 2 horas), com C. parapsilosis em paciente sob nutrição parenteral.

C) Candidemia de foco urinário ARMADILHA
Errada. É a armadilha: seria o foco com obstrução ou manipulação urinária e a mesma espécie na urina e no sangue; candidúria em paciente sondado costuma ser colonização, e o tempo diferencial aponta o cateter.

D) Colonização do cateter, sem infecção
Errada. Colonização seria cultura da ponta positiva com sangue periférico negativo; aqui a hemocultura periférica também cresceu, o que é infecção.

Para levar. Hemoculturas pareadas: se a do cateter positiva 2 horas ou mais antes da periférica, o foco é o cateter, mesmo com óstio limpo e outro foco plausível; candidúria em paciente sondado é colonização até prova em contrário.

IDSA Clinical Practice Guidelines for the Diagnosis and Management of Intravascular Catheter-Related Infection (2009); IDSA Clinical Practice Guideline for the Management of Candidiasis (2016).

---

74 Hepatologia · Peritonite bacteriana secundária no cirrótico: critérios de Runyon

Rótulo verdadeiro **Gabarito C**

Homem de 61 anos, com cirrose por vírus C (Child-Pugh B) e ascite em uso de diuréticos, procura a emergência com dor abdominal difusa e febre há 2 dias. Nega sangramento. Exame: Tax 38,4 °C, FC 108 bpm, PA 104 × 64 mmHg, ascite moderada, abdome doloroso difusamente, sem defesa localizada. Exames: leucócitos 16.200/mm³, creatinina 1,3 mg/dL, glicose sérica 110 mg/dL, DHL sérica 210 U/L (referência até 250 U/L). Paracentese: líquido turvo, 6.800 células/mm³ com 88% de polimorfonucleares, proteína total 2,6 g/dL, glicose 22 mg/dL, DHL 480 U/L; Gram com bacilos gram-negativos, cocos gram-positivos e bacilos gram-positivos. O diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE
glicose 22 mg/dL, DHL 480 U/L

Resolução. Cirrótico com ascite, febre e neutrófilos acima de 250 no líquido monta peritonite bacteriana espontânea na cabeça de quem lê, e o tratamento seria ceftriaxona e albumina. Mas o líquido traz os três sinais de perfuração ou foco intra-abdominal: proteína total acima de 1 g/dL, glicose abaixo de 50 mg/dL e DHL do líquido acima do limite superior sérico (critérios de Runyon; dois ou mais bastam), além de Gram polimicrobiano e contagem de milhares de neutrófilos. A peritonite espontânea é monomicrobiana e o líquido costuma ter proteína baixa, porque a baixa opsonização é o que a permite. O próximo passo é TC de abdome e avaliação cirúrgica, com antibiótico que cubra anaeróbios.

A) Ascite neutrocítica cultura-negativa
Errada. É PMN acima de 250 com cultura negativa em quadro de peritonite espontânea; o Gram com três morfologias já a afasta.

B) Bacterascite monomicrobiana
Errada. Bacterascite é cultura positiva com PMN abaixo de 250; aqui são milhares de neutrófilos.

C) Peritonite bacteriana secundária CORRETA
Correta. Proteína de 2,6 g/dL, glicose de 22 mg/dL, DHL de 480 U/L e Gram polimicrobiano: peritonite secundária, que pede TC e cirurgião.

D) Peritonite bacteriana espontânea ARMADILHA
Errada. É a isca do rótulo: a peritonite espontânea tem PMN acima de 250, mas Gram de um só germe e líquido sem critérios de Runyon; aqui há três critérios e flora mista.

Para levar. No cirrótico com ascite infectada, dois critérios de Runyon (proteína acima de 1 g/dL, glicose abaixo de 50 mg/dL, DHL acima do normal sérico) ou Gram polimicrobiano mandam procurar foco cirúrgico.

AASLD Practice Guidance on ascites, SBP and hepatorenal syndrome (2021); EASL Clinical Practice Guidelines on decompensated cirrhosis (2018)

---

75 Reumatologia · Nefrite lúpica classe II com proteinúria abaixo de 1 g: não induzir imunossupressão

Omissão **Gabarito C**

Mulher de 27 anos tem lúpus eritematoso sistêmico há 3 anos (artrite, lúpus cutâneo subagudo, anti-DNA nativo reagente), em uso de hidroxicloroquina 400 mg/dia, com artrite e pele controladas há 1 ano. Vem à consulta de rotina, sem queixas. PA 118 × 74 mmHg, sem edema. Exames: creatinina 0,7 mg/dL, EAS com 12 hemácias por campo, dismórficas, sem cilindros, relação proteína/creatinina urinária de 0,7 g/g confirmada em segunda amostra, C3 78 mg/dL (VR 90 a 180), C4 9 mg/dL (VR 10 a 40), anti-DNA nativo 1:80. Biópsia renal: 24 glomérulos com hipercelularidade e expansão mesangiais, imunofluorescência com depósitos mesangiais de IgG, IgA, IgM, C3 e C1q, microscopia eletrônica sem depósitos subendoteliais ou subepiteliais, sem crescentes, necrose ou proliferação endocapilar. Além de manter a hidroxicloroquina, a conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

microscopia eletrônica sem depósitos subendoteliais ou subepiteliais

Resolução. Hematúria dismórfica, proteinúria, complemento baixo e anti-DNA reagente formam o conjunto que dispara o reflexo da indução com micofenolato e corticoide. Mas a biópsia decide, e ela mostra classe II pura: lesão só mesangial, sem depósitos subendoteliais (que definiriam classe III ou IV) e sem subepiteliais

(classe V). Na classe II, o rim não pede imunossupressão própria: o tratamento segue as manifestações extrarrenais, que estão controladas, e a proteinúria é tratada com IECA ou BRA e controle pressórico. Imunossupressão só entraria com proteinúria persistente acima de 1 g/dia apesar do bloqueio do eixo (EULAR) ou com proteinúria nefrótica, em que o KDIGO manda procurar podocitopatia lúpica. Hidroxicloroquina mantida, monitorização de proteinúria, sedimento e complemento, e nova biópsia se houver transformação de classe.

A) Pulso de metilprednisolona e ciclofosfamida
Errada. Seria opção em classe III ou IV grave, com crescentes ou perda rápida de função; aqui a função é normal e a lesão é mesangial.

B) Micofenolato e prednisona em dose alta ARMADILHA
Errada. É indução de classe III ou IV, ou de classe V nefrótica; aqui a microscopia eletrônica exclui depósitos subendoteliais e subepiteliais.

C) Bloqueio do eixo renina-angiotensina e seguimento CORRETA
Correta. Classe II com proteinúria abaixo de 1 g e doença extrarrenal controlada pede antiproteinúrico e vigilância, sem imunossupressão renal.

D) Belimumabe associado a micofenolato
Errada. A terapia tripla com belimumabe é para nefrite proliferativa ou membranosa ativa; na classe II é tratamento a mais.

Para levar. Na nefrite lúpica, a classe da biópsia manda, não o complemento: classe II recebe antiproteinúrico e hidroxicloroquina; indução é para III, IV e V.

KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Management of Lupus Nephritis; EULAR/ERA-EDTA 2019 recommendations for lupus nephritis.

---

76 Hematologia · Hiperferritinemia metabólica em flebotomia: saturação que despenca e anemia mandam suspender, não a ferritina

Omissão **Gabarito B**

Homem de 55 anos, com IMC de 33 kg/m², diabetes tipo 2 em metformina, hipertrigliceridemia e esteatose hepática, não bebe. Em outro serviço, por ferritina de 1.240 ng/mL, iniciou flebotomias semanais de 450 mL há 6 semanas, com a meta escrita de "retirar sangue até a ferritina chegar a 50". Não foi feita pesquisa genética. Exames antes da primeira sessão: hemoglobina 15,6 g/dL, saturação de transferrina 38%. Desde a 4ª sessão refere cansaço e tontura ao levantar. Exames de hoje, após 6 sessões: hemoglobina 11,9 g/dL, VCM 83 fL, ferritina 860 ng/mL, saturação de transferrina 12%, ALT 58 U/L, PCR 0,8 mg/dL. Quanto às flebotomias, a conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

saturação de transferrina 12%

Resolução. A ferritina ainda em 860, longe da meta escrita, é o número que empurra para continuar, e a meta de 50 a 100 é a da hemocromatose. O ponto de partida já negava sobrecarga: saturação de transferrina de 38%, abaixo de 45%, num obeso diabético com esteatose, é hiperferritinemia metabólica, em que a ferritina reflete resistência insulínica e inflamação hepática, e não ferro estocado. As 6 sessões funcionaram como teste terapêutico: na sobrecarga verdadeira, a retirada de cerca de 1,3 g de ferro (cerca de 200 a 250 mg por

sessão) mal mexe na saturação, que segue alta enquanto houver estoque para mobilizar; aqui a saturação despencou para 12% e a hemoglobina caiu quase 4 g/dL, com VCM em queda, sinal de eritropoese com falta de ferro disponível. Continuar, ou só espaçar, produz anemia ferropriva sem benefício hepático, e quelante não tem lugar sem sobrecarga. A conduta é suspender e tratar o metabolismo (peso, glicemia, triglicérides), seguindo o fígado pelo FIB-4.

A) Trocar por quelante oral de ferro
Errada. Quelante oral serve à sobrecarga transfusional ou a quem não tolera flebotomia com sobrecarga comprovada; não há ferro em excesso para quelar.

B) Suspender as flebotomias CORRETA
Correta. Saturação inicial de 38% e queda para 12% com anemia após poucas sessões provam que não havia sobrecarga a retirar: suspender.

C) Espaçar para uma sessão mensal
Errada. Espaçar é a fase de manutenção da hemocromatose depois de atingida a meta; sem sobrecarga, qualquer nova sessão só aprofunda a ferropenia.

D) Manter até ferritina de 50 a 100 ARMADILHA
Errada. É a armadilha: a meta de ferritina de 50 a 100 é da hemocromatose com sobrecarga comprovada; aqui a ferritina não mede estoque e a saturação de 12% já mostra falta de ferro.

Para levar. Hiperferritinemia com saturação abaixo de 45% não é sobrecarga de ferro: flebotomia não se indica, e se já começou, saturação despencando com anemia manda suspender, mesmo com ferritina alta.

EASL Clinical Practice Guidelines on haemochromatosis 2022; consenso internacional sobre hiperferritinemia metabólica (Valenti et al., Nat Rev Endocrinol 2023); EASL-EASD-EASO 2024 para MASLD.

---

77 Neurologia · Delirium por anticolinérgico em idosa com Alzheimer leve: a droga nova, não a demência

Rótulo verdadeiro **Gabarito D**

Mulher de 81 anos, com doença de Alzheimer leve diagnosticada há 2 anos, em uso de donepezila 10 mg/dia, mora com a filha e era independente para banho e alimentação. Há 6 dias, a urologista prescreveu oxibutinina 5 mg três vezes ao dia por urgência miccional. Há 3 dias está sonolenta durante o dia e agitada à noite, quando diz ver pessoas estranhas no quarto; alterna momentos de lucidez com outros em que não reconhece a filha e não consegue manter a atenção para dizer os meses do ano de trás para frente. Exame: Tax 36,6 °C, PA 128/76 mmHg, mucosas secas, sem rigidez, tremor ou déficit focal. Glicemia 112 mg/dL, sódio 137 mEq/L, hemograma e EAS normais, sem resíduo vesical na ultrassonografia após micção. A causa mais provável do quadro atual é:

O DADO QUE DECIDE

prescreveu oxibutinina 5 mg três vezes ao dia

Resolução. O rótulo verdadeiro é a doença de Alzheimer, que puxa para progressão. Mas a demência avança em meses, não em 3 dias, e não flutua de hora em hora. Início agudo, flutuação, desatenção (não consegue dizer os meses ao contrário) e alteração do nível de consciência montam delirium, e a demência é o principal fator predisponente, não a explicação. O precipitante está na segunda linha: oxibutinina, anticolinérgico de alta carga que atravessa a barreira, iniciada 3 dias antes do quadro, em paciente cuja cognição depende de

um inibidor da colinesterase que a oxibutinina antagoniza. As alucinações visuais noturnas atraem para demência com corpos de Lewy, mas são frequentes no delirium e, na DCL, acompanham a doença desde o início, com parkinsonismo e distúrbio do sono REM, não surgem em 3 dias após uma droga. Mucosas secas reforçam o efeito anticolinérgico, e infecção, distúrbio metabólico e retenção urinária foram afastados. A conduta é suspender a oxibutinina e manejar sem antipsicótico; se a urgência precisar de tratamento, mirabegrona.

A) Progressão da doença de Alzheimer ARMADILHA
Errada, é a armadilha. O Alzheimer é verdadeiro e predispõe, mas progride em meses e não produz flutuação e desatenção instaladas em 3 dias.

B) Demência com corpos de Lewy
Errada. Na DCL há flutuação e alucinação visual, mas elas acompanham a doença desde o início, com parkinsonismo e distúrbio comportamental do sono REM; não surgem em 3 dias após uma droga nova numa paciente com Alzheimer sem esses sinais.

C) Infarto lacunar talâmico
Errada. Infarto talâmico causa confusão súbita, mas com déficit sensitivo ou de olhar e sem a relação com a droga; o exame não tem déficit focal.

D) Delirium por efeito anticolinérgico CORRETA
Correta. Quadro agudo e flutuante com desatenção, iniciado 3 dias após oxibutinina, com mucosas secas e o resto da investigação normal.

Para levar. Piora em dias numa pessoa com demência é delirium até prova em contrário: procurar a droga nova (anticolinérgico, benzodiazepínico, opioide) antes de chamar de progressão.

Critérios de Beers AGS 2023; NICE CG103 (delirium, atualização 2023); DSM-5-TR.

---

78 Pneumologia · Curva fluxo-volume: obstrução variável extratorácica após tireoidectomia, rotulada como asma

Rótulo verdadeiro **Gabarito B**

Mulher de 46 anos, com diagnóstico de asma feito há 8 meses num pronto-atendimento, procura o ambulatório porque a falta de ar não melhorou com budesonida-formoterol em dose média, usado com técnica correta. Refere chiado e ruído alto na inspiração ao subir escadas, rouquidão discreta e engasgos com líquidos desde uma tireoidectomia total por bócio multinodular, há 1 ano. Nega tosse noturna, rinite e piora com poeira ou frio. Eosinófilos 90/mm³. Exame: FR 18 irpm, SpO2 97% em ar ambiente, ruído inspiratório audível sobre a região cervical, pulmões sem sibilos expiratórios. Radiografia de tórax normal. Na curva fluxo-volume, o achado esperado é:

> O DADO QUE DECIDE
> *ruído alto na inspiração ao subir escadas, rouquidão discreta e engasgos com líquidos desde uma tireoidectomia total*

Resolução. O rótulo de asma é verdadeiro no papel, e quem aceita o diagnóstico espera a concavidade expiratória da obstrução de pequenas vias. Mas não há resposta ao tratamento, eosinófilos são baixos, não há sibilo expiratório e o ruído é inspiratório e cervical, começando depois de uma tireoidectomia com rouquidão e disfagia: lesão dos nervos laríngeos recorrentes, com paresia de pregas vocais. É obstrução

variável extratorácica: na inspiração a pressão intraluminal fica abaixo da atmosférica e a via aérea extratorácica colaba, achatando só a alça inspiratória, e na expiração a pressão positiva abre a luz, preservando a alça expiratória. Obstrução fixa (estenose traqueal pós-intubação, tumor que não muda com a pressão) achataria as duas alças, e a variável intratorácica (traqueomalácia, tumor de traqueia distal) achataria só a expiratória.

A) Achatamento das alças inspiratória e expiratória
Errada. É a curva da obstrução fixa de via aérea central (estenose pós-intubação, tumor rígido); a paresia de pregas vocais muda de calibre com o ciclo respiratório.

B) Achatamento isolado da alça inspiratória CORRETA
Correta. Paresia de pregas vocais após tireoidectomia é obstrução variável extratorácica: platô só na alça inspiratória, com relação fluxo expiratório/inspiratório a 50% da CV acima de 1.

C) Achatamento isolado da alça expiratória
Errada. É a obstrução variável intratorácica (traqueomalácia, tumor de traqueia distal), em que a compressão ocorre na expiração; a lesão aqui é laríngea, fora do tórax.

D) Concavidade da alça expiratória ARMADILHA
Errada, e é a armadilha. Concavidade expiratória é a obstrução de pequenas vias da asma e da DPOC; o rótulo de asma não se sustenta sem sibilo expiratório, sem resposta ao tratamento e com estridor inspiratório.

Para levar. Estridor inspiratório que não responde a broncodilatador é via aérea alta: extratorácica variável achata a alça inspiratória, intratorácica variável achata a expiratória e a fixa achata as duas.

ATS/ERS 2022 (interpretação de testes de função pulmonar); Diretrizes SBPT para testes de função pulmonar

---

79 Cardiologia · Dislipidemia de muito alto risco fora da meta: escalonamento com ezetimiba antes do iPCSK9

Omissão **Gabarito A**

Homem de 58 anos, hipertenso e ex-tabagista, teve infarto sem supradesnivelamento de ST há 5 meses, tratado com angioplastia da descendente anterior. Não é diabético, não tem doença arterial periférica nem cerebrovascular e não teve outro evento. Usa rosuvastatina 40 mg ao dia desde a alta, com boa adesão e sem mialgia, e nunca usou outro hipolipemiante. Perfil lipídico: colesterol total 136 mg/dL, HDL 40 mg/dL, triglicerídeos 160 mg/dL, LDL 64 mg/dL (antes da estatina, 158 mg/dL). CK e transaminases normais, TFG 74 mL/min. A conduta mais adequada para o LDL neste momento é:

O DADO QUE DECIDE

LDL 64 mg/dL (antes da estatina, 158 mg/dL)

Resolução. Infarto prévio é risco muito alto, com meta de LDL abaixo de 50 mg/dL pela SBC (abaixo de 55 mg/dL pela ESC) e redução de pelo menos 50%. A redução já passou de 50% (158 para 64), mas o LDL segue acima da meta, e a estatina já está na dose máxima de alta potência. Faltam cerca de 22% de redução, que é o que a ezetimiba entrega (20 a 25%), e ela é o degrau seguinte do escalonamento, barata e oral. O inibidor de PCSK9 fica para quem continua fora da meta com estatina máxima mais ezetimiba, ou para o risco extremo com distância grande da meta; pulá-lo para cá é o passo a mais. Trocar de estatina não acrescenta potência, e manter aceita LDL fora da meta num paciente pós-infarto.

A) Associar ezetimiba 10 mg CORRETA

Correta. Estatina de alta potência na dose máxima com LDL 22% acima da meta: ezetimiba fecha a distância e é o degrau seguinte.

B) Associar inibidor de PCSK9 ARMADILHA

Errada, e é a armadilha. O iPCSK9 é o terceiro degrau, para quem segue fora da meta com estatina máxima e ezetimiba, ou para risco extremo muito distante da meta.

C) Trocar por atorvastatina 80 mg

Errada. Rosuvastatina 40 mg já é a estatina mais potente; trocar por atorvastatina 80 mg não reduz mais o LDL.

D) Manter e repetir em 6 meses

Errada. Seria aceitável se o LDL estivesse abaixo de 50 mg/dL; com 64 mg/dL após infarto, o risco residual pede escalonar.

Para levar. Escalonamento do LDL: estatina de alta potência na dose máxima, depois ezetimiba, depois iPCSK9. A ezetimiba reduz cerca de 20 a 25%: se a distância até a meta cabe nisso, ela basta.

Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose (SBC 2017); ESC/EAS 2019 (dyslipidaemias)

80

Nefrologia · Prevenção de lesão renal por contraste iodado intravenoso · limiar de TFGe para profilaxia

Limiar **Gabarito D**

Homem de 70 anos, com diabetes tipo 2 em uso de metformina e TFGe estável de 48 mL/min/1,73 m², sem lesão renal aguda atual, fará tomografia de abdome com contraste iodado intravenoso para estadiamento ambulatorial de neoplasia de cólon. Para prevenção de lesão renal associada ao contraste, a conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

TFGe estável de 48 mL/min/1,73 m²

Resolução. Diabetes, metformina e creatinina acima do normal acendem o alerta e levam à hidratação venosa no automático. Mas o risco de lesão renal pelo contraste iodado intravenoso é bem menor do que se acreditava, e o consenso do American College of Radiology com a National Kidney Foundation (2020) fixa o limiar: profilaxia com hidratação isotônica é indicada com TFGe abaixo de 30 mL/min/1,73 m² (fora de diálise) ou com lesão renal aguda; entre 30 e 44 é individualizada; com 45 ou mais não é indicada, mesmo no diabético. Bicarbonato e N-acetilcisteína não foram superiores à salina no PRESERVE e não são recomendados. A metformina também não precisa ser suspensa com TFGe acima de 30 e sem lesão aguda.

A) Bicarbonato de sódio intravenoso

Errada. O bicarbonato não reduziu lesão renal, diálise ou morte em comparação à salina no PRESERVE e não tem papel em nenhuma faixa de TFGe.

B) N-acetilcisteína oral

Errada. A N-acetilcisteína também foi negativa no PRESERVE e foi abandonada como profilaxia.

C) Hidratação venosa com SF 0,9% ARMADILHA

Errada, é a armadilha. Seria a resposta com TFGe abaixo de 30 ou lesão renal aguda em curso; com 48 estável não há benefício, e a hidratação só acrescenta risco de sobrecarga.

D) Nenhuma profilaxia específica CORRETA

Correta. Com TFGe de 45 ou mais, estável e sem lesão aguda, nenhuma profilaxia específica é indicada antes do contraste intravenoso.

Para levar. Contraste iodado intravenoso: profilaxia com salina isotônica só com TFGe abaixo de 30 ou lesão renal aguda; de 30 a 44, individualizar; 45 ou mais, nada. Bicarbonato e N-acetilcisteína não servem.

ACR e National Kidney Foundation, Consensus Statement on IV iodinated contrast in kidney disease (2020); PRESERVE (NEJM 2018); ACR Manual on Contrast Media (2024).